



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN AGUSTUS
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI).....	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	6
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	7
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	21
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik.....	21
3.3.2 Rawat Inap.....	23
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	29
3.3.4 High Care Unit (HCU)	30
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	31
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO).....	32
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	34
3.4.1 Instalasi Farmasi	34
3.4.2 Laboratorium.....	51
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	54
3.4.4 Radiologi	60
3.4.5 Gizi	65
3.4.6 CSSD - Laundry	77
3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan.....	83
3.5.1 SDM	83
3.5.2 IPSRS.....	94
3.5.3 Security.....	102
3.5.4 Parkir	104
3.5.5 Humas Marketing	105
3.5.6 Penjaminan	111
3.5.7 PIPP – MOD - MPP.....	112
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	120
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	121
3.5.10 IT - SIMRS	122
3.6 Komite dan Tim	123
3.6.1 Komite Mutu.....	123
3.6.2 Komite PPI.....	176
3.6.3 Tim PKRS	191
3.6.4 Tim Prognas.....	193
3.6.5 Tim PPRA	234
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	239
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	241
3.8 Profil SDM	253
Bab IV Kesimpulan dan Saran	259
Bab V Penutup	260
Lampiran	261

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Agustus Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



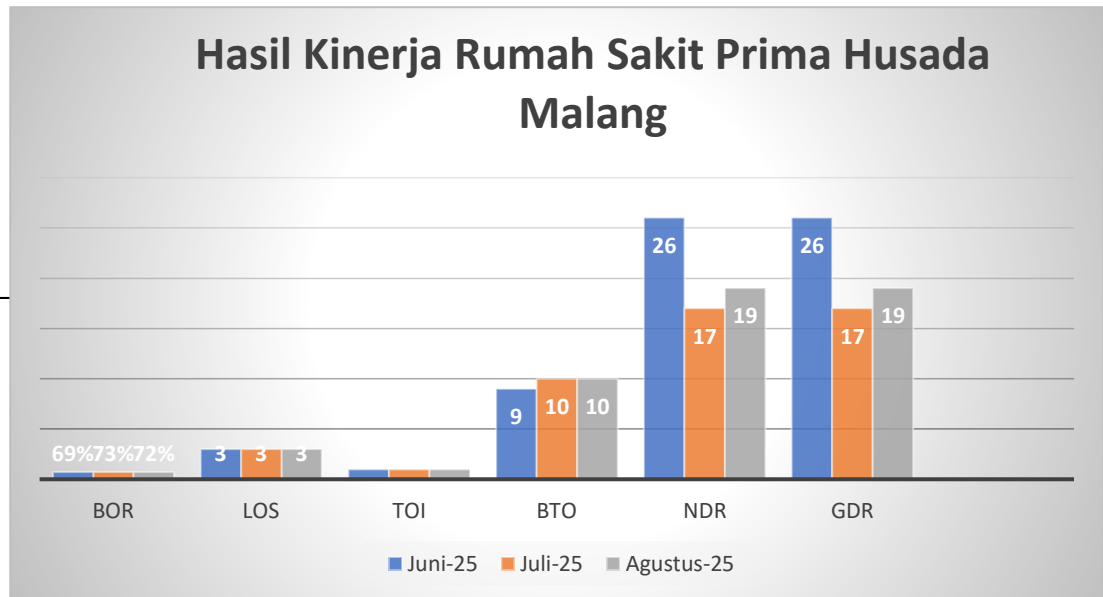
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	JUNI	JULI	AGUSTUS
BOR	69%	73%	72%
LOS	3 hari	3 hari	3 hari
TOI	1 hari	1 hari	1 hari
BTO	9 kali	10 kali	10 kali

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Masalah :

- LOS terlalu rendah (3 hari)** → indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:
 - Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
 - Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
 - Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.
- BTO tinggi** → mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.
- BOR fluktuatif** walaupun masih dalam batas ideal → perlu perhatian agar tetap stabil dan tidak menurun di bawah standar.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Untuk BOR:

Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.

2. Untuk LOS:

- a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
- b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.

3. Untuk TOI:

Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.

4. Untuk BTO:

- a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
- b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
- c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

Analisa

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

- a) Juni: 69% → Juli naik jadi 73% → Agustus sedikit turun ke 72%.
- b) Standar ideal BOR menurut Depkes: **60–85%** → artinya masih dalam kategori **baik** dan stabil.

2. LOS (Length of Stay)

- a) Stabil 3 hari setiap bulan.
- b) Standar ideal: **6–9 hari** → LOS rumah sakit **lebih rendah dari standar**, menunjukkan rata-rata pasien pulang lebih cepat.

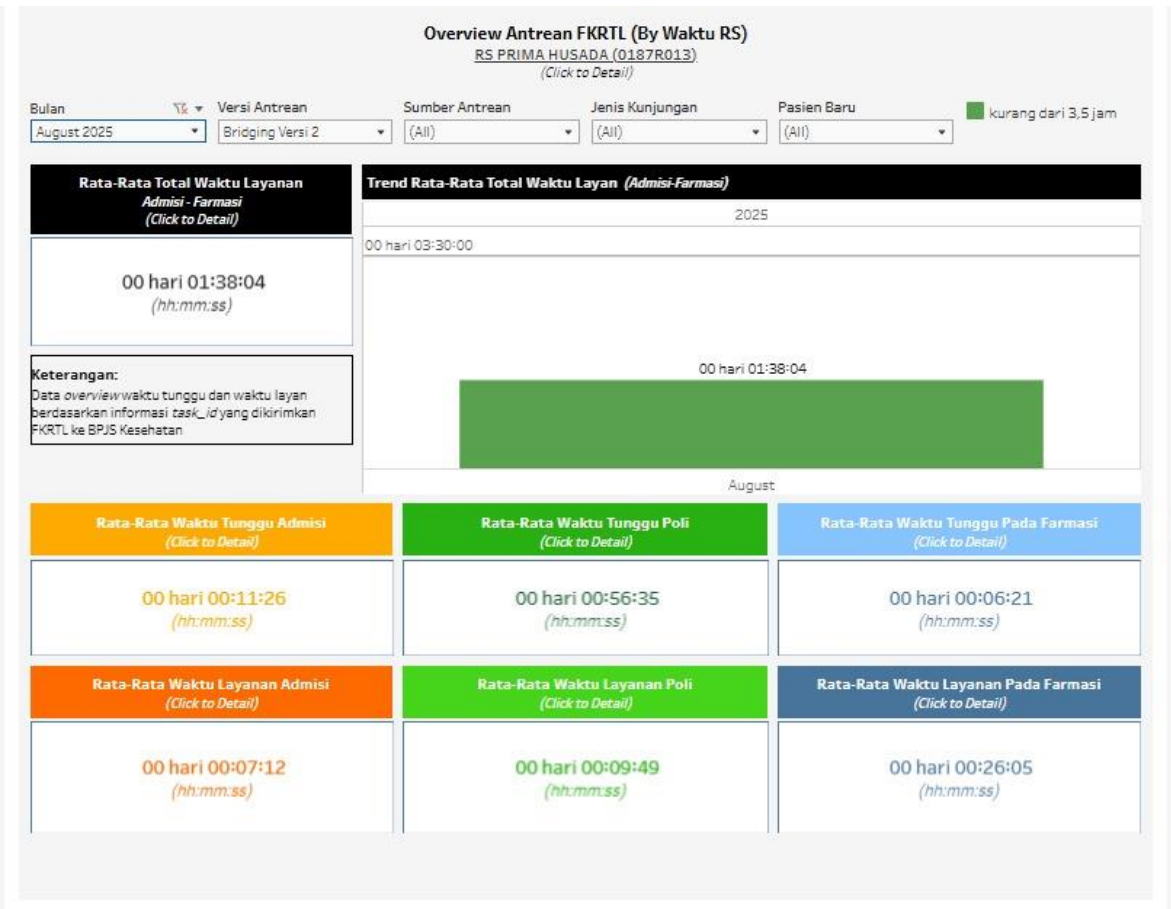
3. TOI (Turn Over Interval)

- a) Stabil 1 hari.
- b) Standar ideal: **1–3 hari** → sesuai standar, menandakan bed tidak lama menganggur setelah ditinggalkan pasien.

4. BTO (Bed Turn Over)

- a) Juni: 9 kali → Juli & Agustus: 10 kali.
- b) Standar ideal: **40–50 kali per tahun (±3–4 kali per bulan)** → angka BTO cukup tinggi (9–10 kali/bulan). Ini menandakan frekuensi pemakaian tempat tidur tinggi dengan lama rawat singkat.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	Jenis	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%	48.20%	
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%	94.36%	

Analisis :
Pemanfaatan antrian online data juli 2025 belum mendapat dari BPJS

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan Dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Penyeragaman penulisan SOAP keperawatan di unit layanan IRNA	1. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan 10 -15 tertinggi 2. Membagi template SOAP keperawatan disertai dengan contoh yang benar 3. Melakukan rapat untuk sosialisasi penulisan di ERM	Implementasi masih kurang, rencana tindaklanjut sosialisasi selain pada rapat koordinasi keperawatan, juga saat supervisi harian karu

2	Komite keperawatan	Mengaktifkan kembali audit mutu keperawatan dengan mengadakan lapsus	1. Membuat lapsus dari pasien meninggal dengan kriteria pasien kompleks 2. Mengundang staf terkait yang menangani pasien di lapsus, diantaranya dokter IGD, DPJP, perawat, bidan, apoteker maupun gizi	Untuk pelaksanaan lapsus dilakukan offline maupun zoom, untuk kendala saat ini masih belum ada.
3	IRJA	Poli Sakura Obgyn – Promo kemerdekaan harga Jasa Dokter Rp. 200.000	1. Menawarkan pada dokter obgyn untuk berkenan tarif promo selama agustus 2025 2. Membuatkan flyer untuk di share di Sosmed 3. Mensosialisasikan pada unit irja, kasir, dan PDF terkait dengan promo tersebut	Pasien obgyn Sakura di bulan agustus 2025 ada 7 pasien.
4	IGD	Fitur Copy WA	Fitur Copy WA memudahkan dokter IGD untuk konsul ke DPJP tanpa harus mengetik ulang	Kendala yang ditemui, ada beberapa pasien yang GCS nya tidak sesuai saat akan konsul, rencana tindak lanjut adalah lapor ke progammer
		Sharing Ilmu kegawatan pada Dokter IGD dan PJ Shift IGD	Untuk meningkatkan skill dan pengetahuan dokter IGD, dokter spesialis bisa memberikan sharing ilmu terkait kegawatan melalui materi zoom maupun offline	Bulan Agustus 2025, ada sharing ilmu terkait tata laksana pasien malnutrisi + anemia pada anak, sharing ilmu terkait CKD oleh dokter Sp.KGH, sharing ilmu pasien ARDS+COPD + Urosepsis dengan melibatkan spesialis urologi, anestesi dan paru.
5	IKO	Pelatihan Perawat instrument magang di Bedah syaraf RSSA	Untuk mengkader dan melatih perawat instrument IKO dengan tidak menggunakan asisten luar operasi bedah saraf, maka DPJP menyarankan untuk ada pelatihan magang bedah saraf ke RSSA. Agar lebih fokus dan banyak kasus terkait bedah saraf, dan legal	Saat ini masih belum ada kendala di lapangan karena magang baru selesai 1 september 2025.

			mendapatkan sertifikat, sehingga perawat tersebut mampu melakukan secara mandiri asisten bedah saraf di RS Prima Husada Malang	
--	--	--	--	--

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 126. e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	Dalam antrian progamer
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock

			sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i>.
		5. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	a. Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara. b. Belum ada penanda resep obat siap dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap di SIMRS. c. Perubahan alur pendaftaran primantara oleh farmasi. a. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.

			sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	
		6. Jasa pengantaran obat	a. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. b. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. c. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis. d. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		8. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.

		9. Pelayanan retriksi obat kronis: penambahan fitur Centang “Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi,	Pengajuan fitur ke progamer.

			verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		11. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat”	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat” untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
		12. Ruang handrub	a. Penambahan ruang handrub pada tanggal 28 mei 2025 untuk pengisian botol cairan handrub yang habis di ruangan agar meminimalkan mikroorganisme. b. Pengisian handrub dilakukan oleh apoteker. c. Sudah dilakukan sosialisasi pengisian botol handrub oleh komite PPI.	Monitoring dan Evaluasi.
		13. Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik	Alur pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik : a. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasien) b. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. c. Order vaksin ke gudang farmasi. d. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. e. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasarkan kwitansi manual sebelumnya. d. Pasien melakukan suntik di poli vaksin.	Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024.	Rencana trial menunggu Programmer PT

			c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaikan sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaikan alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP.	Monitoring dan Evaluasi.

			- Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat	
--	--	--	--	--

			evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu :	
--	--	--	--	--

			- Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan.	
--	--	--	--	--

			Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih di sistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada di depo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada di inputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke	
--	--	--	---	--

			perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
--	--	--	--	--

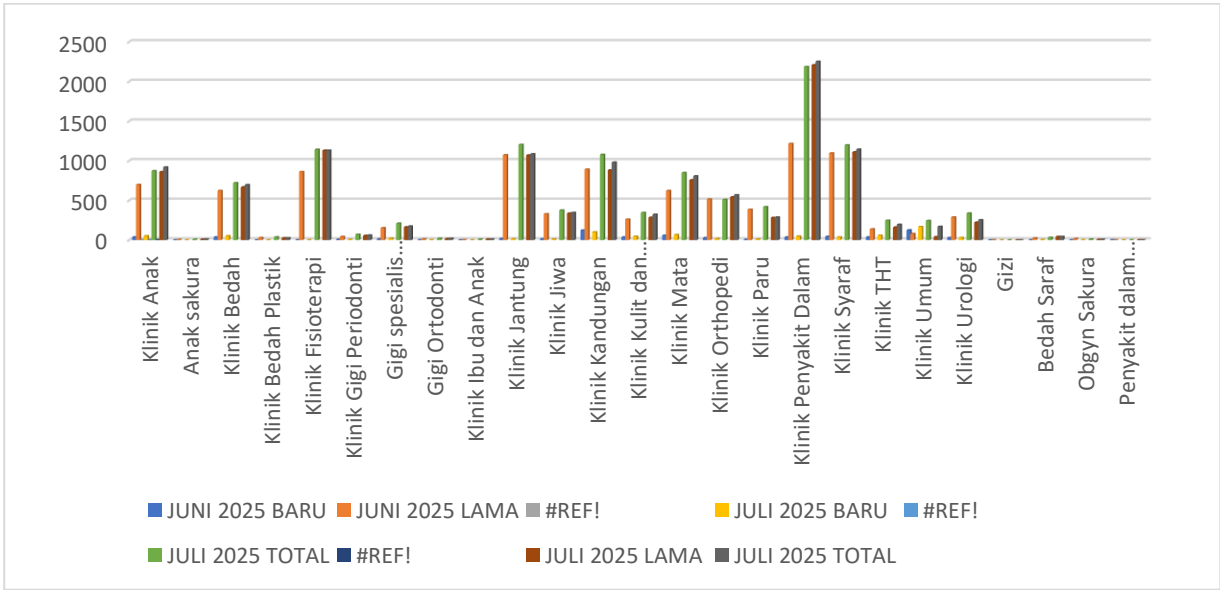
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Poli gizi dan kia belum menjalankan ERM	1. Pelatihan lanjutan dan pendampingan penggunaan ERM untuk Poli Gizi dan KIA. 2. Koordinasi dengan tim IT dan manajemen untuk menyelesaikan kendala teknis. 3. Penjadwalan evaluasi progres bulanan.
		2. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Formulir rekapitulasi kegiatan pelayanan laboratorium pada SIMRS	Rekapitulasi jumlah pemeriksaan lab dengan kriteria jenis kelamin dan hasil nilai rata-rata pemeriksaan lab	Keterlambatan pengisian pada web SIRS online → Follow up ke Programmer untuk update fitur di SIMRS

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	JUNI 2025			JULI 2025			AGUSTUS 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	36	697	733	51	821	872	58	860	918
2	Anak sakura	0	6	6	0	7	7	1	9	10
3	Klinik Bedah	36	622	658	52	668	720	29	667	696
4	Klinik Bedah Plastik	0	29	29	0	37	37	0	26	26
5	Klinik Fisioterapi	1	860	861	1	1142	1143	1	1130	1131
6	Klinik Gigi Periodonti	7	42	49	6	63	69	4	56	60
7	Gigi spesialis pedodontis	14	152	166	20	190	210	11	163	174
8	Gigi Ortodonti	2	13	15	3	16	19	3	16	19
9	Klinik Ibu dan Anak	0	3	3	0	9	9	0	11	11
10	Klinik Jantung	16	1073	1089	14	1189	1.203	15	1070	1.085
11	Klinik Jiwa	13	329	342	10	365	375	8	337	345
12	Klinik Kandungan	122	892	1014	99	978	1.077	99	881	980
13	Klinik Kulit dan Kelamin	36	260	296	45	300	345	38	284	322
14	Klinik Mata	58	622	680	66	783	849	50	756	806
15	Klinik Orthopedi	27	515	542	16	494	510	26	542	568
16	Klinik Paru	6	385	391	10	408	418	7	281	288
17	Klinik Penyakit Dalam	36	1215	1251	47	2139	2186	44	2208	2.252
18	Klinik Syaraf	44	1095	1139	36	1161	1197	34	1110	1.144
19	Klinik THT	36	137	173	58	58	246	35	160	195
20	Klinik Umum	125	78	203	167	77	244	130	39	169
21	Klinik Urologi	29	287	316	28	28	337	31	222	253
22	Gizi	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Bedah Saraf	1	24	25	4	28	32	0	42	42
24	Obgyn Sakura	2	16	18	2	7	9	1	6	7
25	Penyakit dalam sakura	2	2	4	0	7	2	0	1	1
Total		935	9961	10896	1051	12017	13068	914	11463	12377



Analisis :

1. Kunjungan pasien rawat jalan Juli ke Agustus 2025 mengalami penurunan secara keseluruhan sebesar 5%
2. Kunjungan tertinggi : Poli Penyakit Dalam dengan kunjungan 2252

- 3. Kenaikan tertinggi : Poli Anak Sakura dengan persentase 43%
- 4. Penurunan tertinggi : Poli Penyakit Dalam Sakura dengan persentase 50%

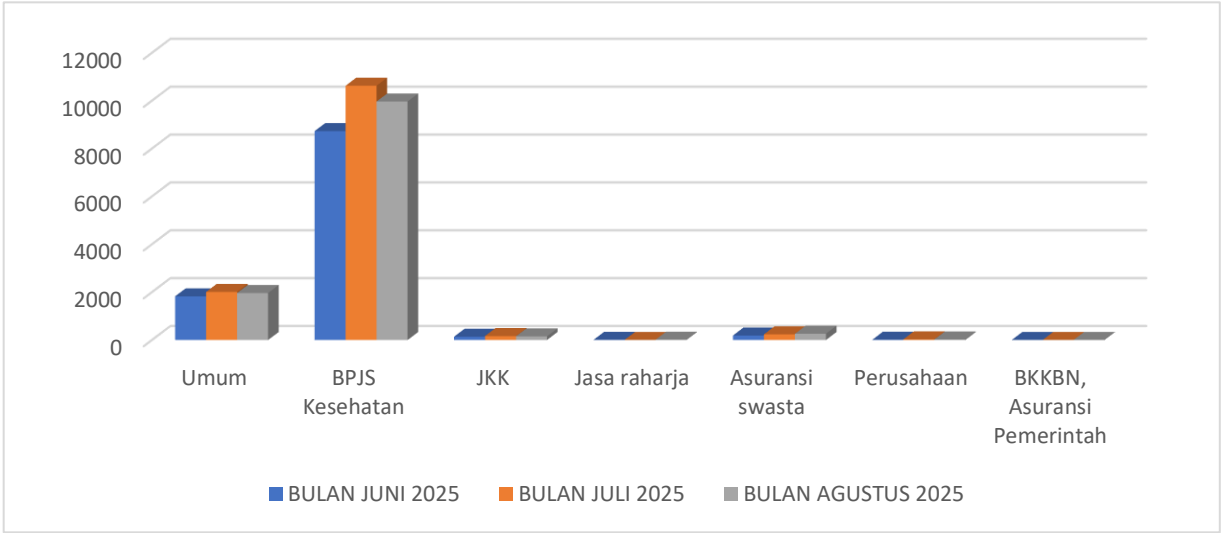
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli Sakura
- 3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN JUNI 2025	%	BULAN JULI 2025	%	BULAN AGUSTUS 2025	%
1	Umum	1825	16,75%	2010	15,38%	1964	15,86%
2	BPJS Kesehatan	8728	80,10%	10625	81,30%	9965	81,51%
3	JKK	136	1,25%	165	1,26%	154	1,24%
4	Jasa raharja	7	0,06%	3	0,02%	10	0,08%
5	Asuransi swasta	188	1,73%	237	1,81%	261	1,22%
6	Perusahaan	12	0,11%	28	0,22%	20	0,21%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Total	10896	100%	13068	100%	12377	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

- 1. Kunjungan dengan cara bayar umum mengalami penurunan 2,34%
- 2. Kunjungan dengan cara bayar BPJS mengalami penurunan 6,62%
- 3. Kunjungan dengan cara bayar BPJS KETENAGAKERJAAN mengalami penurunan 7,14%

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

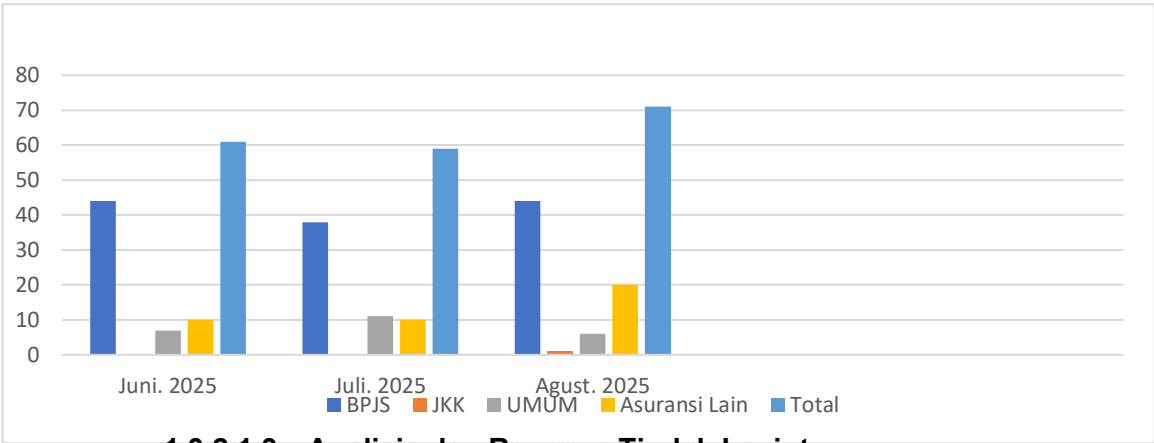
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	44	38	44	↑ 15,78%
2	JKK	0	0	1	↑ 100%
3	Umum	7	11	6	↓ 45,45%
4	Asuransi Lain	10	10	20	↑ 100%
Total Pasien		61	59	71	↑ 20,33%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Juni - Agustus 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

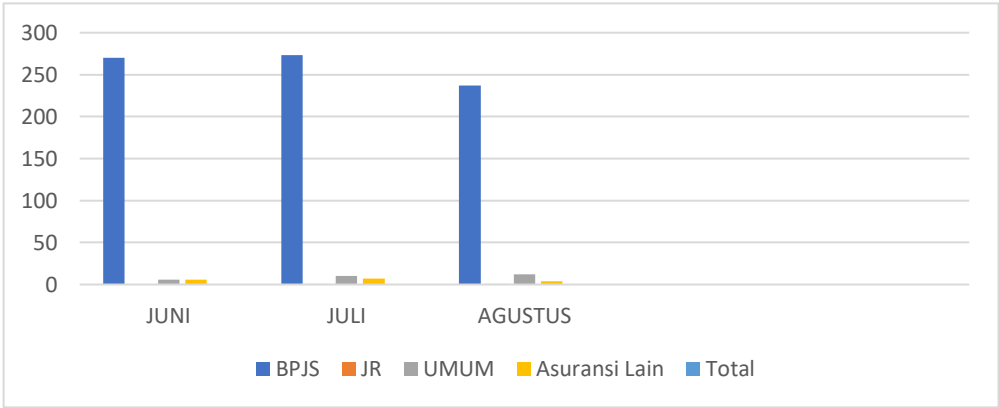
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Agustus 2025	44	6	1	20	71
	Analisa	Bulan Agustus pasien BPJS naik seknifikan dari 38 menjadi 44	Pasien umum bulan Agustus turun menjadi 6 dari 11	Pasien JKK ada 1 karena naik ke VIP	Untuk pasien asuransi juga mengalami kenaikan drastis dari 10 px menjadi 20 pasien di bulan Agustus	Total bulan Agustus mengalami kenaikan yang segnifikan dari 59 menjadi 71
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	270	273	237	↓ 15%
2	JR	0	1	1	0%
3	Umum	6	10	12	↑ 16%
4	Asuransi Lain	6	7	4	↓ 75%
Total Pasien		282	291	254	↓ 15%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Juni - Agustus 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

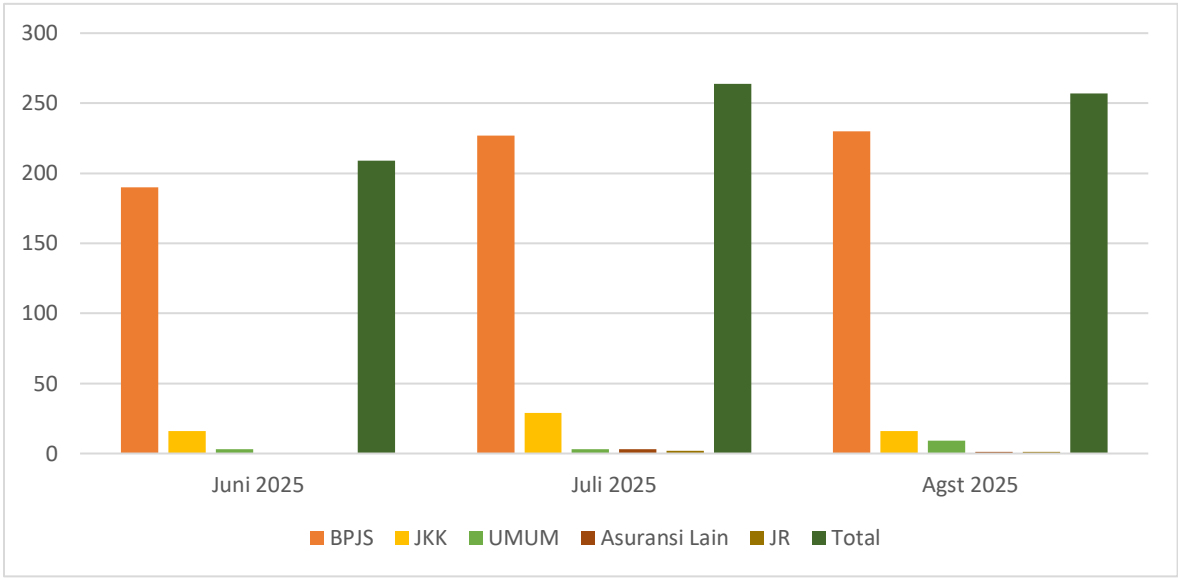
NO.	BULAN AGUSTUS 2025	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS ada penurunan selama 3 bulan terakhir pada bulan agustus 2025 mengalami penurunan 15% dikarenakan pasien anak tersebar di semua lantai	Pasien Umum mengalami peningkatan di bulan agustus sebanyak 16% Dikarenakan pasien sudah memiliki BPJS semua	Pasien JR dari 3 bulan terakhir tetap Dikarenaka KLL kebanyakan tunggal dan jatuh sendiri	Pasien Asuransi mengalami penuruna 75% di bulan agustus Karena rata-rata pasien menggunakan penjamin BPJS	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi di bulan juli peningkatan di setiap bulannya yaitu 291 dan mengalami penurunan dui bulan agustus sebanyak 15% yaitu 254
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	190	227	230	↑ 1,32 %
2	JKK	16	29	16	↓ 44,82 %
3	Umum	3	3	9	↑ 100 %
4	Asuransi Lain	0	3	1	↓ 100 %
5	JR	0	2	1	↓ 100 %
Total Pasien		209	264	257	↓ 2,65 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

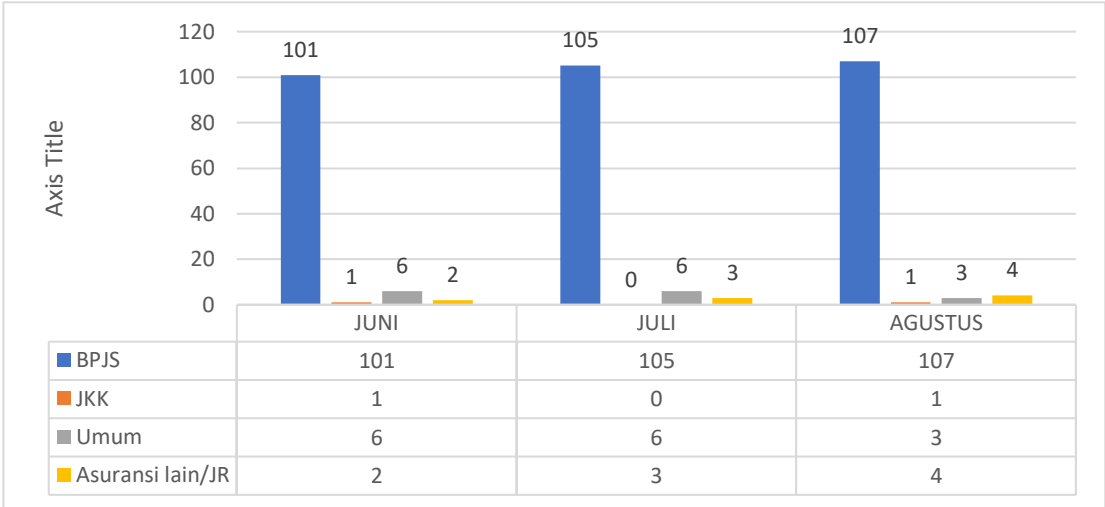
NO.	BULAN JULI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Agustus 2025	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 230 pasien	Pasien Umum mengalami peningkatan di bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 9 pasien	Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 19 pasien	Pasien JR mengalami penurunan pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 1 pasien dan Pasien Asuransi mengalami penurunan pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 1 pasien	Penurunan jumlah pasien terjadi di bulan Agustus 2025 dengan jumlah pasien sebanyak 257 pasien.
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	101	105	107	↑0,01%
2	JKK	1	0	1	↑100%
3	Umum	6	6	3	↓50%
4	Asuransi Lain	2	3	4	↑25%
Total Pasien		110	114	115	↑0.86%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

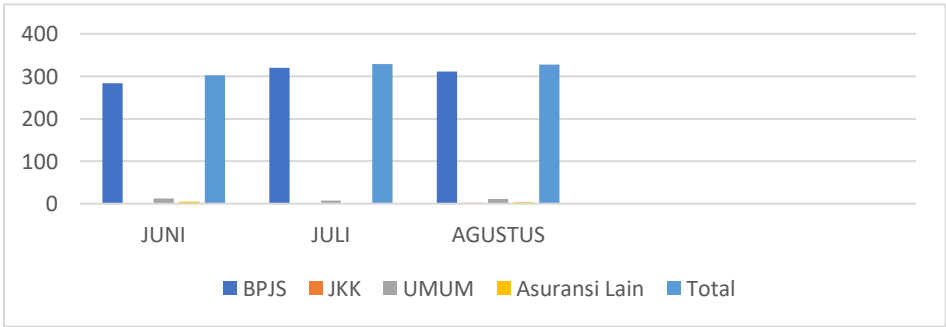
NO.	BULAN JULI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Agustus 2025	Total Pasien BPJS mengalami kenaikan sebanyak $\uparrow 0,01\%$ dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami penurunan $\downarrow 50\%$ dari kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan maupun peningkatan $\downarrow 100\%$ dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 25\%$ dari bulan sebelumnya	Pada bulan Juli untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar $\uparrow 0.86\%$
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni – Agustus 2025)

NO	PENJAMIN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	284	320	311	$\downarrow 2,8\%$
2	JKK	0	1	2	$\uparrow 50\%$
3	Umum	13	7	11	$\downarrow 36.6\%$
4	Asuransi Lain	5	1	3	$\uparrow 66,6\%$
Total Pasien		302	329	327	$\downarrow 0,6\%$

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni – Agustus 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

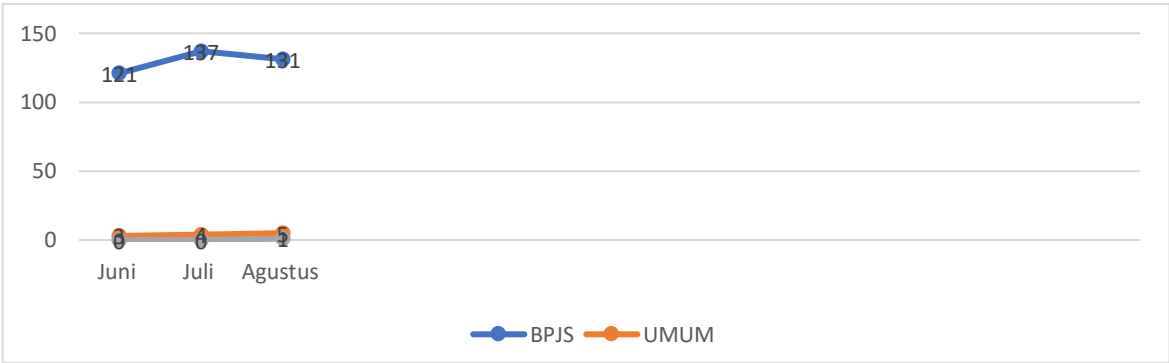
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami terjadi penurunan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 320 pasien	Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 11 pasien	Terdapat 2 pasien JKK pada bulan Agustus 2025	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2025	Penurunan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan Juli dengan jumlah pasien sebanyak 329 pasien.
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGISTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	121	137	131	↓4,37%
2	Umum	3	4	5	↑20%
3	Asuransi	0	0	1	↑100%
Total Pasien		124	143	137	↓4,19%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

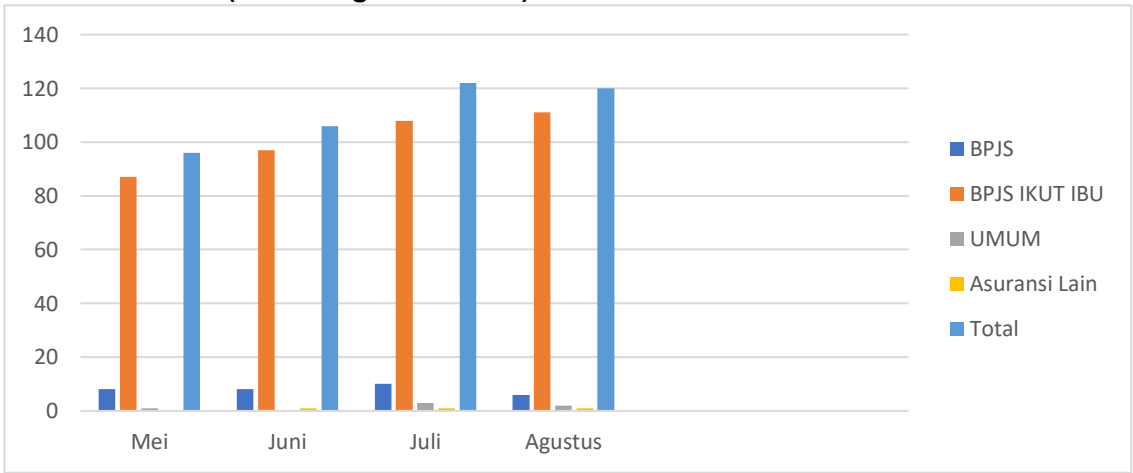
NO	BULAN JUNI	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Bulan Juni-Agustus	Pasien BPJS pada bulan Agustus mengalami penurunan 4,37%	Pasien umum pada bulan Agustus mengalami kenaikan 20 %	Pasien umum pada bulan Agustus mengalami kenaikan 100 %	Kunjungan turun dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	8	10	6	↓3,33%
2	Umum	2	0	3	2	↓0,83%
3	Asuransi Lain	1	1	1	1	=0%
4	BPJS IKUT IBU	100	97	108	111	↑2,5%
Total Pasien		110	106	122	120	↓1,76%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	TOTAL PASIEN
1	Agustus 2025	6	2	1	111	120
	Analisa	Untuk pasien BPJS	Untuk pasien Umum	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu	

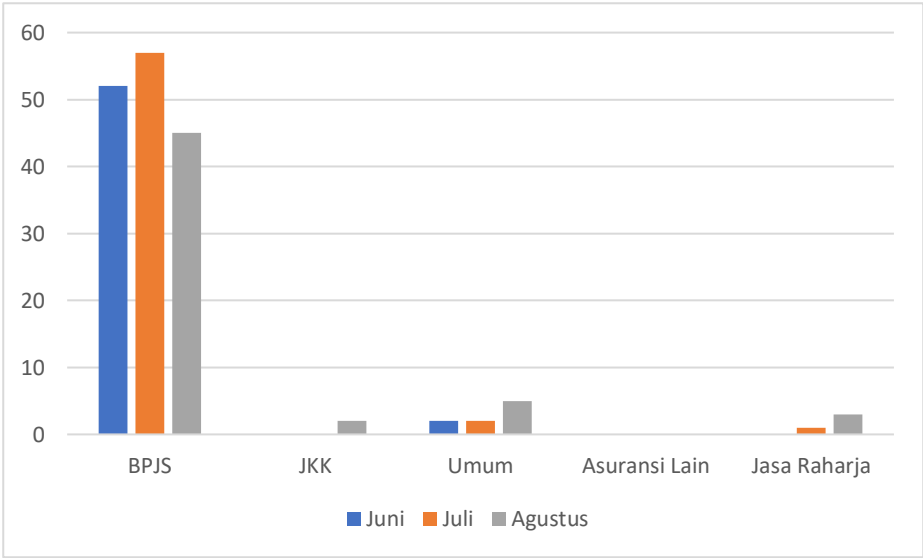
		mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,33%	mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,83%		mengalami kenaikan 2,5%	
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	PENJAMIN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	52	57	45	↓21%
2	JKK	0	0	2	↑100%
3	Umum	2	2	5	↑95%
4	Asuransi Lain	0	0	0	tetap
5	JR	0	1	3	↑97%
Total Pasien		54	60	55	↓8,3%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada

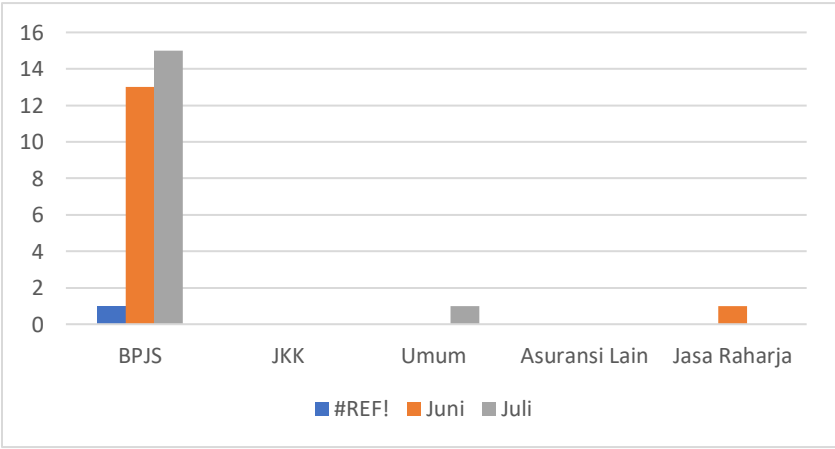
		Agustus 2025 mengalami penurunan 8,3% dibandingkan bulan sebelumnya	peningkatan bulan juni mengalami peningkatan 100% 2025 di bandingkan bulan dengan bulan sebelumnya		Agustus 2025 ada 3 kunjungan, meningkat dari bulan sebelumnya	mengalami kenaikan sebesar 97% dibandingkan dari bulan sebelumnya karena pasien yang perawatan di ruang ICU adalah sebagian pasien jantung
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	13	15	19	↑26,6%
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	0	1	0	↓100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	1	0	0	Tetap
Total Pasien		14	16	19	↑18,75%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

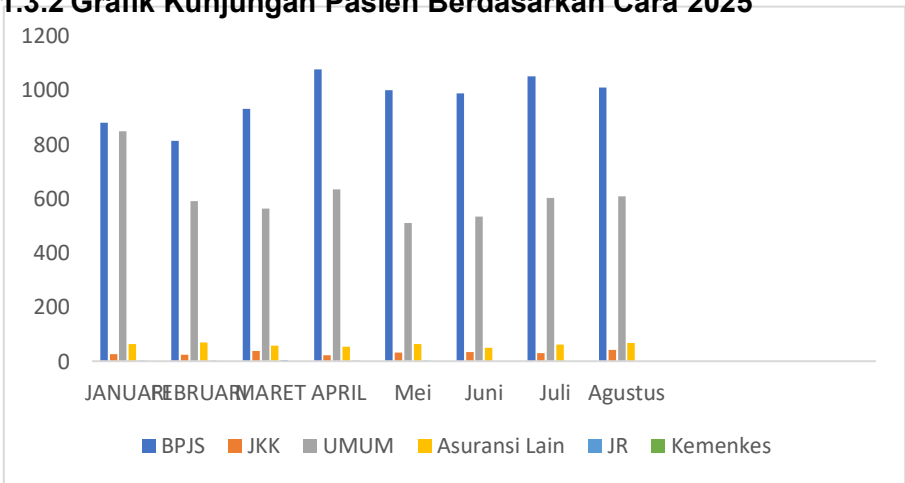
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan Agustus 2025 mengalami kenaikan di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Agustus 2025 sama seperti bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi bulan Juli 2025 tidak ada pasien	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada tetap dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2025)

NO	HAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	987	1050	1010	↓3,8%
2	JKK	533	603	608	↑ 0,8 %
3	Umum	33	30	42	↑ 28,5%
4	Asuransi Lain	50	61	67	↑ 7,4%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		1.625	1.744	1727	↓0,9%

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara 2025



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JULI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di IGD menurun	Kunjungan pasien UMUM di IGD meningkat	Kunjungan pasien JKK di IGD meningkat	Kunjungan pasien asuransi di IGD	Kunjungan pasien dengan

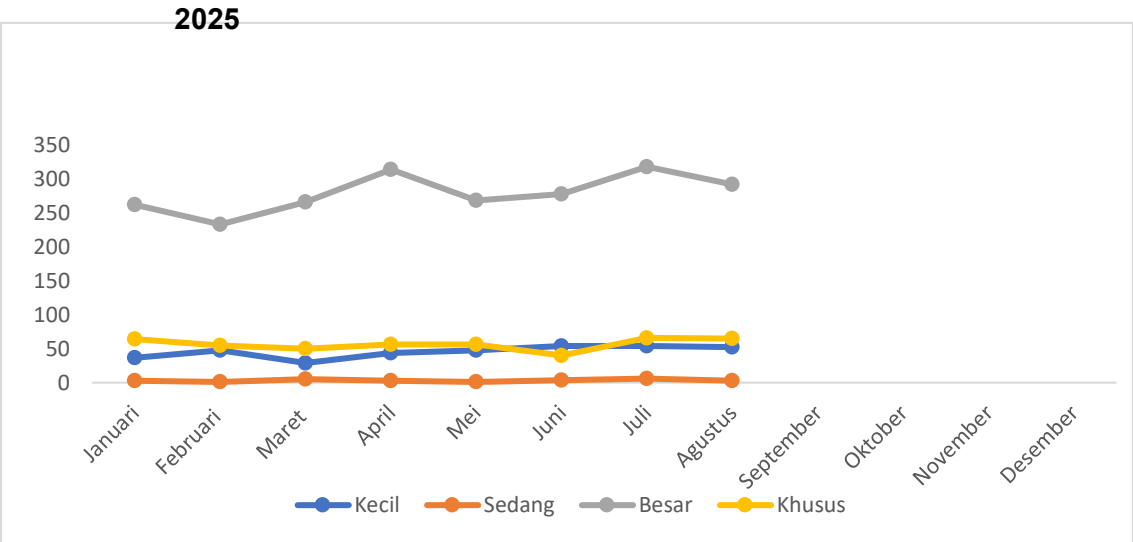
		dibandingkan bulan juli 2025 banyaknya rujukan dari luar yang di tolak terkait fasilitas dan untuk kunjungan menurun banyaknya kegiatan di bulan agustus sehingga untuk jumlah kunjungan di IGD menurun	dibandingkan bulan juli karena banyak pasien masuk false emergency di IGD sehingga menggunakan cara bayar umum	28,5% di bandingkan bulan juli, ini meningkat karena pertengahan bulan agustus turun hujan selama 1 minggu sehingga banyak kecelakaan kerja	meningkat 7,4% di bandingkan bulan agustus 2025 disebabkan pasien yang masuk ke IGD karena mempunyai asuransi	jaminan JR dari bulan Juli ke agustus mengalami penurunan 0 %
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Mei - Juli 2025)

NO	HAL	JUNI 2025				JULI 2025				AGUSTUS 2025			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	52	4	52	4	52	4	52	4	49	3	278	29
2	JR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
3	Umum	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	5	6
4	Asuransi Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22
	Total Pasien	376				444				412			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JULI	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi belum stabil untuk bpjs TK meningkat untuk bulan juli di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan mengalami peningkatan	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir stagnan tidak ada operasi selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untukAgustus 2025 mengalami peningkatan di bandingkan bulan sebeleumnya	Total pasien untuk bulan Agustus 2025 menurun bandingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

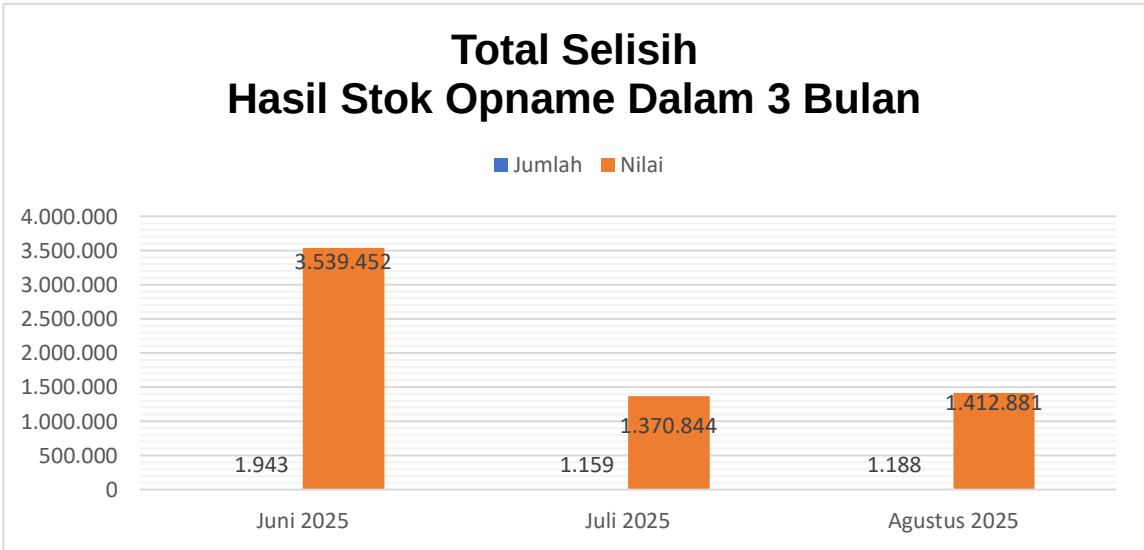
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Juni - Agustus 2025

UNIT	STOK	JUNI 2025		JULI 2025		AGUSTUS 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	1.026.778	1.713.691.456	781.394	1.348.925.757	804.320	1.583.025.196
	Sistem	1.026.751	1.713.581.456	781.394	1.348.925.757	804.620	1.583.511.196
	Selisih	26	0	0	0	-300	-486.000
DEPO FARMASI	Fisik	296.141	744.906.778	185.996	594.215.843	225.591	610.008.889
	Sistem	294.212	739.557.458	184.837	592.844.999	224.104	608.110.008
	Selisih	1.917	+3.539.452	+1.159	+1.370.844	+1.488	+1.898.881
IKO	Fisik	2.504	95.918.212	2.270	86.545.010	2.624	100.070.771
	Sistem	2.496	95.775.965	2.270	86.545.010	2.624	100.070.771
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		1.943	+3.539.452	1.159	+1.370.844	+1.188	+1.412.881

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Juni – Agustus 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar -Rp 486.000 , hal ini disebabkan karena :		
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
2	Kode barang F00052 Asam tranexamat tab 500 mg - Hexpharm selisih kurang 300 pcs (3 Box). Kartu stok Gudang tanggal 28/08/2025 mutasi keluar 300 tetapi tidak ada release barang.	1. Penggunaan scan barcode atau RFID dalam proses serah terima barang → follow up ke programmer terkait dengan program scan. 2. Pelaksanaan double check oleh petugas gudang dan petugas depo farmasi.
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +Rp 1.898.881 , hal ini disebabkan karena :		
1	Kesalahan dalam perhitungan buffer stok tidak terhitung saat stok opname bulan Juli 2025 : F00148 Cefadroxile caps 500 mg - hexpharm jaya = +326 F00347 Glyceryl guaiacolate (gg) tab 100 mg = +242 F03214 Vitamin b kompleks tab – pim = +220	1. Perbaiki penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok (sesuai alfabetis dan penggolongan obat). 2. Penambahan lemari buffer stok di ruang buffer agar buffer tidak di tumpuk di dalam kardus.
2	Ketidaksesuaian dalam proses INPUT (tidak menulis perubahan jumlah di resep) dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang disiapkan, yang	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.

	seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check dengan penerima obat.	2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid Jangmed terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
3	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : F00123 Cairan inf ns 0.9% 1000 ml – otsuka = +8 F01472 Infusion set anak – hexacare = +2 F01475 Infusion set dewasa y set – otsuka = -1 F01504 Jarum neolus 23 g x 1¼" – bd = -5 F01692 Oxyflow dewasa (nasal oxygen cannul I) – nousmed = +1 F01986 Sput 10 cc – gidcare = -2 F01991 Sput 3 cc – gidcare = -4 F01992 Sput 5 cc – gidcare = +3	1. Penegasan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai → kolaborasi dengan Karu IGD. 2. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan dan supervisi oleh kains farmasi. 3. Perbaikan alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
4	Ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan, seperti: F00339 Glimepiride tab 1 mg - ogb dexta = -12 F00340 Glimepiride tab 2 mg - ogb dexta = +12 F00727 Symbicort raphaler 120 160/45 mcg - astra zeneca = +1 F00728 Symbicort turbuhaler 120 160/45 mg - astra zeneca = -1	1. Memperbaiki sistem pengeluaran barang dari gudang ketika ada nama barang sama namun beda pabrik dengan memastikan stok depo dihabiskan terlebih dahulu sebelum dinonaktifkan. 2. Sosialisasi kepada perawat perbaikan fitur pencarian dalam SIMRS untuk meningkatkan akurasi pemilihan barang. 3. Memperbaiki sistem penyiapan barang bertanggungjawab atas input penjualan.
5	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).	1. Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati 2. Melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi 3. Melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kabid keperawatan dan Kabid penunjang terkait obat-obatan yang belum tereturn sesuai dengan alur
IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Perawat patuh melakukan input resep; retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; tidak ada anomali data di SIMRS	Supervisi secara berkala

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Agustus 2025 – Februari 2026)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Mar 24 - Ags 25
							Juni	Juli	Ags		
1.	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	10	10	10	2.800.000	21
2.	F01394	Foley cath silicon no 10 - rusch	Pcs	110.000	30/09/2025	KME20K3008	3	3	3	330.000	4
3.	F01680	Nelaton cath no 12 - rusch	Pcs	16.500	30/09/2025	KMA2030441	1	1	1	16.500	1
4.	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.000	30/10/2025	KMF20I2362	7	7	7	1.554.000	5
5.	F00586	Oxoferin sol 30 ml - pharos	Btl	80.500	30/11/2025	D3C2720	7	6	3	241.500	14
6.	F00603	Perossal 2x6 - dipa pharmlab	Pcs	231.000	30/10/2025	22KA14790	0	0	12	2.772.004	99
7.	F01390	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.570	30/11/2025	P20L04	24	22	22	452.540	18

8.	F00606	Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros	Amp	1.532	31/12/2025	46803002-2	8	5	5	7.660	41
9.	F00176	Cendo pantocain 2% - cendo	Flash	13.250	30/01/2026	3p30117	11	5	4	53.000	16
10.	F01395	Foley cath silicon no 12 - rusch	Pcs	77.000	30/01/2026	KME21B1823	0	0	18	1.386.000	3
11.	F00558	Obat suntik kb 1 - harsen (hibah)	Vial	0	30/01/2026	3A020100	0	0	38	0	146
12.	F04476	Susu dancow full cream 780 g (hibah) - nestle	Box	0	01/01/2026	12578064	74	57	33	0	87
13.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra - sanofi	Vial	179.550	31/01/2026	5DA67D1	0	0	5	897.750	113
TOTAL										6.313.883	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Agustus 2025 - Februari 2026)

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Agustus 2025 - Februari 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs. 2. Foley cath silicon no 10 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 17/01/2023 dari distributor sejumlah 10 pcs. 3. Nelaton cath no 12 – rusch, digunakan untuk kateterisasi kandung kemih jangka pendek. 4. Foley cath silicon no 8 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/03/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. 5. Oxoferin sol 30 ml – pharos digunakan untuk luka terinfeksi, penyembuhan luka yang lambat sesudah traumatik atau sesudah operasi, ulkus decubitus, ulkus kaki kronis pada insufisiensi vena, ulkus dan luka akibat aliran darah arteri, ulkus diabetik, ganggren, luka bakar. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/02/2024 dari distributor sejumlah 3 botol. 6. Perossal 2x6 - dipa pharmlab merupakan material sintetik pengganti tulang yang resorbable, digunakan untuk pengisian atau rekonstruksi tulang pada tulang yang rusak. Pembelian terakhir tanggal 30/08/2025 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 12 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari RS rekanan. 7. Foley cath no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 8. Phenobarbital inj 50 mg/ml – phapros untuk mengontrol dan meredakan kejang, serta sebagai obat penenang sebelum tindakan operasi dan untuk mengatasi insomnia. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/11/2023 dari distributor sejumlah 30 ampul. 9. Cendo pantocain 2% - cendo digunakan sebagai anestesi untuk meredakan nyeri pada mata selama operasi atau pemeriksaan mata. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/07/2023 dari distributor sejumlah 16 flash. 10. Foley cath silicon no 12 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. 11. Obat suntik kb 1 - harsen (hibah)	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS.

	12. Susu dancow full cream 780 g (hibah) – nestle, Penggunaan susu slow moving diberikan untuk pasien anak yang mengkonsumsi obat TB. Penerimaan hibah dari Dinkes Kabupaten Malang dengan ed < 1 tahun pada tanggal 16/10/2024 sejumlah 120 box. 13. Vaksin vaxigrip tetra – sanofi untuk mencegah penyakit Influenza yang disebabkan oleh 4 tipe virus influenza yaitu 2 tipe A dan 2 tipe B yang sangat mudah menular melalui air liur (droplet). Pembelian terakhir tanggal 23/08/2025 dari distributor sejumlah 11 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor karena adanya program harga promo dari PT. Sanofi dan penyediaan stok di RS untuk paket vaksin dengan harga promo.	
--	---	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah Tenaga Vokasi Farmasi/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

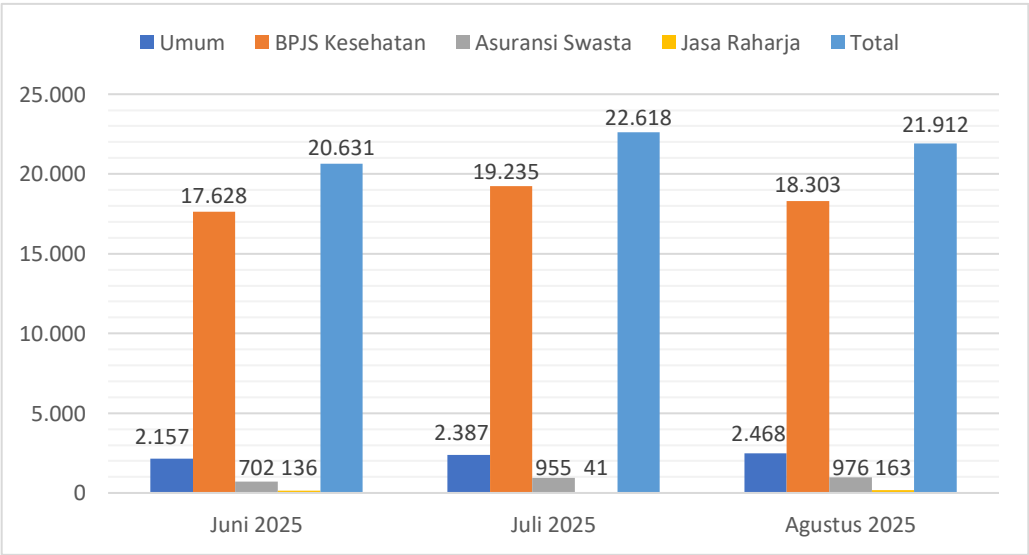
3	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/</i> <i>beyond use</i> <i>date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

9	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Agustus 2025

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	53	239	0	0	0	292
	Jumlah Resep Obat Jadi	866	7.593	0	456	98	9.013
	Jumlah Resep Obat	919	7.832	0	456	98	9.305
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	65	47	0	0	0	112
	Jumlah Resep Obat Jadi	685	1.600	0	154	26	2.465
	Jumlah Resep Obat	750	1.647	0	154	26	2.577
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	264	1.491	0	0	2	1.757
	Jumlah Resep Obat Jadi	506	6.426	0	283	7	7.220
	Jumlah Resep Obat	770	7.917	0	283	9	8.979
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	29	907	0	85	30	1.051
	Jumlah Resep Obat	29	907	0	85	30	1.051
TOTAL		2.468	18.303	0	976	163	21.912

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Juni - Agustus 2025



Analisis :

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan Agustus 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025, dengan total resep yaitu : bulan Juli 2025 sebanyak 2.387 resep umum dan bulan Agustus 2025 sebanyak 2.468 resep umum.

2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan Agustus 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025, dengan total resep yaitu : bulan Juli 2025 sebanyak 19.235 resep BPJS Kesehatan dan bulan Agustus 2025 sebanyak 18.303 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan Agustus 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025, dengan total resep yaitu : bulan Juli 2025 sebanyak 1.036 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan Agustus 2025 sebanyak 1.139 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja.
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan Agustus 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan untuk pasien rawat jalan adanya pembatasan kunjungan pasien per poli, adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil, retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien, kurangnya promo tarif vaksin di poli, kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain, DPJP tidak praktek karena cuti; untuk pasien IGD ada batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL; untuk pasien rawat inap adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi. Evaluasi pelayanan ODD.
3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni - Agustus 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Juni 25	Juli 25	Ags 25	
1	Pengkajian resep	100%	98.61%	99.14%	99.01%	Jumlah pengkajian resep yaitu Juni 2025 = 20.631 Juli 2025 = 22.618 Agustus 2025 = 21.912 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu Juni 2025 = 287 Juli 2025 = 195 Agustus 2025 = 218
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.

4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ada kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	59	35	17	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

3.2.1.10 **Tabel Analisa dan Tindakanlanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Juni 2025**

KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Agustus 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Juli 2025 sebanyak 99.14% dan bulan Agustus 2025 sebanyak 99.01%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : 1. Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. 2. Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 218 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. 3. Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.	1. Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi. 2. Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). 3. Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

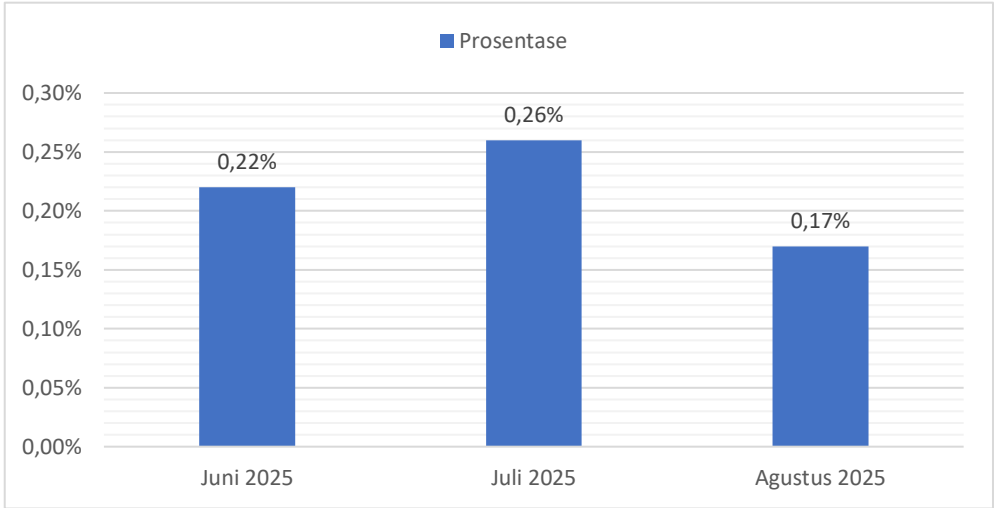
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Agustus 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di Nurse Station atau di Poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Agustus 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Juli 2025 sebanyak 56 dan bulan Agustus 2025 sebanyak 17. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.	- Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

1.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Juni - Agustus 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/6/2025-31/6/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/6/2025-31/6/2025	Methylelgometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/6/2025-31/6/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi

4	1/6/2025-15/6/2025	Santagesik inj 1 gr	Analgesik	PT. Bina San Prima	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juni 2025 = 0.22%					
1	1/7/2025-31/7/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/7/2025-31/7/2025	Methylethergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/7/2025-30/7/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/7/2025-4/7/2025	Divalproex sodium tab 500 mg	Anti konvulsan	PT. Parit Padang Global	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juli 2025 = 0.26%					
1	1/8/2025-31/8/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/8/2025-31/8/2025	Methylethergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Agustus 2025 = 0.17%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Juni - Agustus 2025



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Methylethergometrin tab 0,125 mg (paten dan generik) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Agustus 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	Masker nebulizer set anak - Besmed	1 pcs	Oksigen tidak keluar. No. Batch : 08042588	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruang 3C Anak dilaporkan tanggal 30/08/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. Tindak lanjut : diganti barang yang baru oleh distributor.
3	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Agustus 2025

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut									
1	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.									
2	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP									
3	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari									
4	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	<table><tr><td colspan="3">Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 3 pada Bulan Juli Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu :</td></tr><tr><td>No</td><td>Temuan obat near ED < 6 bulan</td><td>Pergantian obat near ED</td></tr><tr><td>1</td><td>Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26</td><td>Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27</td></tr></table>	Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 3 pada Bulan Juli Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu :			No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1	Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26	Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan
Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 3 pada Bulan Juli Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu :												
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED										
1	Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26	Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27										

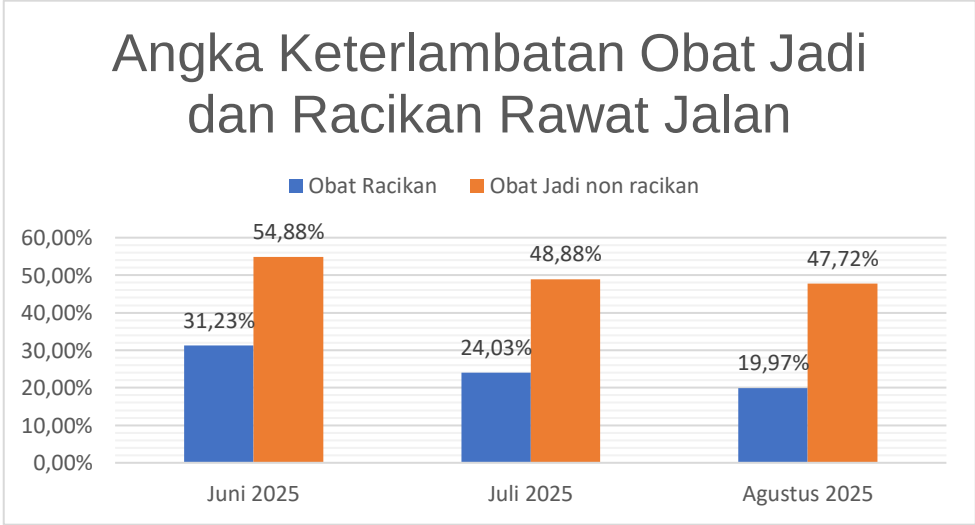
		2	Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sputit 1 cc 1/26	Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sputit 1 cc 5/29	pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.
		3	Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab) 1/26 Mannitol (1 flash) 1/26	Clopidogrel (5 tab) 3/27 Mannitol (1 flash) 1/27	
		4	Box emergency poli vaksin: Mannitol (1 flash) 1/26 Phenytoin inj (1 amp) 1/26 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/26 Furosemid (2 amp) 2/26	Mannitol (1 flash) 1/27 Phenytoin inj (1 amp) 1/28 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/27 Furosemid (2 amp) 12/26	
		5	Trolley emergency IGD: Amiodaron Inj (4 amp) 11/25	Amiodaron Inj (4 amp) 1/27	
		6	Box emergency infant Ponak IGD: Terfusion Terumo (1 pcs) 2/26 Dopamin Inj (1 amp) 2/26	Terfusion Terumo (1 pcs) 12/26 Dopamin Inj (1 amp) 12/26	
		7	Box HPP – Eklamsi IGD: MgSO4 20% (1 flash) 11/25 Misoprostol tab (1 tab) 1/26	MgSO4 20% (1 flash) 9/26 Misoprostol tab (1 tab) 12/26	
		8	Kit emergency IGD 1: Tidak ada obat near ED	-	
		9	Kit emergency IGD 2: Tidak ada obat near ED	-	
		10	Box emergency ambulance: Tidak ada obat near ED	-	
		11	Trolley emergency IKO: Tidak ada obat near ED	-	
		12	Box emergency infant IKO:		

			Suction cath no. 8 12/25 Suction cath no.6 01/26	Suction cath no. 8 03/27 Suction cath no.6 12/27	
		13	Box HPP-Eklampsi IKO: Tidak ada obat near ED	-	
		14	Box emergency 2C: Amiodaron 06/26 Aspilet 06/26 Clopidogrel tab 06/26 Dexamethasone 06/26 Furosemide 05/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal tab 04/27 Clopidogrel tab 01/27 Dexamethasone 03/27 Furosemide 12/26	
		15	Box emergency ICU: Dexamethason 06/26 Inzana 03/26 Furosemide 05/26	Dexamethason 03/27 Inzana 04/27 Furosemide 12/26	
		16	Box emergency ICU ventilator: Dexamethason 06/26 ISDN 05/26 Norepinephrin 04/26 Manitol 04/26	Dexamethason 03/27 Inzana 12/26 Norepinephrin 07/26 Manitol 01/27	
		17	Box emergency HCU: Amiodaron 06/26 Inzana tab 06/26 Clopidogrel tab 05/26 Dexamethason 05/26 Manitol 03/26 Infusion set dewasa 07/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal tab 04/27 Clopidogrel tab 01/27 Dexamethason 03/27 Manitol 01/27 Infusion set dewasa 01/30	
		18	Box emergency 3C anak: Tidak ada obat near ED	-	
		19	Box emergency PICU Ventilator: Tidak ada obat near ED	-	
		20	Box emergency PICU: Tidak ada obat near ED	-	
		21	Box emergency 2A: Inzana 06/26 Amiodarone 06/26 Dexamethasone 04/26 Natrium phenytoin 02/26 Manitol 03/26	Inzana 04/27 Amiodarone 01/27 Dexamethasone 03/27 Natrium phenytoin 09/27 Manitol 01/27	
		22	Box emergency 3A: Tidak ada obat near ED	-	
		23	Box emergency 4A: Dexamethasone 04/26	Dexamethasone 03/27	

			Nospirinal tab 07/26 Phenytoin 03/26 Valisanbe 03/26 IV cannul no. 20 02/26 Manitol 03/26	Nospirinal tab 04/27 Phenytoin 09/27 Valisanbe 01/27 IV cannul no. 20 09/29 Manitol 01/27	
		24	Box emergency infant Maternitas: D10% 04/26 Sput 10cc Terumo 02/26 Dobutamin 01/26	D10% 11/26 Sput 10cc Terumo 01/30 Dobutamin 02/27	
		25	Trolley emergency Maternitas: Amiodaron 06/26 Nospirinal 06/26 Valisanbe 03/26 Furosemide 04/26 Clopidogrel tab 04/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal 04/27 Valisanbe 01/27 Furosemide 12/26 Clopidogrel tab 01/27	
		26	Box emergency infant Perinatologi: D10% 07/26 Dobutamin 12/26 Dopamin 09/26 Infus Gelafusal 02/26 ETT uncuff no.2 02/26	D10% 11/26 Dobutamin 02/27 Dopamin 12/26 Infus Gelafusal 01/27 ETT uncuff no.2 08/29	
		27	Box emergency 5C: Amiodaron 06/26 Clopidogrel tab 10/26 Nospirinal 11/26 Furosemide 11/26 Dopamin 09/26	Amiodaron 01/27 Clopidogrel tab 11/27 Nospirinal 04/27 Furosemide 12/26 Dopamin 12/26	
		28	Box emergency 6A: Atropine 02/26 Dobutamin 12/26 Inzana tab 04/26 Furosemide 04/26 Natrium Phenytoin 06/26 Clopidogrel tab 06/26 Manitol 04/26	Atropine 09/27 Dobutamin 02/27 Nospirinal tab 04/27 Furosemide 12/26 Natrium Phenytoin 01/28 Clopidogrel tab 01/27 Manitol 01/27	
		29	Box emergency 7A: Amiodaron 02/26 Dopamin 04/26 Inzana tab 04/26 Furosemide 04/26 Gelafusal 02/26 Manitol 04/26	Amiodaron 01/27 Dopamin 12/26 Nospirinal tab 04/27 Furosemide 12/26 Gelofusan 01/27 Manitol 01/27	
		30	Box emergency 8A: Hi-Oxy dewasa 01/26	Hi-Oxy dewasa 04/29	
		31	Box emergency Radiologi: Tidak ada obat near ED	-	
5	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.			- Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap

			menuliskan pada kartu stok - Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	Ditemukan perawat menyimpan sisa infus NS 0.9% dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	• Rawat inap : Double check obat dan bmhp resep ODD (One Daily Dose) dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi ke ruangan rawat inap. Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep dan daftar pemberian obat (DPO) antara farmasi dan perawat/ bidan. Perawat/ bidan penerima obat melakukan double check secara independen dengan PJ Shift/ kepala ruang menggunakan daftar pemberian obat (DPO) sebelum obat diserahkan/ disuntikkan ke pasien secara UDD (Unit Dose Dispensing). • Rawat Jalan : Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep antara petugas verifikasi dan petugas penyerah sebelum obat diserahkan ke pasien.	Supervisi secara berkala terkait pelaksanaan double check obat high alert di rawat inap dan rawat jalan

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Juni – Agustus 2025



Analisis :

1. Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan Agustus Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (0%). Hal ini disebabkan :
 - DPJP tidak praktek karena cuti sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari berikutnya ketika DPJP praktek,
 - Pembatasan kunjungan pasien rawat jalan,

- Penurunan angka keterlambatan obat di rawat jalan karena komposisi farmasi sudah lengkap (cuti melahirkan sudah masuk bekerja)

Rencana Tindak Lanjut:

1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh apoteker.

1.2.1 Laboratorium

1.2.1.11Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	JUNI 25	%	JULI 25	%	AGS 25	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1772	<11,84 %	1813	>2,2 %	1817	>0,2%
FAAL HEMOSTASIS	733	>3,82 %	831	>11,7%	779	<6,2%
HEMATOLOGI LAIN	3	>300%	0	0%	0	0%
URINALISIS	180	<28,9%	256	>29,6%	283	>9,5%
ANALISA FEACES	8	>37,5%	14	>42,8%	11	<21,4%
FUNGSI HATI	318	<15,4%	373	>14,7%	315	<15,5%
LEMAK DARAH	718	<4,12%	797	>9,9%	808	<1,3%
GINJAL HIPERTENSI	1197	>10 %	1383	>13,4%	1401	<1,2%
GULA DARAH	1534	<6,8 %	1962	>21,8%	2115	>7,2%
JANTUNG	552	<4,50 %	577	>4,332%	545	<5,5%
ELEKTROLIT DAN BGA	80	<65%	235	>65,9%	164	< 30,2%
IMUNO SEROLOGI	461	<12,2%	469	>1,7%	425	<9,38%
REMATIK	7	>700%	3	<57,1%	5	>40%
ENDOKRINOLOGI	82	>15,9%	93	>11,8%	72	>22,5%
REPRODUKSI	21	>23,8%	26	<19,2%	92	>71,7%
MIKROBIOLOGI	61	>18%	43	<29,5%	46	>6,5%
Jumlah	7727	<9,6%	8875	< 12,8%	8878	>0,3%

Analisis :

Jumlah Pemeriksaan Pada Periode pertama bulan Agustus 2025 didapatkan jumlah total pemeriksaan 8878 pemeriksaan, pada bulan Agustus mengalami kenaikan 0,3 % di bandingkan dengan bulan Juli.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
2. Perbaiki serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.

- Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
- Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

1.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan April - Agustus 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting
Bulan Mei 2025					
1.	Andara	224145	01/05/2025	IGD	Sampel Clotting
Bulan Juni 2025					
Tidak ditemukan sampel rusak					
Bulan Juli 2025					
1.	Kuseran	183848	16/07/2025	IGD	DL clotting
2.	Juri	069001	21/07/2025	IGD	DL clotting
Bulan Agustus					
1	Ra'im	125436	12/08/1952	IGD	DL Clotting
2	Budiarjo	155739	15/08/2025	3A	SE Lisis
3	Suyatmi	235823	03/03/1948	ICU	SE Lisis
4	Suyatmi	235823	03/03/1948	7A	SE Lisis

Analisis :

Ditemukan 4 sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan Agustus 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- Monitoring dan Evaluasi.
- Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
- Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
- Supervisi ED reagen.

1.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan April - Agustus 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4
Juni 2025	15	29	27	8	79	2	1	-	-	3
Juli 2025	18	14	29	6	67	1	4	-	3	8
Agustus 2025	15	32	30	6	83	6	2	0	2	10

1.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						
Bulan Juni 2025						

1.	Siti Rahajuningsih				√	2 Labu
Bulan Juli 2025						
Tidak ada						
Bulan Agustus 2025						
Tidak ada						

Analisis :
Pada periode pertama bulan Agustus 2025 tidak ditemukan pasien Incompatible

Rencana Tindak Lanjut :
Pertahankan Tetap telili dan berhati hati dalam melakukan crossmatch

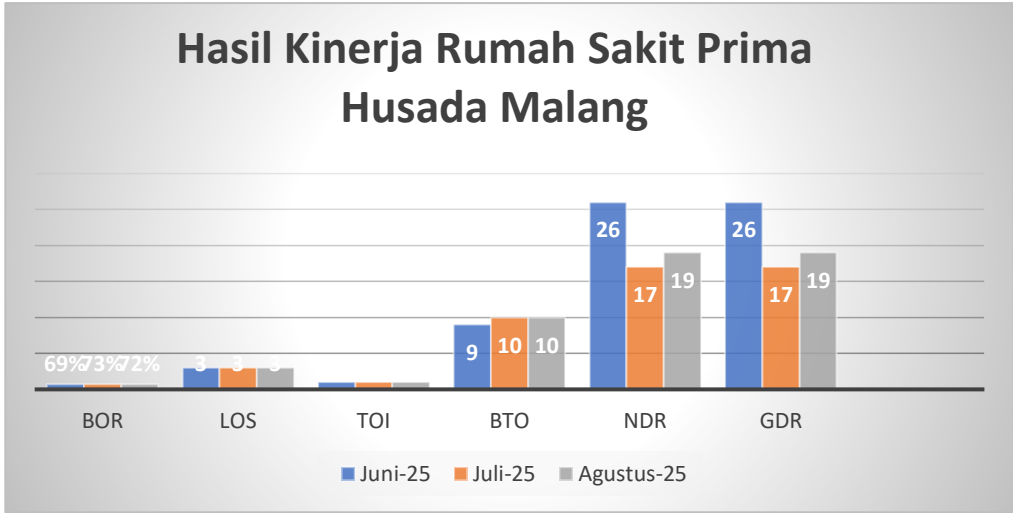
1.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Juni - Agustus 2025

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang												
						LT 2C	LT 3 A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	Juni 25	63	75	73	71	57	64	77	70	60	50	25	33	69
					Juli 25	83	111	71	79	58	66	77	69	66	39	24	28	73
					Agustus 25	63	76	64	91	60	82	81	81	64	12	32	25	72
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Juni 25	4	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3
					Juli 25	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	2	2	3
					Agustus 25	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Juni 25	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	4	1
					Juli 25	1	0	1	1	2	1	1	1	1	7	3	3	1
					Agustus 25	1	1	1	0	2	1	1	1	1	14	2	4	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali (dalam hitungan bulan)	Juni 25	8	9	10	11	7	8	10	8	9	5	9	6	9
					Juli 25	7	10	10	11	8	9	9	10	11	3	8	7	10
					Agustus 25	9	10	9	12	8	9	9	9	11	2	10	6	10
NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap	$(\sum Px \text{ Mati } > 48 \text{ jm}) / \sum Px \text{ keluar } (H+M) \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah	<25%	Juni 25	0	0	0	8	9	20	9	32	0	0	59	404	26

	1000 penderit keluar rumah sakit		pasien keluar		Juli 25	35	12	0	0	0	27	9	43	0	0	0	167	17
					Agustus 25	0	0	0	7	0	19	9	46	0	0	211	172	19
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderit keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Juni 25	0	0	0	8	9	20	9	32	0	0	59	404	26
					Juli 25	35	12	0	0	0	27	9	43	0	0	0	167	17
					Agustus 25	0	0	0	7	0	19	9	46	0	0	211	172	19

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Agustus 2025 2025



Analisis :

Indikator	Nilai Agustus 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	72%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	10 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Catatan
BOR	81%	75%	72%	68%	69%	73%	72%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	10 kali	10 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

Walaupun masih dalam batas ideal → perlu perhatian agar tetap stabil dan tidak menurun di bawah standar.

2. LOS (Length of Stay)

Indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:

- a) Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
- b) Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
- c) Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.

3. TOI (Turn Over Interval)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

4. BTO (Bed Turn Over)

Sangat tinggi (sekitar 10x/bulan), artinya volume turnover sangat besar:

- a) Bisa menimbulkan burnout tim cleaning, housekeeping, frontliner.
- b) Boleh jadi menunjukkan just-in-time turnover, tapi bisa mengurangi kualitas jika tidak seimbang dengan standar sterilitas dan manajemen alur.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Untuk BOR:**
Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.
- 2. Untuk LOS:**
 - a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
 - b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.
- 3. Untuk TOI:**
Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.
- 4. Untuk BTO:**
 - a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
 - b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
 - c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Agustus 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	443
2.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	349
3.	E11.4	With neurological complications	338
4.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	314
5.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	296
6.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	219
7.	J47	Bronchiectasis	201
8.	K04.1	Necrosis of pulp	176
9.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	174
10.	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	171

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Agustus 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever	248
2.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	50
3.	E14.9	Dm Hyperglikemia	27
4.	E11.9	Diabetes Mellitus Type 2	27
5.	M72.6	Necrotizing Fascitis	23
6.	J18.9	Pneumonia	20
7.	J18.0	Broncho Pneumonia	18
8.	A90	Dengue Fever	15
9.	A09.0	Gastro Enteritis Akut	13
10.	S52.5	Close Fraktur Distal Radius	13

Analisis :

- 1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah DM Tanpa komplikasi / Without complications sebesar 443 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 248 kasus.
- 2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

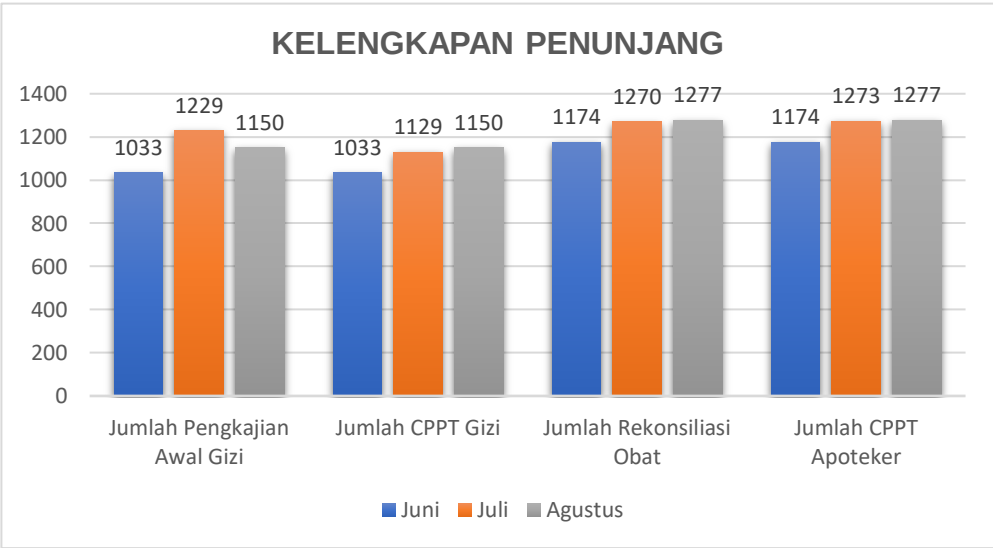
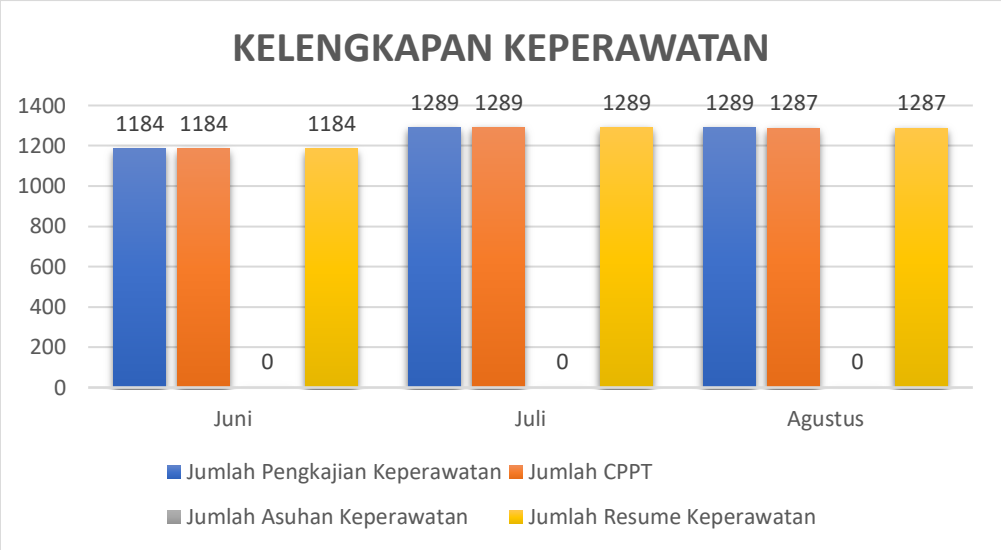
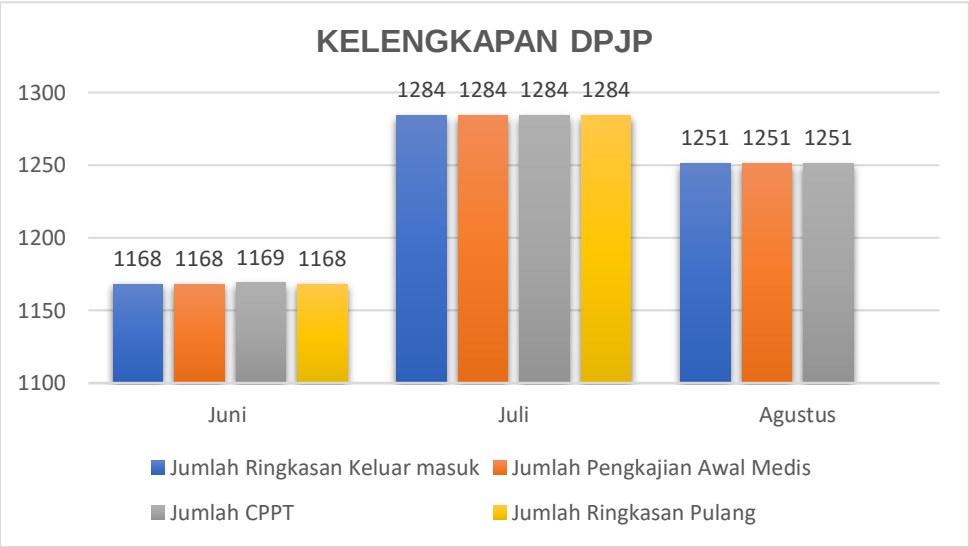
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Agustus 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Agustus 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi terisi lengkap 100% , sebanyak 1150 dokumen
- 2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan Agustus 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Agustus 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

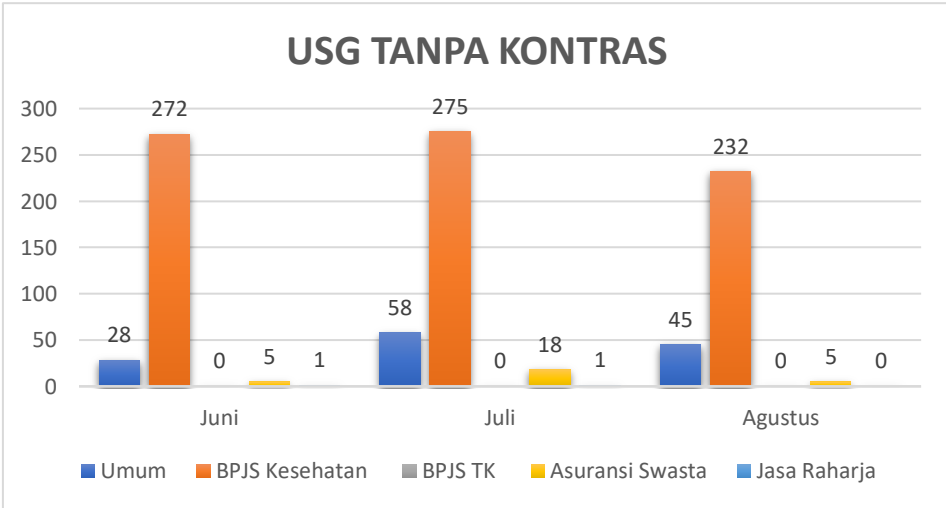
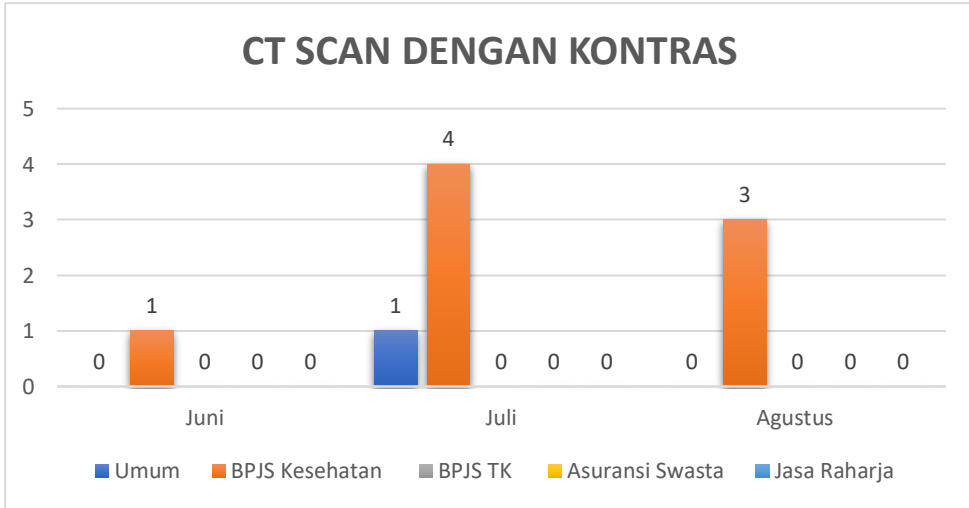
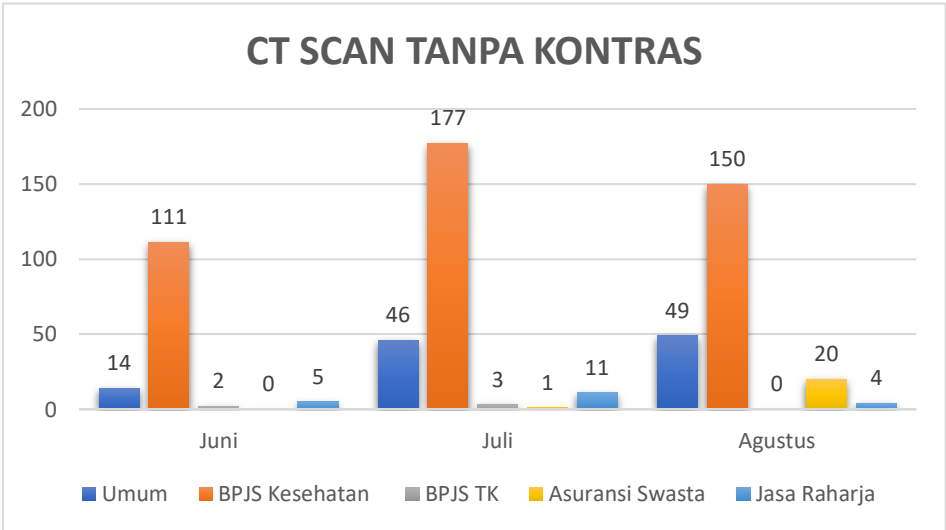
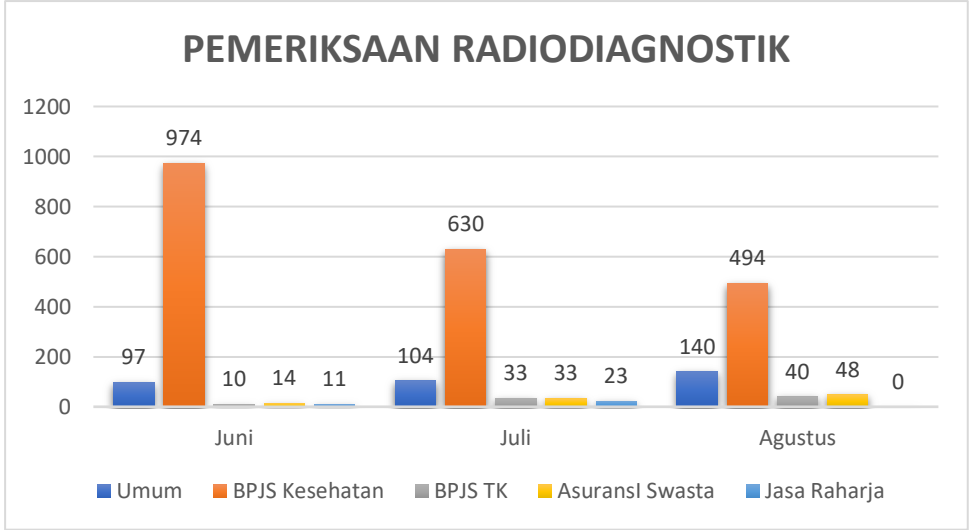
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat raport ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

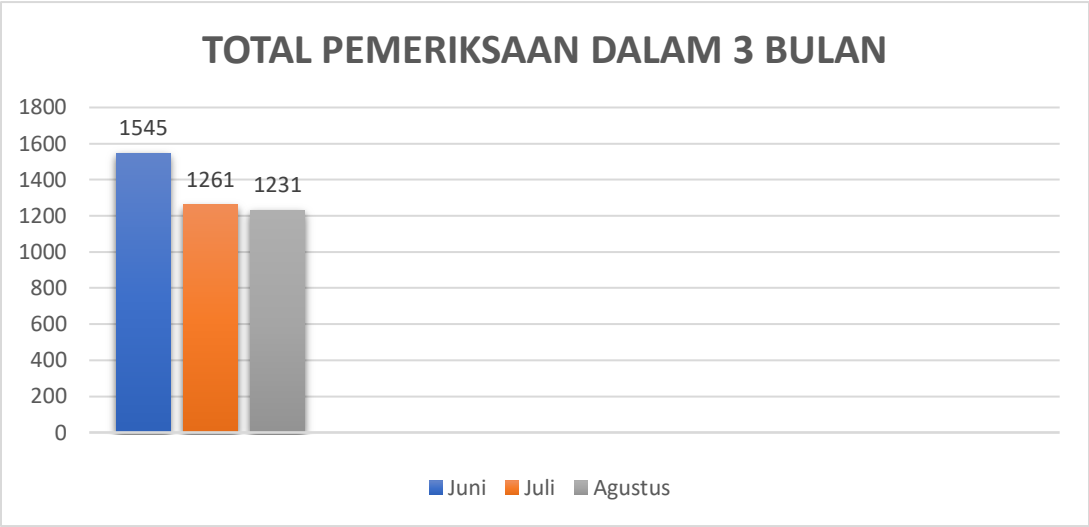
6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	97	104	140
		BPJS KESEHATAN	974	630	494
		BPJS TK	10	36	40
		ASURANSI SWASTA	14	33	48
		JASARAHARJA	11	23	0
	TOTAL		1106	826	722
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	14	46	49
		BPJS KESEHATAN	111	177	150
		BPJS TK	2	3	0
		ASURANSI SWASTA	0	1	20
		JASARAHARJA	5	11	4
	TOTAL		132	78	220
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	1	3
		BPJS KESEHATAN	1	4	0
		BPJS TK	0	0	3
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		1	5	3
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	28	58	45
		BPJS KESEHATAN	272	275	232
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	5	18	5
		JASARAHARJA	1	1	0
	TOTAL		306	352	286
TOTAL KESELURUHAN			1545	1261	1231

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2025





- Analisis :**
- Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Agustus 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada Bulan Agustus 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 722
 - USG Tanpa Kontras : 286
 - CT Scan Tanpa Kontras : 220
 - Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Agustus 2025 adalah sebanyak 1231 pemeriksaan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
 - Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
 - Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan Maret - Agustus 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
2.		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
2.		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
1.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1

Bulan Juni 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Kiki Nur Ika Sari (232011)	Normal	Tetap Normal	1
Bulan Juli 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	- Eko sutaji (189842) - Sabar (195701)	-Normal -Normal	- Pulmonary hipertension - Pneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	0	0	0	0
Bulan Agustus 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Sabar / 195701	Normal	Pneumonia	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	Andrianto / 234437	Normal	Ada garis fraktur	1

Analisis :
 Pada Bulan Agustus Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-180	3	10-1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	10-1440
3.	Ro Abdomen	-	-	10	10-1440
4.	Ro Extremitas	-	-	2	10-1440
5.	Ro Skull	-	-	2	10-1440
6.	USG Abdomen	8	5	15	10
7.	CT Scan Non Kontras	5	30-24	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	25-24	-	-
9.	Radiologi CITO	10	04-25	10	10

- Analisa :**
1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
 2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
 3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
 4. Terdapat pembacaan CITO selama bulan Juli 2025 dan hasil *ekspertise* sesuai target yakni kurang dari 30 menit
 5. Semua pemeriksaan CT Scan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
 6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.

7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Agustus 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

-

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

6.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

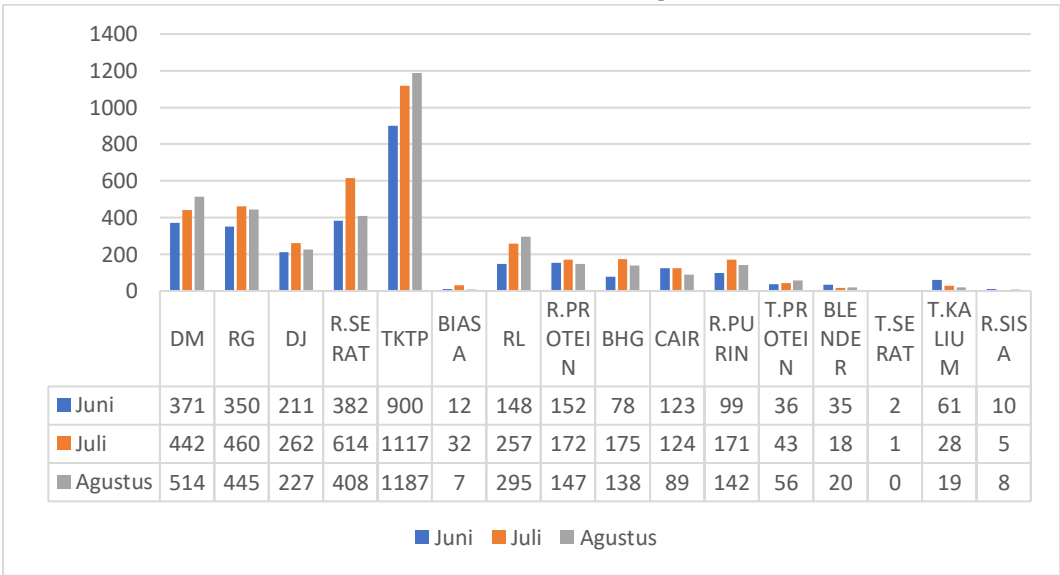
No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Juni - Agustus 2025

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUTUS 2025	
1.	Diabetes Melitus	371	442	514	16,2
2.	Rendah Garam	350	460	445	-3,2
3.	Jantung	211	262	227	-13,3
4.	Rendah serat	382	614	408	-33,5
5.	TKTP	900	1117	1187	6,2
6.	Makanan biasa	13	32	7	-78,1
7.	Makanan Lunak	0	5	2	-60
8.	Rendah Lemak	148	257	295	14
9.	Rendah Protein	152	172	147	-1,4
10.	Bubur Halus	78	175	138	-21
11.	Cair	123	124	89	-28
12.	Rendah Purin	99	171	142	-16
13.	Tinggi Protein	36	43	56	30,2
14.	Blender	35	18	20	1,1
15.	Tinggi serat	2	1	0	0
16.	Tinggi Kalium	61	28	19	-32,1
17.	Rendah Kalium	10	20	11	-45
18.	Rendah Sisa	10	5	8	60
TOTAL		2981	3946	3715	-5,8

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Juni - Agustus 2025



Analisis :
Jumlah pesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan. Pemberian diet TKTP meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan diagnosa post partum normal, post sc, post op, TF, DHF tanpa komplikasi.

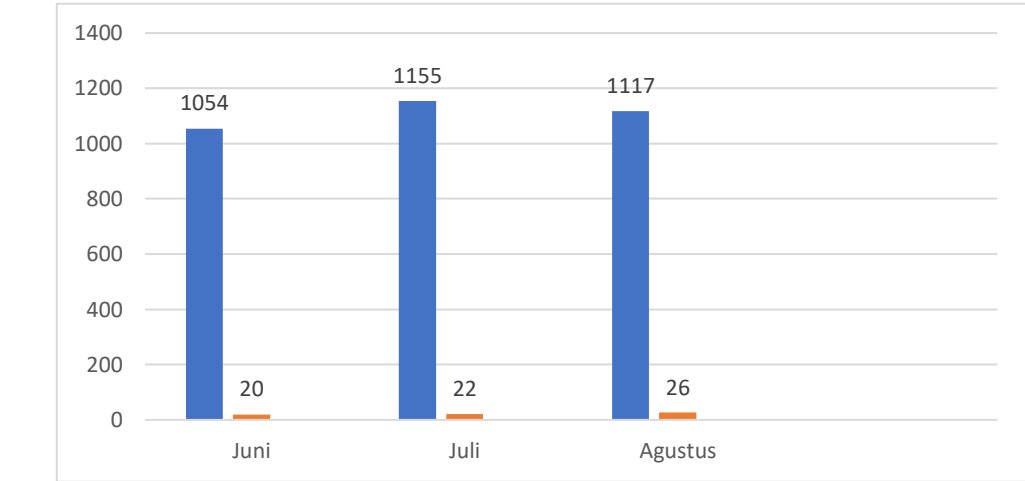
- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 - 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
 - 3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
 - 4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
 - 5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.

6. Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi April - Juni 2025

NO	INDIKASI	JUMLAH PASIEN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1054	1155	1117
2.	Konsultasi Rawat Jalan	20	22	26

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Bulan Juni- Agustus Tahun 2025



Analisis :

1. Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Juli 2025 menurun
2. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan Juli 2025 kondisi stabil.
3. Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Giz

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Agustus 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
		Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)			
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					

Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil makanan pasien terlebih dahulu.	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga mengkonsumsi makanan dalam waktu lebih lama.	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah pembagian makan. 2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	1
Bulan Juni 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	Ny Nadiyah Firliani Komplain melalui google review "makanannya kurang enak"	a. Pasien sakit mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan citarasa b. Antara satu petugas pengolahan dan pengolahan lain memiliki selera rasa yang berbeda sehingga ketika memberi rasa pada makanan disesuaikan dengan selera petugas masing-masing	Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan dalam pembuatan standar resep masakan agar masakan yang dihasilkan sama antara satu petugas dengan petugas lain	1
Bulan Juli 2025					
1	Keluhan adanya benda asing dalam makanan pasien	- Ani Puji Lestari (C3a-6) komplain ada benang wol saat makan siang menu mie bihun, benang dikunyah saat makan oleh pasien. Pasien tidak langsung lapor, tapi mengisi	- Ahli gizi kurang teliti dalam melakukan QC makanan pasien - Petugas pengolahan tidak teliti dalam mengolah bihun. Tidak	- Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan, pemorsia, dan ahli gizi dalam menjaga kebersihan	2

		kuesioner saat KRS. - Hana Rizki Anjani (3c anak) komplain sebaiknya pasien sering diberi menu sayur dan buah.	menggunting benang bihun dengan teliti sehingga ada benang yang tertinggal - Pasien anak dengan diagnosa TF diberikan advice DPJP diet rendah serat (tidak boleh mengonsumsi sayur dan buah). Ahli gizi sudah menjelaskan diet kepada keluarga pasien. Keluarga pasien yang dijelaskan tidak mengoperkan kepada anggota keluarga yang lain. Ahli gizi tidak konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	makanan dari benda asing - Sosialisasi kepada seluruh ahli gizi jika setelah memberikan penjelasan melakukan konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	
Bulan Agustus 2025					
1	Keluhan tentang variasi makanan	- Etik Hariani (2c) komplain jika masakannya tolong bervariasi, - Komplain dari kuisisioner (3 Agustus) Untuk menu makanan bisa bervariasi lagi - Komplain kuisisioner (30 Agustus) Masukan untuk bagian gizi supaya lebih fariatif menu, untuk rasa kurang asin.	Menu makan pasien pada siklus yang berjalan ada yang diulang dalam waktu berdekatan, sehingga jika pasien dirawat dalam waktu 3 hari berisiko masih menemukan menu yang sama dengan hari sebelumnya	- Koordinasi dengan Instalasi gizi RSPHS terkait komplain variasi menu yang muncul - Mengajukan perubahan siklus kepada PT DPM untuk menghindari pengulangan menu dalam waktu dekat (proses pengajuan)	3

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan Mei - Juli 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	120,7	134,5	135,5	75% dari sisa makanan berasal

		Nasi Tim	178	204,5	198,2	dari karbohidrat.
	Total		298,7	339	333,7	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0,3	0	Snack yang memiliki sisa paling banyak adalah bubur sagu dan terang bulan.
		Setup Pisang	0,7	0,8	0,4	
		Kacang Hijau	0,7	0,4	1,4	
		Kue Hongkong	0	0,2	0	
		Terang Bulan	0	1,4	0	
		Bubur Sagu	1,2	1,9	1,0	
		Kue Lumpur	0,5	0,8	0	
		Puding	0	0,5	0,6	
		Donat	0	0,8	0,5	
		Tahu Fantasi	0	1,0	0,4	
		Sagu Mutiara	0	0,7	0	
	Total		3	8,8	4,3	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 12,3 Kg
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,5	3,4	2,4	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	1,3	4,1	3,9	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)				
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	1,5	4,4	4,1	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)				
		Tempe Goreng				
	Tambahan VIP	Perkedel				
	Total					
2.	Menu 2					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	2,5	3,5	3,5	
		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Rebus	2	3	3,1	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)				
		Ayam Wijen				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Telur Gulung	2,7	3,2	2,9	
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)				

		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar			
	Total		7,2	9,7	9,5
3.	Menu 3				
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	2,3	3,3	2,7
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	4,1	3,8	4
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	4,5	4,4	4,5
		Ayam Bombay			
		Tempe Orek			
	Tambahan VIP	Telur Dadar			
	Total		18,5	10,9	11,2
4.	Menu 4				
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,2	3,6	3,4
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	5,3	4,1	3,6
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	5,6	4,6	3,8
		Telur Rebus			
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Keripik Kentang			
	Total		18,9	14,1	10,8
5.	Menu 5				
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025

	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	2	3,4	4,4	
		Opor Tahu				
		Oper Telur				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	4,1	3,4	3	
		Ayam Bombay				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Tahu Krispy				
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	3,9	2,7	5,2	
		Tempe Goreng				
Telur Dadar						
Total		10				
6.	Menu 6					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,8	3,1	4,5	
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun Bawang, Telur)				
		Tempe Goreng				
	Tambahan VIP	Ayam Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	2,1	1,6	4,1	
		Ayam Laos				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok				
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	4,2	2,4	4,3	
		Tahu Krispy				
		Tambahan VIP				
	Total					
7.	Menu 7					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	3,3	2,9	3,6	
		Telur Ceplok Bumbu Kuning				
		Abon				
	Tambahan VIP	Tempe Bacem				

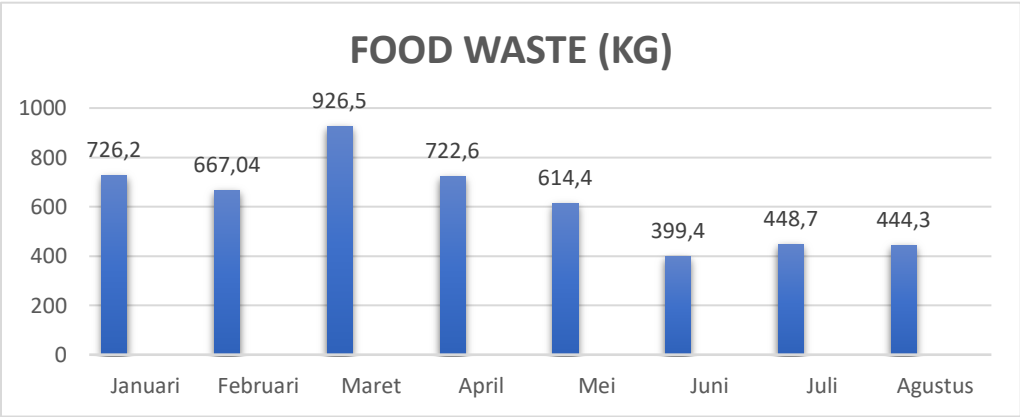
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)	2,4	3,8	3,4	
		Ayam Ungkep				
		Perkedel				
	Tambahan VIP	Jamur Krispy				
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	3,4	5,5	5,7	
		Tempe Goreng				
	Tambahan VIP	Telur Dadar				
	Total		9,1	12,2	12,7	
8.	Menu 8					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Sayur Bobor (Manisah, Sawi Hijau)	2,2	3,7	3,4	
		Tahu Nugget				
		Abon				
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung				
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)	2	3,7	3,5	
		Ayam Bakar				
		Tahu Goreng				
	Tambahan VIP	Nugget Ayam				
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	2	3,8	3,6	
		Botok Tahu				
		Abon				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Total		6,2	11,2	10,5	
9.	Menu 9					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	6,2	3,6	3	
		Tahu Rempah				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Dadar				
	Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	4,5	3,2	2,8	
		Ayam Kemangi				
		Tahu Krispi				
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar				
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,8	3,4	2,6	
		Telur Rebus				
		Tempe Goreng				

	Tambahan VIP	Keripik Kentang				
	Total		15,5	10,2	8,4	
10.	Menu 10					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	2	3	2,8	
		Telur Ceplok				
		Abon				
	Tambahan VIP	Tempe Bacem				
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	3,1	2,8	2,4	
		Ayam Wijen				
		Tahu Goreng				
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik				
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	5,1	3,9	4,3	
		Tempe Goreng				
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar				
	Total		10,2	9,7	9,5	
11	Menu 11					
	Bulan		Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025	
	Pagi	Sapo Tahu (Tahu, wortel,kembang kol, bakso)	-	1,8	0,6	
		Tempe Goreng				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur rebus				
	Siang	Sayur asem (Wortel, kacang panjang, manisah)	-	0,7	0,7	
		Ayam bakar				
		Bakwan jagung				
	Tambahan VIP	Tahu Goreng				
	Sore	Semur (Ayam fillet, soun, daun bawang,tomat)	-	1,9	0,8	
		Tahu Rempah				
		Abon				
	Tambahan VIP	Jamur krispy				
	Total		-	4,4	2,1	
	Total Sisa Menu tanpa KH		97,9	109,7	110,6	
	Total Keseluruhan dengan KH		396,6	448,7	444,3	

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08
5.	Mei 2025	614,4	19,81
6.	Juni 2025	399,4	13,3
7.	Juli 2025	448,7	14
8.	Agustus	444,3	14

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunansisa makanan pada Bulan Agustus 2025, yaitu sebanyak 444,3 kg, setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
5. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
2. Melakukan plating secara menarik.
3. Mengadakan cooking class.
4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan

BULAN :
TEMPAT : PENCUCIAN ALAT DAPUR

TANGGAL															
1		2		3		4		5		6		7		8	
P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
Batas suhu min (°C)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Batas suhu maks (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Nilai Suhu (°C)	73	75	74	75	77	74	72	71	70	77	72	71	70	71	73
Inisial Staff	Dk	Dk	Dk	Sb	Sb	Dk	Dk	TY	TY	Dw	Dw	wn	wn	wn	sb
Supervisi Karu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Ket :
1. Isi dengan angka yang sesuai pada kolom suhu (°C) sebagai tanda ukuran suhu pada tanggal tersebut, grafik secara otomatis akan terbentuk.
2. Tuliskan inisial staf yang melakukan pencatatan dan akan di supervisi (v) oleh kepala ruang setiap harinya.

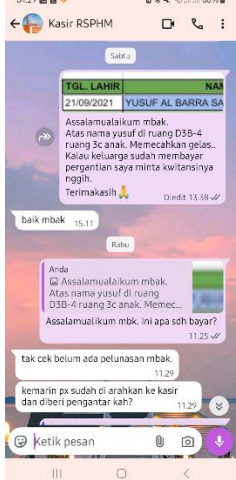
17		18		19		20		21		22		23		24	
P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
73	75	74	77	76	75	72	75	77	77	76	75	76	78	75	77
Dw	Dw	Dw	Dw	Dw	TY	TY	TY	wn	wn	wn	sb	sb	yn	yn	yn
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

(→) Suhu air panas tidak lebih dari 80°C (←) Suhu air panas tidak kurang dari 75°C

2.4.5.8 Lampiran Rekap Data Kehilangan Alat Makan

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	RUANGAN	NAMA ALAT	BUKTI KUITANSI	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang

8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah Azizah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Juni 2025							
Juli 2025							
1	04/07/2025	Ahmad Subandi	D7A-1	Sendok Makan			Sendok Hilang Px Pulang
2	06/07/2025	Lili Anita	B3C-6	Gelas			Memecahkan Gelas
3	11/07/2025	Eka Maulidia Sari	V3 (VVIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
4	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
5	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Garpu			Garpu Hilang Px Sudah Pulang
6	11/07/2025	Sophia Alya Khairani	B3C-4	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
7	20/07/2025	Arya Raka Pratama	C3C-7	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
Agustus 2025							
1	04/08/2025	Aisyah Bulan Jewel Gandhi	D3C-7	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
2	12/08/2025	Farieza Dayn Za-Zahra	D3B-2	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang

3	02/08/2025	Yusuf Al Barra Saputra	D3B-4	Gelas Pasien		Memecahkan Gelas, Pasien Pulang Tanpa Membayar
---	------------	------------------------	-------	--------------	---	--

Analisis :

- Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 kehilangan alat makan pada Bulan Agustus 2025.
- Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

Rencana Tindak Lanjut :

- Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
- Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

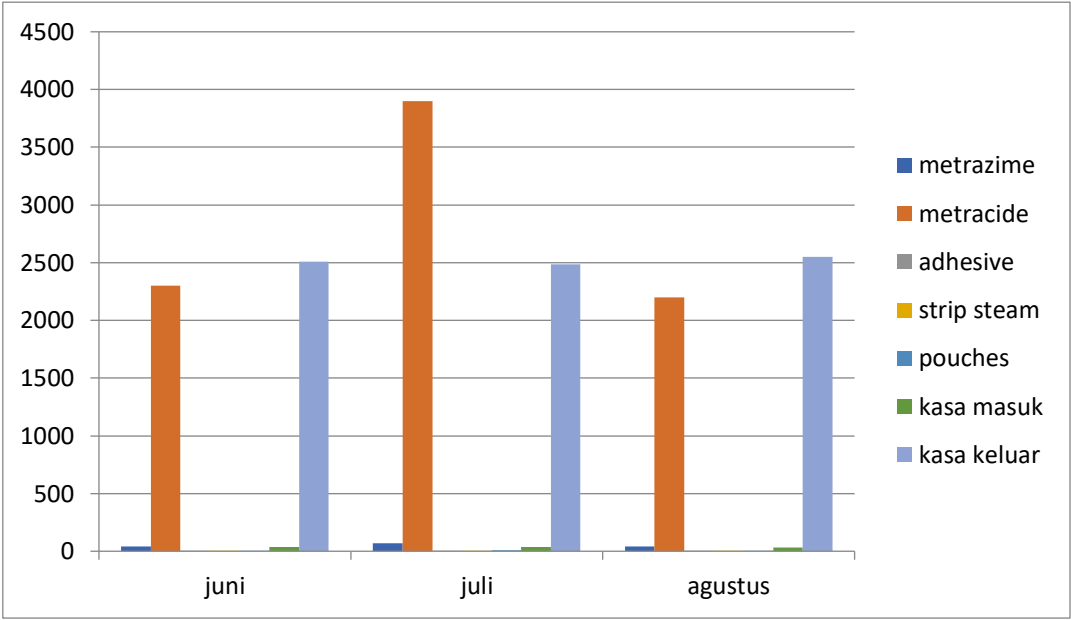
4.4.7 CSSD – Laundry

4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Agustus 2025

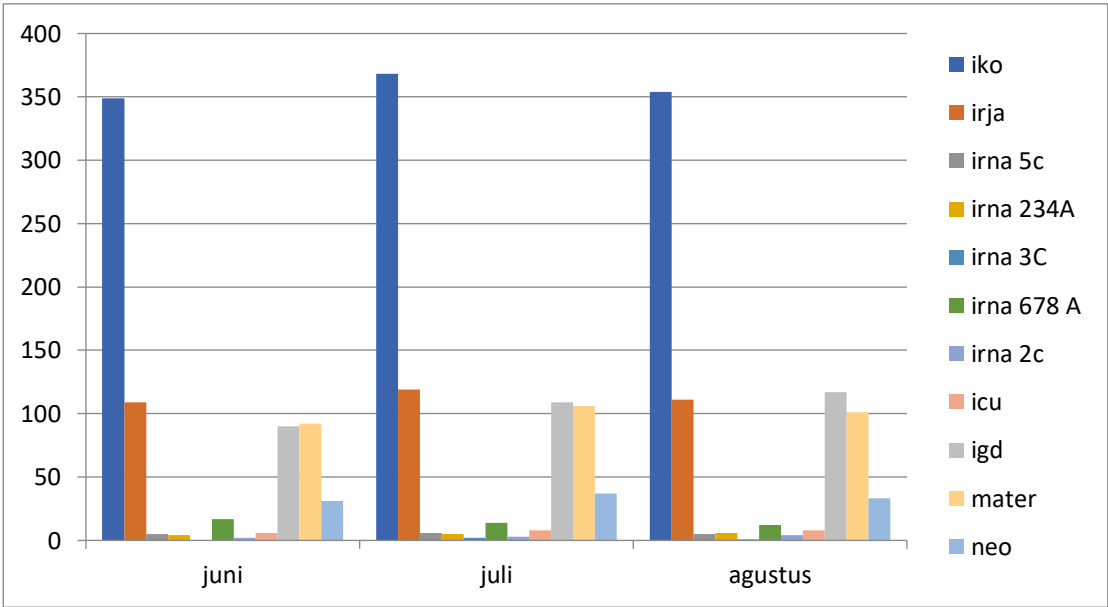
NO	HAL	BULAN TAHUN 2025		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	2300	2900	2200
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	41	43	40
3.	Kassa Masuk (roll)	38	35	32
4.	Kassa Keluar (pouches)	2500	2484	2550
5.	BHP Pouces (roll)	6	6	5
6.	Indikator Adhesive (roll)	3	3	1
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	349	368	354
9.	IRJA	109	119	111
10.	IRNA 5C	5	6	5
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	4	5	6
12.	IRNA 3C ANAK	0	2	1
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	17	14	12
14.	IRNA 2C VIP	2	3	4
15.	IRNA ICU	6	8	8
16.	IGD	90	109	117
17.	MATERNITAS	92	106	101
18.	NEONATOLOGI	31	37	33
Jumlah		705	777	742

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Juni - Agustus 2025



Analisis :

- 1. Pada bulan Agustus bhp yang mengalami peningkatan yaitu : metrazime , metracide, pouches, indicator strip, adhesive tape, kasa masuk
- 2. Untuk kasa keluar steril dan kasa masuk roll mengalami penurunan



Analisis :

- 1. Pada bulan agustus jumlah alat yang disetor di CSSD yang mengalami peningkatan yaitu: 234 A, 2 C dan IGD
- 2. Sementara Pada bulan Agustus alat yang disetor di CSSD yang mengalami penurunan yaitu lantai 6 7 8 A, 3 C, MATER, ICU, IGD, IRJA,5 C dan NEO

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
- 4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan AgustusTahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breating circuit	-

Analisis :
Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Agustus 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT		BULAN			JULI 2025	AGT 2025	TOTAL
		APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025			
		Kejadian Instrument Kurang					
IKO		1	4	1	2	-	8
IGD		0	0	0	0	-	0
IRNA		0	0	0	0	-	0
IRJA		0	1	0	0	-	1
		Kejadian Instrumen Hilang					
IKO		0	0	0	0	-	0
IGD		2	0	0	0	-	2
IRNA		0	0	0	0	-	0
IRJA		0	0	1	0	-	1

Analisis :
-

Rencana Tindak Lanjut :
-

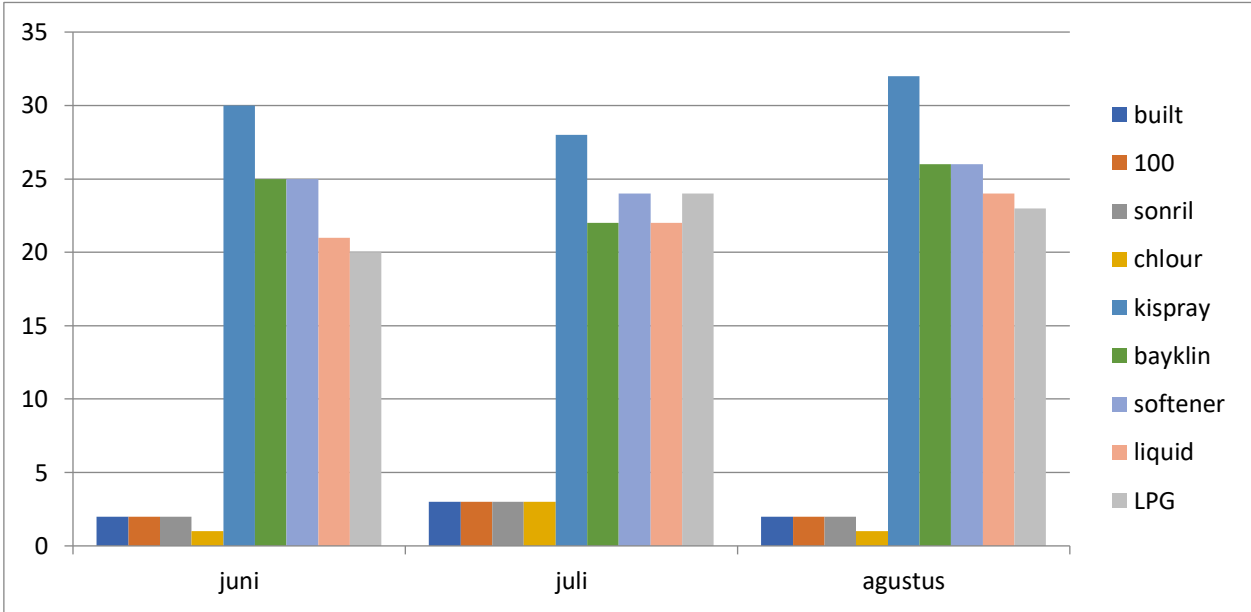
1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	HAL	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	3	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	3	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	2	3	2
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	3	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	30	28	32
6.	Pemutih Bayclean (liter)	25	22	26
7.	Softener (liter)	25	24	26
8.	Liquid matic (liter)	21	22	24
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	20	24	23
TOTAL		128	132	
LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksius	2266	2370	2401
2.	Linen Non Infeksius	1969	1983	2282
3.	IRNA 2,3,4 A	455	458	425
4.	IRNA 6,7,8 A	612	503	501
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	221	295	301
6.	IRNA 3C	226	413	399
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	275	326	345
8.	IRNA 5C	337	260	333
9.	IKO	1741	1713	1883
10.	IRJA	75	66	70
11.	IGD	187	216	206
12.	LABORATORIUM	7	8	5
13.	RADIOLOGI	7	4	4
14.	DAPUR/GIZI	7	4	4
15.	CSSD	13	8	9
16.	Linen MS	69	62	73
17.	Umum	3	21	125

Total	4235	4353	9366
-------	------	------	------

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Juni - Agustus 2025

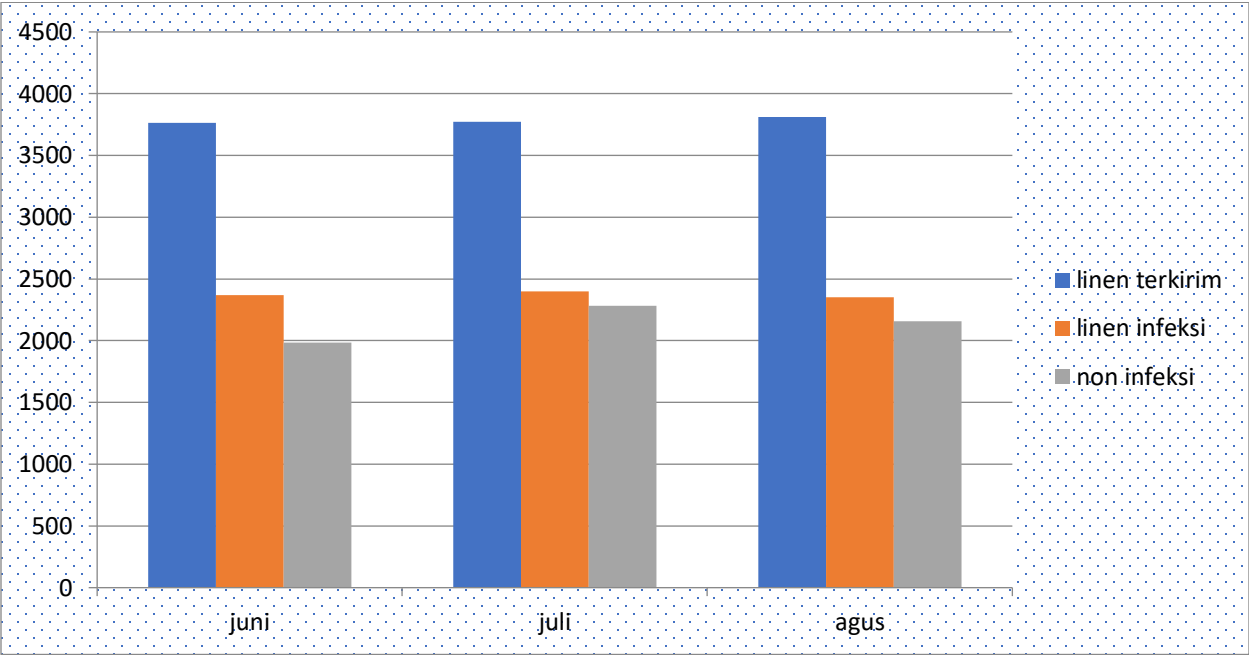


Analisis :

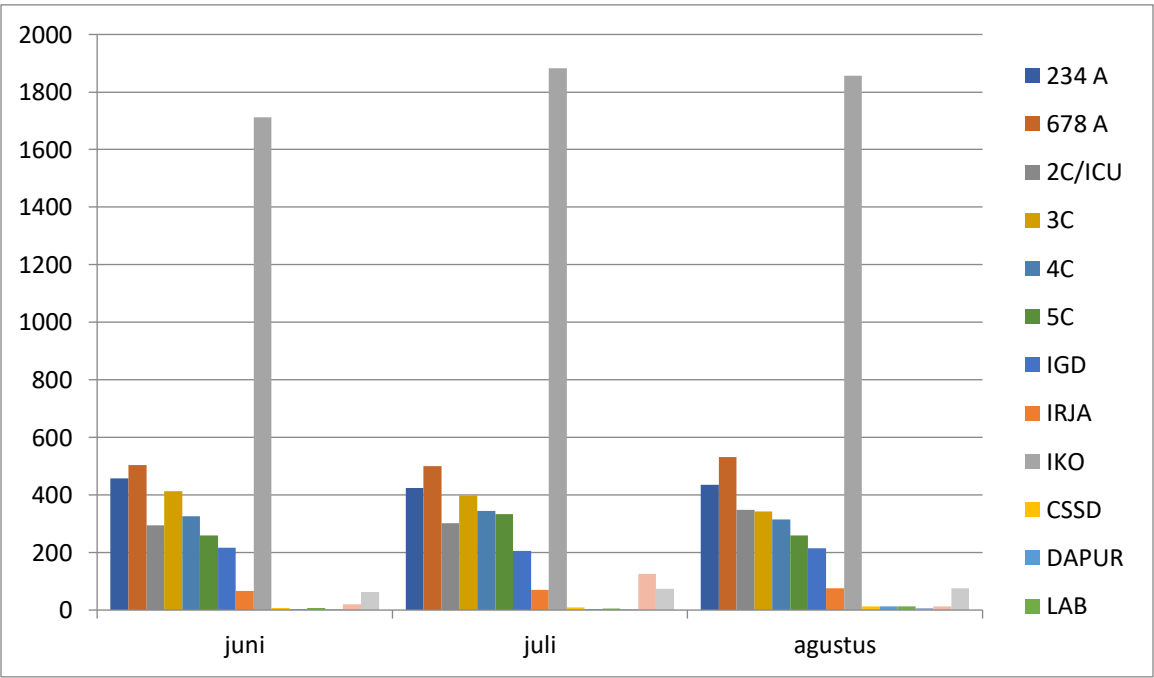
1. Pada bulan agustus BMHP yang mengalami penurunan pemakaian yaitu : clax built lite, clax 100, clax sonril, clax neutral (tidak ada permintaan dari RSDH), dan gas LPG
2. Pada bulan agustus pemakaian chemical yang meningkat yaitu; softener bayklin kispray dan liquid

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.



- Analisis :**
- 1. Terjadi peningkatan di linen terkirim dari 3773 ke 3811
 - 2. Untuk linen infeksi dari 2401 ke 2352
 - 3. Untuk linen non infeksi dari 2282 ke 2157



- Analisis :**
- 1. Linen IKO mengalami penurunan dari 1883 ke 1856
 - 2. Linen IRJA di bulan juli mengalami peningkatan pemakaian APD dari 70kg ke 75 kg
 - 3. Linen IRNA di bulan juli mengalami peningkatan yaitu lantai 234 A, 678 A, 2C/ICU, 5C sementara lantai 4 C, Dan 3 C menurun
 - 4. Linen kotor IGD juga meningkat, penggunaan linen selimut di IGD meningkat
 - 5. Terjadi penurunan di cucian umum sebesar 12 kg yaitu korden

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Juli 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	Sprei	160	142	133
2.	Sarung bantal	276	265	253
3.	Selimut	178	170	164

4.	Baju tim IKO	110	110	110
5.	Baju ganti pasien	37	36	33
6.	Skort	148	145	145
7.	Perlak	22	19	18
8.	Baju ganti laundry	14	14	14
9.	Duk lubang besar	20	20	20
10.	Duk pembungkus	56	54	53
11.	Duk kecil 1 meter	50	45	43
12.	Duk ortho	15	14	14
13.	Duk lubang kecil	17	17	17
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	20	20	19
16.	Skort IKO	61	61	61
17.	Waslap	59	55	55
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	129	126	123
20.	Baju Pasien	30	28	25

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Juli 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	Sprei	45	18	11
2.	Sarung bantal	35	11	10
3.	Selimut	17	8	8
4.	Duk Pembungkus	0	2	0
5.	Duk Lubang Kecil	0	5	0
6.	Celana Tim IKO	3	0	1
7.	Baju Tim IKO	3	0	1
8.	Baju Pasien	7	1	2
9.	Skort	2	3	0
10.	Perlak	9	3	4
11.	Baju Ganti Laundry	1	0	1
12.	Duk Kecil	0	5	7
13.	Waslap	5	4	0
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	2	3	2
16.	Kerudung	0	0	2
17.	Kantung L	0	0	0
18.	Meja Mayo	0	0	1
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025	Dijadwalkan 6 bulan sekali	Dijadwalkan 6 bulan sekali

Analisis :

- 1. Untuk linen rusak bulan agustus yaitu jenis spre, sarban, selimut, duk kecil, baju pasien, perlak, duk pembungkus dan meja mayo
- 2. Sprei, sarban dan selimut rusak karena terdapat noda yang membandel dan sudah dilakukan spoting berulang

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Follow up Pengadaan PT
- 2. Jadwal pemusnahan linen selanjutnya pada Bulan Juli 2025

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	Masker IKO	2	1	3
2.	Tissue	2	4	2
3.	Jarum	1	0	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	0	0
7.	Benda lainnya	1 (selang oksigen)	1 (selang oksigen)	0 (selang oksigen)

Analisis :

- 1. Benda asing yang sering tercampur Di linen kotor yaitu, masker dari IKO, tissue , selang oxygen, instrument bedah IKO
- 2. Ketidakdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
- 3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
- 2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.4.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	0	0	0	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0

10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0

		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	1	0	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		11	7	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0

30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0

		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			430	430	282	148	0

Keterangan :
Pada bulan Agustus akhir terdapat 1 staf SDM resign.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Nabila Rizki Amalia, S. Tr. Kes	Analisis Kesehatan	04 Juli 2025	SIP terbit
2	dr. Kezia Berlianti Rukmana	Dokter IGD	06 Agustus 2025	SIP terbit
3	Siti Sulistiowati, Amd. Farm	TTK	11 Agustus 2025	Pembaruan SIP
4	dr. Andira Aulia Rahma	Dokter IGD	Juli 2025	Pencabutan SIP
5	dr. Sheila Dyah Prasetyo	Dokter Casemix	Juli 2025	Pencabutan SIP
6	Ica Anindya P., S. farm., Apt	Apoteker	Juli 2025	Pencabutan SIP
7	Rizky Dinda M., Amd. Kep	Perawat	Juli 2025	Pencabutan SIP
8	Fakhrur Rifqi A., S. Kep., Ns	Perawat	Juli 2025	Pencabutan SIP
9	Octa Fitri Muazizah, S. Tr. Kep	Perawat	Juli 2025	Pencabutan SIP
10	Rina Tri Wahyuni, Amd. RMIK	Perekam Medik	Juli 2025	Pencabutan SIP
11	dr. Ageng Sunjoyo, Sp. An-Ti	Dokter Anastesi	Juli 2025	Pencabutan SIP
12	Prima Dio Prasajo, S. Tr. Kep	Perawat	Juli 2025	Pencabutan SIP
13	Gusti Naila R. G., S.Tr.Kes	Analisis Kesehatan	Juli 2025	Pencabutan SIP
14	Aulia Rahmatul A., Amd. Kep	Perawat	Juli 2025	Pencabutan SIP

Keterangan :
Pada bulan Juli terdapat 1 SIP terbit dan 11 proses pencabutan SIP bagi staf resign dan mutasi. Sedangkan untuk bulan Agustus terdapat 2 SIP baru terbit untuk dokter baru dan perpanjangan SIP

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1.	08 Agustus 2025	Orientasi khusus	dr. Kezia	Profesi Dokter Umum	Dokter Umum	08 Agustus 2025	Orientasi berakhir 07 September 2025

Keterangan :
Pada bulan Agustus 2025 tidak ada staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK
1	Diklat BHD untuk Tim Code Blue dan IGD	Internal unit tertentu	21	6	12 dan 28 Agustus 2025	v	
2	Diklat Medication Eror	Inetrnal unit tertentu	173	0	19 Agustus 2025	v	
3	Diklat Kegawat Daruratan Neonatus	Inetrnal unit tertentu	27	33	15 Agustus 2025	v	
4	Diklat SKP	Internal All Staf	261	47	26 Agustus 2025	v	

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

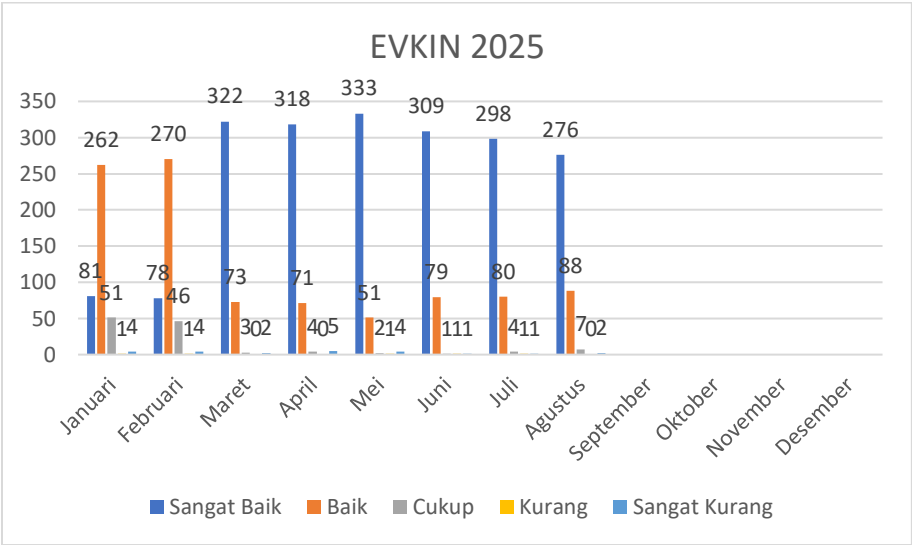
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	0	24	14	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	8	2	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	2	3	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	17	0	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	8	4	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	24	0	17	7	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRs	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	22	4	1	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	6	0	6	0	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	15	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	13	0	10	3	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	5	3	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	14	6	1	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	6	2	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	9	0	3	6	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	9	0	8	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	5	2	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	15	0	11	4	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	5	2	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	2	0	1	1	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	1	2	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	44	6	0	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	10	0	2	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Juli 2025.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan

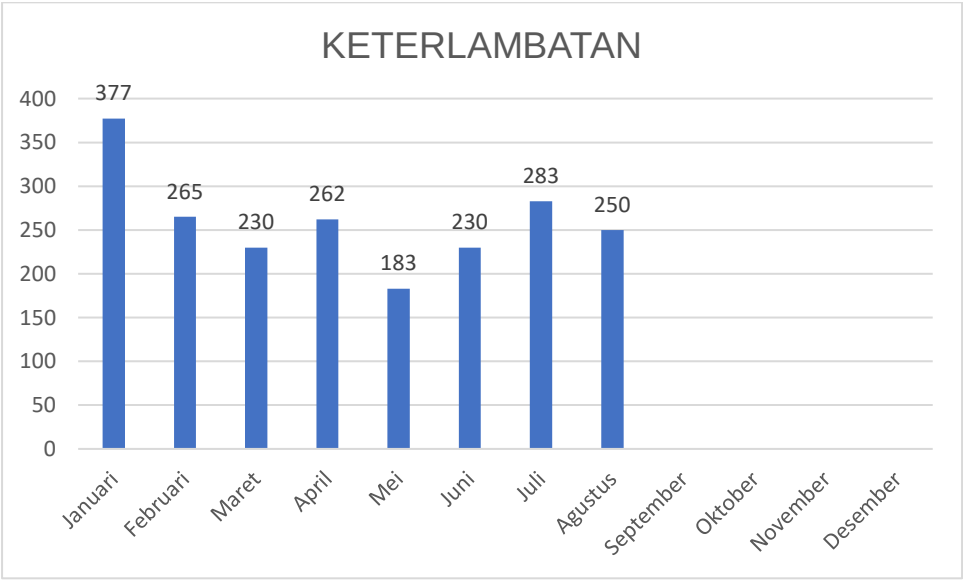


Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309	298	276				
Baik	262	270	73	71	51	79	81	88				
Cukup	51	46	3	4	2	1	4	7				
Kurang	1	1	0	0	1	1	1	0				
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1	1	2				
TOTAL	399	399	400	398	391	391	385	373				

Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

- Rencana Tindaklanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230	283	250				



Analisa :
Secara umum terdapat kenaikan keterlambatan karyawan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	1	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	1	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	1	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0

23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	1	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	3

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan karir telah dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%	100%	0%	100%				

Analisaais:
 Telah terlaksana supervise oleh SDM. Dilaksanakan pada tanggal 9 dan 22 Agustus Dilakukan mandiri ke tiap unit. Masih ditemukan staf yang tidak patuh kelengkapan atribut kerja (nametag dan kerapian rambut) 2025.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Sisca Puspita Sari, S.Kep., Ns	IRNA 2C RS PHM	Plt Kabid Pelayanan Medis RS PHS
2	Cindytya Andrawina, S.Kep., Ns	PIPP RS PHM	PJ IRNA RSDH
3	Very Susanto, S.Kep., Ns	Kabid Keperawatan RS PHM	Karu IGD RS PHM
4	Putri Indah Purnamasari, S.Kep., Ns	Plt Kabid Penunjang Medis RS PHM	PIPP RS PHM

Analisis : pada bulan Agustus 2025 terdapat 4 mutasi / rotasi staf.

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruang	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74	69.2%	82.05%	64.10%				

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%
Juli	276	166	60.14%
Agustus	276	194	70%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15
Juli	25
Agustus	29

Analisa :
Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 64.10% dan jumlah alat 70%. Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuatif adalah alat medis masih dipakai oleh pasien (Irna), ruangan atau unit masih ada tindakan pasien (OK). Bulan agustus terdapat agenda kalibrasi alat sehingga capaian ruangan lebih menurun karena atem mendampingi vendor.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61
APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI	15	21	12	48
AGUSTUS	3	4	16	23
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :
Pada Awal Juni dengan adanya instruksi untuk perbantuan maintenance seluruh AC di 3 klinik Mutiara Sehat membuat pelaksanaan maintenance AC dari tim IPSRS bertambah. akan dilakukan pemetaan kembali terkait target maintenance AC dan pembuatan system monitoring dan evaluasi. Bulan ini sebagai evaluasi untuk perubahan pedoman penjadwalan maintenance di bulan agustus.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbs_oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3I7_SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497
4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAYz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwtuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Agustus 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/08/2025	2460	2240	220	MMHG			MMHG
02/08/2025	2240	1982	258	MMHG			MMHG

03/08/2025	1982	1349	633	MMHG			MMHG
04/08/2025	1349	3234	0	MMHG	sesudah pengisian	1885	MMHG
05/08/2025	3234	2959	275	MMHG			MMHG
06/08/2025	2959	2641	318	MMHG			MMHG
07/08/2025	2641	2324	317	MMHG			MMHG
08/08/2025	2324	2076	248	MMHG			MMHG
09/08/2025	2076	1842	234	MMHG			MMHG
10/08/2025	1842	1396	446	MMHG			MMHG
11/08/2025	1396	3296	0	MMHG	sesudah pengisian	1900	MMHG
12/08/2025	3296	2988	308	MMHG			MMHG
13/08/2025	2988	2743	245	MMHG			MMHG
14/08/2025	2743	2511	232	MMHG			MMHG
15/08/2025	2511	2277	234	MMHG			MMHG
16/08/2025	2277	2025	252	MMHG			MMHG
17/08/2025	2022	1565	457	MMHG			MMHG
18/08/2025	1565	3165	0	MMHG	sesudah pengisian	1600	MMHG
19/08/2025	3165	2813	352	MMHG			MMHG
20/08/2025	2813	2548	265	MMHG			MMHG
21/08/2025	2548	2265	283	MMHG			MMHG
22/08/2025	2265	2005	260	MMHG			MMHG
23/08/2025	2005	1759	246	MMHG			MMHG
24/08/2025	1759	1039	720	MMHG			MMHG
25/08/2025	1039	3190	0	MMHG	sesudah pengisian	2151	MMHG
26/08/2025	3190	3102	88	MMHG			MMHG
27/08/2025	3102	2828	274	MMHG			MMHG
28/08/2025	2838	2535	303	MMHG			MMHG
29/08/2025	2535	2285	250	MMHG			MMHG
30/08/2025	2285	2044	241	MMHG			MMHG
31/08/2025	2044	1822	222	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8181	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						7536	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			544.6785714	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3014.4	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fuh93fV8dr-elBhq4_WnFYCEM3i7Q8OnspbTdrherYs/edit?gid=1709907740#gid=1709907740

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
---------	----------	----------	------	-----------------------

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link <https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wmsJe6qBbbD63O5DgfOA6YujFNommAsXIHIsi0g3o0/edit?gid=289224812#gid=289224812>

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapitan Kegiatan External

BULAN	JUMLAH KEGIATAN (HARI)
Januari	4
Februari	4
Maret	4
April	15
Mei	12
Juni	15
Juli	6
Agustus	12

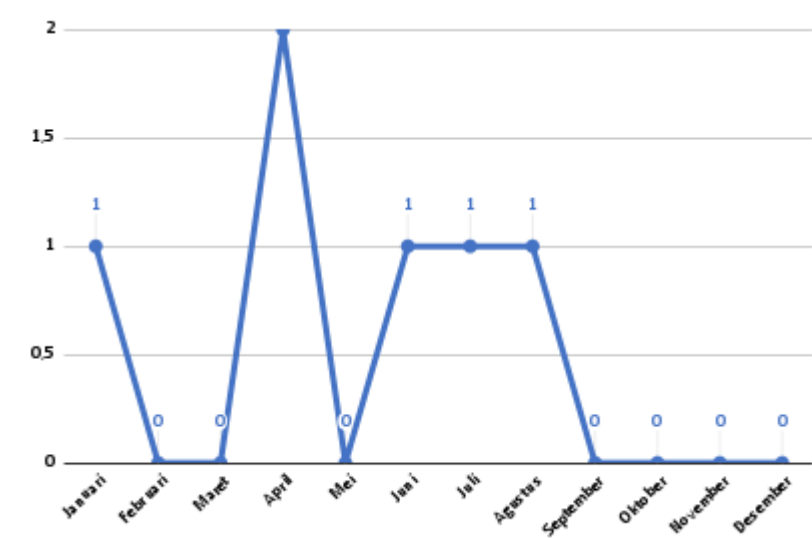
Keterangan :
Perbantuan eksternal ke instansi lain pada bulan ini adalah 10 Mutiara Sehat, 2 RSDH Probolinggo

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1	1	1			

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



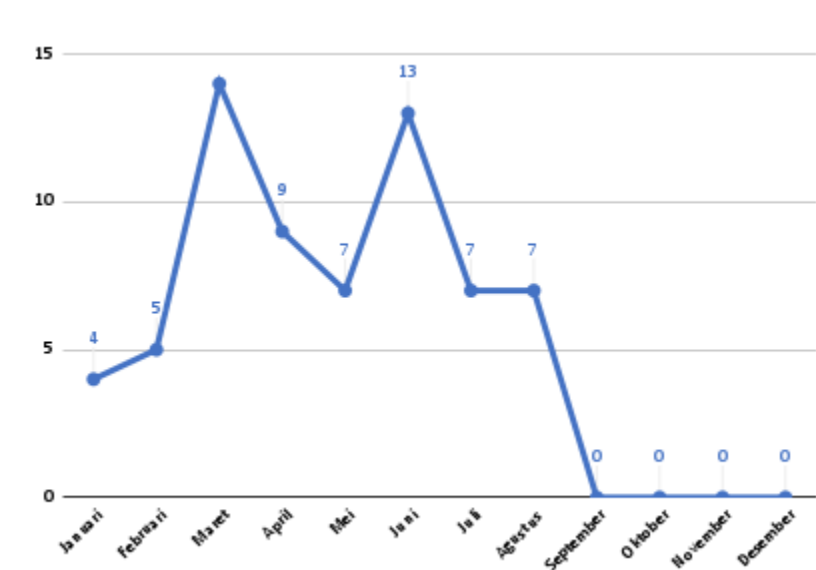
Analisa :
Pada tanggal 31 – 08 – 2025, ditemukan selendang bayi di area Gedung poli spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13	7	7			

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
03 – 08 – 2025	Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
04 – 08 – 2025	Kunci motor milik pegunjung menancap di sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
12 – 08 – 2025	Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
`12 – 08 – 2025	Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
18 – 08 – 2025	Telah ditemukan sejumlah uang di area depan radiologi diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
`20 – 08 – 2025	Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
`21 – 08 – 2025	Kunci motor menancap milik karyawan di sepeda motor diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

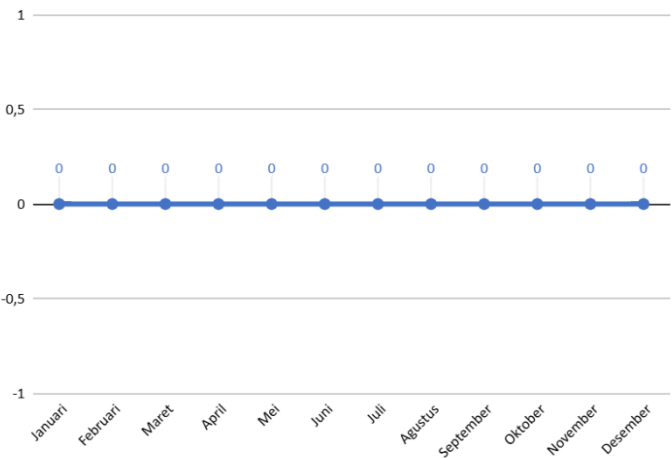
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



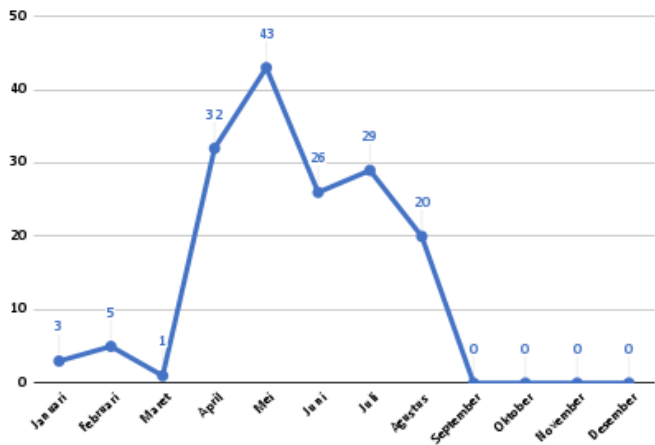
Analisis :

Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45	26	29	20				



Analisis :

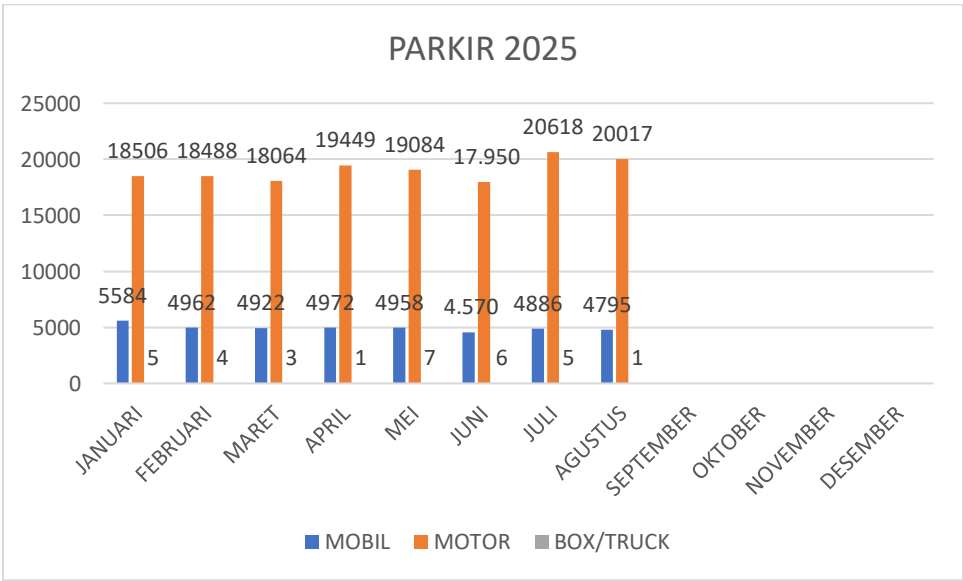
Angka 29 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x. Beberapa factor yang mempengaruhi, posisi kursi taman pot depan IGD yang tidak dapat diberi tulisan dan menjadi tempat makan. Patroli security yang regular sering terlewat karena saat ada patrol memang tidak terpantau ada perokok.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

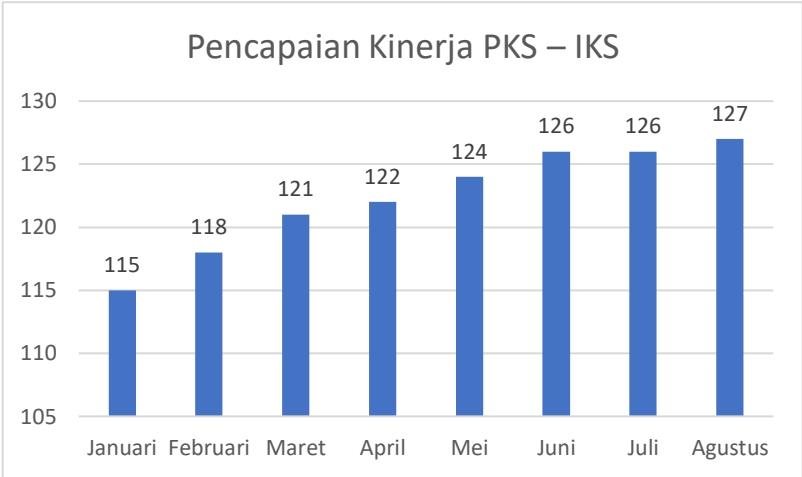
3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	(review pihak kedua) 1 (105lastic105 evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
7	Juli 2025	1 IKS Baru	126	1	0	0	1 (Proses Review)	1
8	Agustus 2025	1 IKS	127	1	0	1	1 (Klinik Utama Kedungdoro)	1
Analisis ; - Pada bulan Agustus 2025, Perpanjangan PKS dengan Pihak Asuransi BRI Life dan Klinik Utama Kedungdoro - Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : - Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Juli 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak	Proses pihak Dispenduk

		sekda)	
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Proses Pihak Kedua
13	RS Panti Nirmala	Review	Proses Review
14	BRI Life	Review	Proses
15	Klinik Utama Kedungdoro	Review	Proses



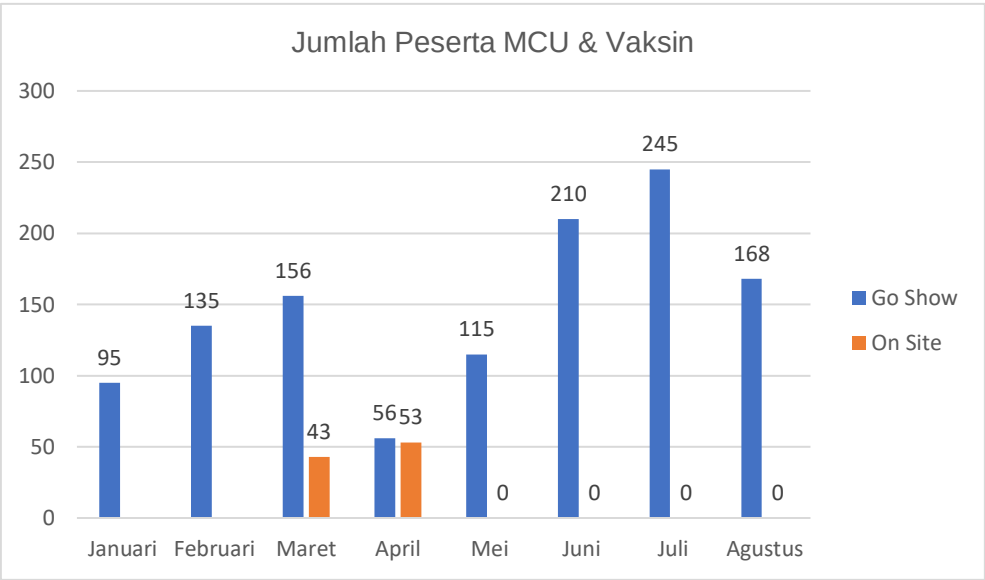
3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Agustus 2025

NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150	210	-
7	JULI	150	254	
8	AGUSTUS	150	168	
9	SEPTEMBER	150		
10	OKTOBER	150		
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;
 Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Agustus Menurun 33.86% dari bulan Juli

Rencana Tindak Lanjut :
 1. Melakukan Promosi rutin melalui Social Media dengan update berkala
 2. Kunjungan ke SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
7	Juli	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Marine	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
8	Agustus	PT Arjaya Mukti Santosa	Sudah terlaksana 4 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2	17	6	6			

Analisa :
Kunjungan eksternal disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada beberapa target klinik dan mitra. Untuk kegiatan umum seperti pengenalan RS dll sudah dilakukan di akhir Juli FKTP Gathering.

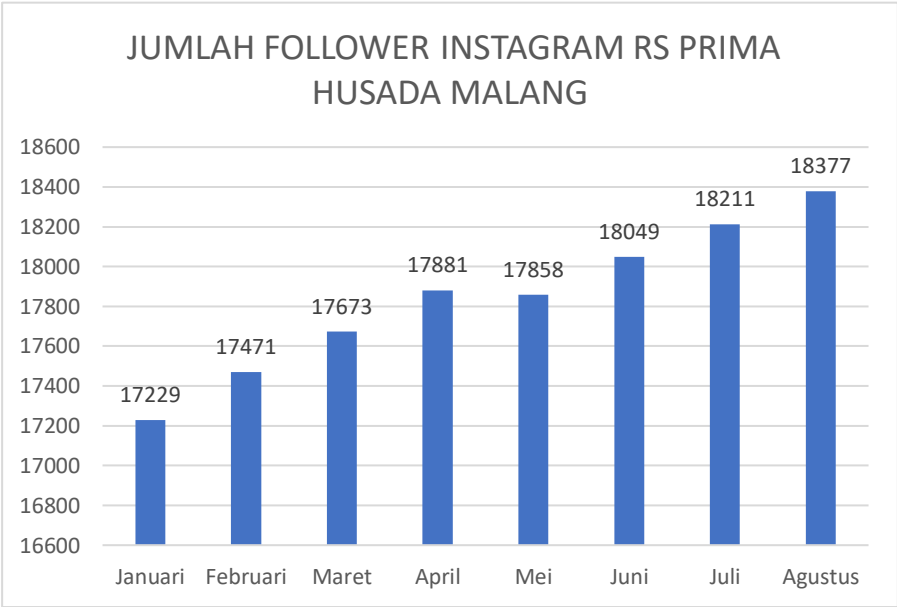
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala.

1.5.5.2.4 Digital Marketing
1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10	9	10	8				
REELS	5	5	11	5	1	1	6	7				
STORY	6	10	14	8	12	10	18	11				
TOTAL	14	22	34	28	23	19	34	26	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10	12	14	8				
FEED VIDEO	0	0	0	0	1	1	6	7				
REELS	3	4	5	7	1	1	6	7				
STORY	29	33	28	38	12	29	74	24				
TOTAL	38	48	49	64	24	20	100	46	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850	18049	18.211	18.377				
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	286	346	283	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

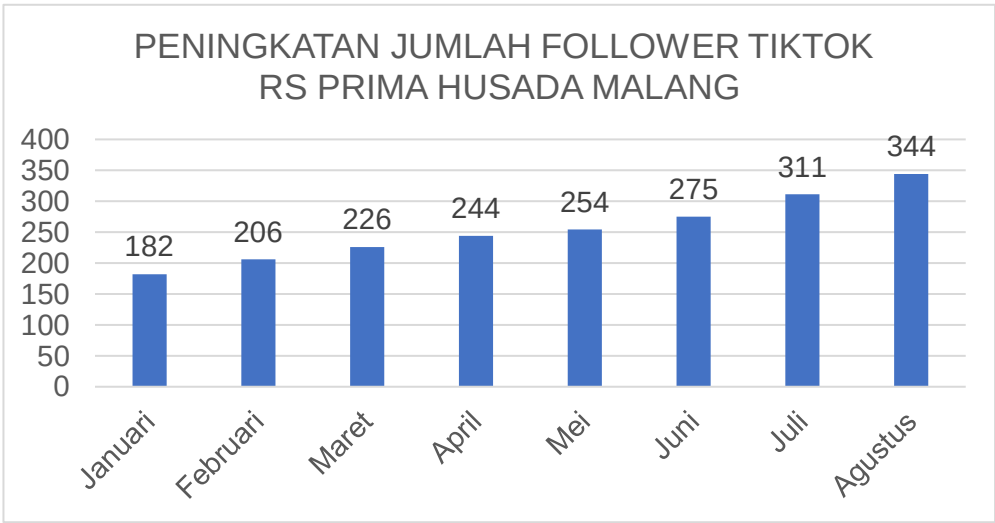


Analisa :
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0,91%. dari bulan Juli

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2	1	3	3				
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254	275	331	344				
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	21	36	33	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187	1222	1336	1476				



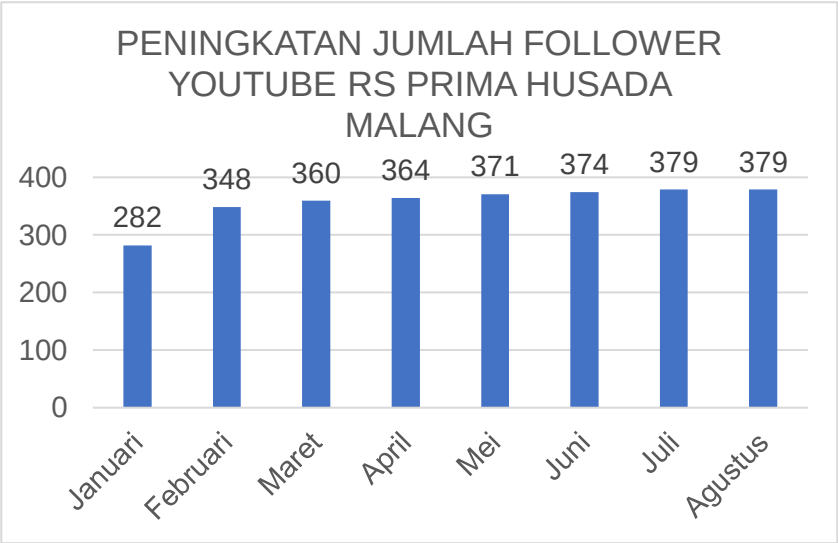
Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 10,61% dari bulan Juli

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0	0	0	0	0				
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371	374	379	379				

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	7	3	5	0	0	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

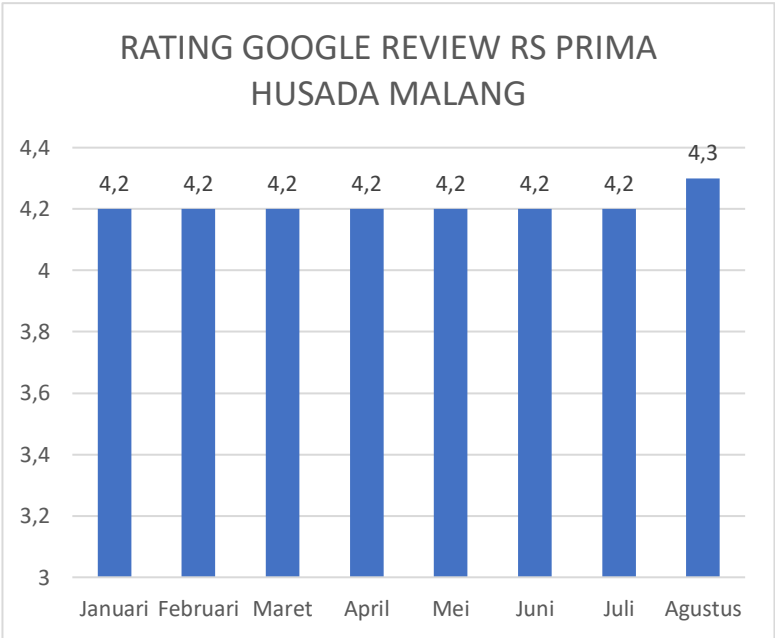


Analisa :
 Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan Juli

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3				



NO	BULAN	KOMENTAR POSITIF	KOMENTAR NEGATIF
1	Jan-25	18	6
2	Feb-25	13	6
3	Mar-25	7	5
4	Apr-25	25	10
5	May-25	15	7
6	Jun-25	19	3
7	Jul-25	60	3
8	Aug-25	44	10
9	Sep-25	0	0
10	Oct-25	0	0
11	Nov-25	0	0
12	Dec-25	0	0

Analisa :

1. Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin dari bulan Juli
2. Mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan, kepuasan pasien yang lebih tinggi, dan/atau perbaikan dalam manajemen keluhan.

Rencana Tindal Lanjut :

Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

IC	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	c	(a.b.c=d)	e	f	g	(e.f.g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE AGUSTUS 2025 :																
1	Asuransi	271.264.613	122.807.801	3.846.090	144.610.721	343.138.306	42.915.586	883.182	299.339.618	443.950.339	384.552.408	22.228.730	9.819.722	10.984.477	16.445.003	443.950.340
2	Perusahaan	627.695.575	430.482.913	308.622	196.904.940	328.069.104	1.028.000	-	327.041.104	523.946.044	433.299.946	414.900	26.267.771	243.604	64.730.824	523.946.044
3	Idandiri Inhealth	78.702.520	29.992.891	1.356.919	47.352.719	44.173.592	-	-	44.173.592	91.526.312	75.797.400	15.364.872	-	-	372.039	91.526.312
4	Lisa Raharjo	27.002.418	26.981.500	-	920.918	146.621.732	145.750.966	0	870.768	1.791.685	876.162	-	-	-	920.917	1.791.685
5	BPJS Ketenagakerjaan	669.243.374	643.921.710	989.731	24.331.932	606.739.391	-	-	606.739.391	631.071.324	407.729	-	-	22.038.219	608.635.376	631.071.324
Total Saldo											1.692.285.704	1.527.660.032	23.299.836	33.704.717	7.048.648	1.692.285.704

Keterangan : Cut off 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.692.285.704

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Data anomali di KC Malang penagihan tertinggi dengan typoid yaitu RSPH yang penagihannya 300x dari FKRTL lain, jika benar di RSPH dengan typoid, maka KLB tidak dijamin JKN	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Reseleksi kode DU.terdapat penegakan diagnosa DU A01	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Ukuran batu & lt; 1 cm dan tanpa densitas => tidak ada indikasi lithotripsy sesuai PNPk	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Tidak sesuai standar pelayanan, indikasi N39.0	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

	dirawatinapkan jika dilakukan kultur, dan lebih spesifik		
5	Pasien pneumonia LOS < 4 HARI, SESUAI DENGAN PNPK TERAPI INJEKSI ANTIBIOTIK MINIMAL 72JAM	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Tidak sesuai standar pelayanan, tindakan 2207 (pterygium), diajukan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Readmisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Rujuk dihari yang sama klaim rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Konfirmasi cara pulang	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

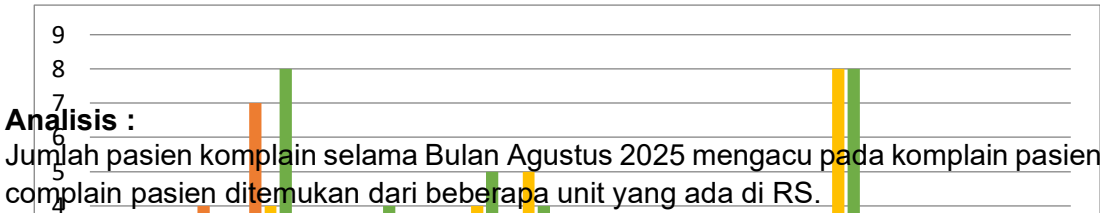
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Agustus 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	IRJA	2	2	1
2.	IRNA	1	0	0
3.	IFRS	4	1	2
4.	UMUM	7	4	8
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	1	1
6.	PERAWAT / BIDAN	0	1	4
7.	KASIR	0	0	1
8.	GIZI/DAPUR	0	4	5
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	5	4
10.	DOKTER IGD	3	0	0
11.	IGD REGULER	2	0	2
12.	SECURITY	0	0	2
13.	PARKIR	3	2	3
14.	PENUNJANG	0	1	1
15.	FASILITAS RS	3	8	8
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		27	29	42

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Agustus 2025



Analisis :
Jumlah pasien komplain selama Bulan Agustus 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Agustud 2025 Meningkat dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan juni sebanyak 27 pasien, pada bulan Juli 2025 sebanyak 28 pasien Sedangkan pada bulan agustus 2025 sebanyak 42 pasien
2. Komplain terbanyak pada bulan Agustus 2025 yaitu dari bagian UMUM dan fasilitas RS sebanyak 8 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 4 kasus complain dengan rincian :
 - a) Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 - b) Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perlebar ruangan rawat inap dan perbaharuan kamar mandi.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

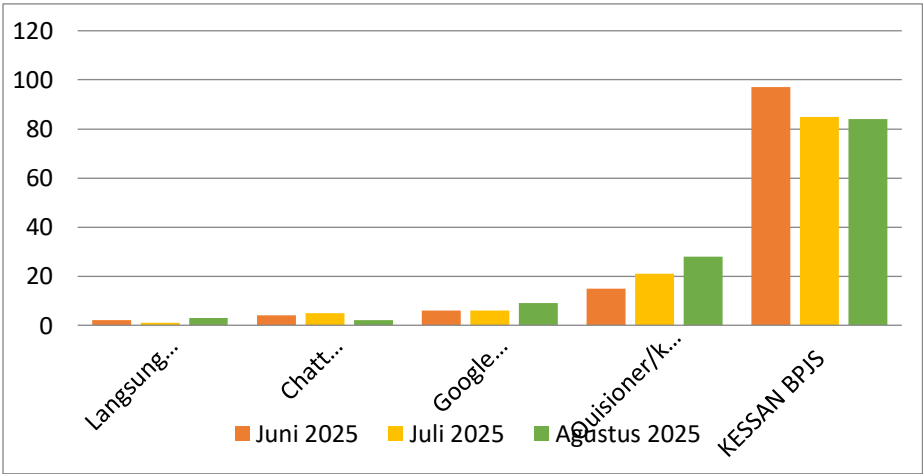
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Agustus 2025

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	Langsung tatap muka	2	1	3
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	4	5	2
b	Google reviuw	6	6	9
3.	Quisioner/kolom kritik saran	15	21	28

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Agustus 2025



Analisis :

Pada bulan Agustus 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 28 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari Google viuw sebanyak 9 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juli 2025

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google review	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	60%	40%	0
					24	4	
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0
	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Agustus 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 4 kasus complain dengan rincian :

- 1) Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
- 2) Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perlebar ruangan rawat inap dan perbaharuan kamar mandi.

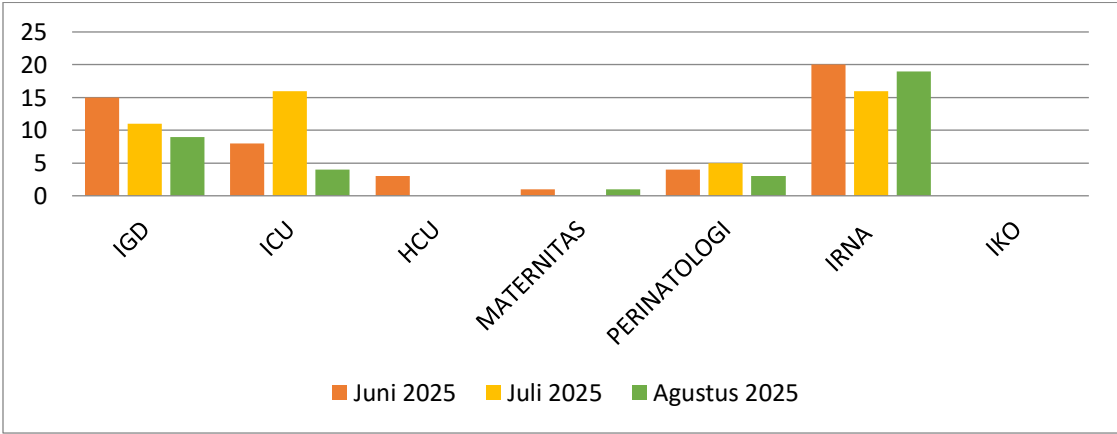
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Agustus 2025

NO	UNIT PERUJUK	JUNI 2025	JULI 2025	JULI 2025
1.	IGD	15	11	9
2.	ICU	8	16	4
3.	HCU	3	0	0
4.	MATERNITAS	1	0	1
5.	NEONATOLOGI	4	5	3
6	IRNA	20	16	19
7	IKO	0	0	0
Total		33	51	48

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Agustus 2025



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Agustus 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAYON HABIS
1	Ny. Sri Wahyuni	IRNA	Necrotizing Fascitis humerus bracialis Dex post op excisional debridemant, Ulkus decubitus pedis + gluteus, DOC ec septis condition, AKI, Sepsis	dr. Anton, Sp. B Konsul dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	Pro Bedah Umum/ TKV	6	TIDAK
2	Tn. Jarwoto	ICU	Post GEA dehidrasi berat, sepsis MODS, shock septic	dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	pro Perawatan lanjutan, Sepsis belum teratasi dengan pemberian meropenem, pertimbangan eskalasi pemberian AB berdasarakan hasil kultur darah. RSPH tdk tersedia pemeriksaan kultur darah	6	TIDAK
3	By. Ny. Nur Aini	NEO	1. RDS 2. Neonatal bronchopneumonia	dr. Dicky, Sp. A	RS Lavalette	pro subspesialis konsultan neonatologi	3	TIDAK
4	By. Ny. Wikke Vara Mariskha	NEO	RDS, Neonatal bronchopneumonia, imatur	dr. Fiona, Sp. A	RS Lavalette	pro subspesialis konsultan neonatologi	2	TIDAK
5	Tn. Novi Candra Irawan	IRNA	Fistel enterocutan Post laparotomy drainage ec peritonitis + multiple perforasi + frozen	dr. Zaki, Sp. B	RSSA	Bedah Umum Pro perbaikan KU kp relaparotomy	6	Total rs : 11.615.134 Plavon : 6.274.500

			intestine					Minus : 5.340.634
6	ny.siti sulaehah	IRNA	Sinus Cavernosus Syndrome dt Susp Trombosis Sinus Cavernosus dd Aneurisma dd SOP	dr. fahimma Sp.N	RSSA	pro CTA,CTV	2	TIDAK
7	Tn. Laseri	IRNA	susp. tetanus generalisis grade 2	dr. Anton, Sp. B	RSSA	Pro isolasi tetanus	2	TIDAK
8	Tn. SUGENG MESELAN	IGD	sirosis hepatoma asites	dr. ARDHI,SP.PD	RSSA	Pro Pemeriksaan lebih ke arah onkologi	1	TIDAK
9	Sdr. SAFRIN HANIDAR	NEO	paraplegi electrolit inbalance	dr. FARID SP. S , KONSUL DR. EKO SP. KFR , KONSUL DR. HUDA SP. KJ	RSJ	Pro UGD RSJ (F06.8 GANGGUAN MENTAL ORGANIK)	4	TIDAK
10	By. Ny. Nur Fitri Lestari	NEO	Pneumonia, RDS, BBLR	dr. Dicky, Sp. A	RSSA	pro subspesialis konsultan neonatologi	2	TIDAK
11	Tn. Lutfiyanto	IRNA	* Faty Liver, * Multiple Cholelithiasis, * poliposis Vesica Felea , Nephrolithiasis	dr. Ard hany. Sp.PD	RSSA	Pro Perawatan SpPD- KGEH pertimbangan ERCP	6	TIDAK
12	NY. ROSA NATALIA AZIZ	IRNA	CVA infark + dm +Hipernatremia	dr. Farid sp. S konsul dr.Ardhany sp.pd	RS lavalet	Pro unit stroke	1	TIDAK
13	NY. RUBAIAH	IRNA	Paraplegi Inferior	dr Farid Sp S	RSSA	Pro MRI Thoracolumbalis	3	TIDAK
14	Nn. Nafisa Syifa Aulia	IRNA	susp internal bleeding e.c KET (hasil USG obgyn massa adnexa kanan 8 x 5 cm susp KET dgn internal bleeding	dr. Zora Sp PD konsul dr Humaira, Sp.OG	RSSA	Pro laparatomy cito dengan backup tranfusi TC dan perawatan ICU	4	TIDAK
15	Tn. A Dariono	IRNA	.DOC DT HEPATIC ENCELOPATHY WH GRADE III-IV DD HIPOXIC ENCEPHALOPATHY	dr. Aji sp. pd	RSSA	pro kolonoscopi dan perawatan KGEH	9	TIDAK
16	Ny ANIS ANDAYANI	IGD	Prolong Fever ec B20	dr. Heri sp. pd	Lavalate	pro ruang isolasi dan pengobatan ARV	2	TIDAK
17	Ny. NURUL LAILA	IGD	susp pneumoni, B20	dr. Elvi, Sp. P	Lavalate	pro ruang isolasi dan pengobatan ARV	2	TIDAK
18	Ny. Atim	ICU	Post Coma Hipoglikemia	dr. Ardhi sp pd	RST Soepraoen	pro Perawatan lanjutan, Sepsis belum teratasi dengan pemberian meropenem, pertimbangan eskalasi pemberian AB berdasarakn hasil kultur darah. RSPH tdk tersedia pemeriksaan kultur darah	2	TIDAK
19	Tn. KHOLIM	IGD	Open Fracture Cruris Sinistra suspek Gustillo Anderson Grade IIIC	dr Arianto, Sp.OT	RSSA	Pro tindakan operasi CITO	1	TIDAK
20	Ny. HADI PRAYITNO	ICU	CVA Emboli onset H-3	dr. Ira Sp. JP konsul dr Dewi, Sp.S	RSSA	pro Stroke unit	3	TIDAK
21	Tn. Moch. Alwi	ICU	COS, ICH Frontal, pneumocephalus, edema cerebri	dr Fachriy Sp BS	RSSA	kebutuhan alat khusus	2	TIDAK
22	Tn. Ghufron	IRNA	susp Tetanus Generalisata Grade II	dr Zaki Sp B	RSSA	Pro ruang isolasi tetanus	2	Tidak
23	An. Fathima Az zahra	IRNA	Anemia	dr Dicky Sp A	RST Soepraoen	Pro subspesialis	3	Tidak
24	Tn. SUJA'I	IRNA	ALO kardiogenik	dr. Mira.Sp.Jp	RS Aisiyah	pro Immedate invasive strategy	1	TIDAK
25	Ny. Atmina	IRNA	DM tipe 2	dr. Aji, Sp.PD	RS Lavallete	Pro HD dan perawatan KGH	5	TIDAK
26	Ny.RIYANTI	MTS	P2103 AB000 Post sc + MOW Hari ke 2 a/i PEB ,letsu ,KIFL,	dr Humaira Sp OG	RSSA	pro penatalaksanaan lebih lanjut dan pro hemodialisa	2	TIDAK
27	Ny LAILATUL BADRIYAH	IRNA	HEPATOMA TUMOR PARU DD	dr. Ardhi. sp. Pd konsul dr.	RSSA	Tatalaksana lebih lanjut untuk bidang gastro /	4	Tidak

			METASTASE	Andy. SP. P		onkologi		
28	Ny. FARIS OLIVIATI	IRNA	pansitopeni (dd MDS dd acute leukemia dd anemia aplastik)	dr. Zora, Sp.PD kpnsl dr. Nurhadi, Sp.M	RSSA Malang	PRO BMP	3	TIDAK
29	Tn. JACOB AGUSTINUS SABA	IGD	Stemi inferior dan RV infarct	dr. Mira,Sp. JP	RS Soetomo	Pro PCI	1	TIDAK
30	NY EVI LESTARI	IGD	obs konvulis dt st.epilpetikus	dr. Farid, Sp.N	RSJ Lawang	pro EEG	1	TIDAK
31	UNTUNG WAHYU JUNAEDI	IRNA	Trombositosis + leukositosis dt ET dd MPN AKI dd CKD	dr. aji. sp.PD	RSSA	pro BMP+trombopheresis+p enanganan KHOM	2	TIDAK
32	JUWOTO	IGD	STEMI	dr Mira Sp JP	RSSA	Pro PCI	2	Tidak
33	Wahyu Hidayat	IRNA	CKD st V, Anemia, HT emergency	dr Ard hany Sp PD	RSI Aisiyah	Pro HD	3	Tidak
34	Tn Sariman	IRNA	Anemia Hemoragic, Hematemesis Melena, Leukositosis, CKD	dr Heri Sp PD	RSSA	Pro Endoskopi	3	TIDAK
35	MOH IMRON ROSYADI	IRNA	Tumor epigastrium + hematemesis + melena + anemia	dr. Ard hany Sp. PD	RSSA	pro endoskopi dan perawatan Sp PD, KGEH	5	TIDAK
36	TOIFUR AHMAD BAMIFTA	IGD	NSTEACS + Symptomatic Bradycardia + Hyperglycemic Crisis	dr. Ira SP.JP	RSSA	Pro TPM	1	TIDAK

- Analisis :**
- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Agustus 2025. Pada bulan Juni 2025 sebanyak 47. pada bulan juli 2025 sebanyak 48 pasien. Sedangkan pada bulan agustus 2025 sebnayak 36 pasien
 - Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - Pro Bedah digestif
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Mebutuhkan alat khusus
 - Mebutuhkan pengobatan ARV
 - Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya. Pada bulan Juli tidak ada pasien rujuk yang minus. Pada bulan agustus terdapat minus sebanyak : Rp. 5.340.634

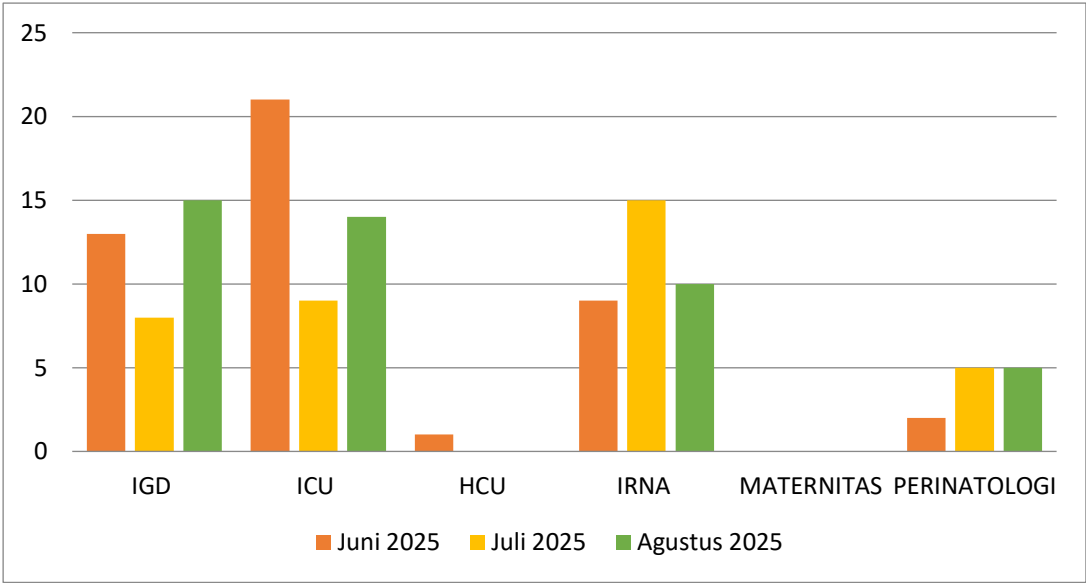
Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Agustus 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1.	IGD	13	8	15
2.	ICU	21	9	14
3	HCU	1	0	0
4.	IRNA	9	15	10
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	5	5
Total		46	37	39

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Agustus 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal Juli 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Ny. Soniati	IRNA	DM, CKD, Anemia	dr.Ardhany Sp.PD
2	Ny. TIANAH	ICU	Shock Sepsis, Post Excisi abses submandibula D	dr. Andi Sp.B Raber dr. Heri Sp.PD
3	Ny.Fita Fitria	ICU	ARDS, DOC, DM Type 2, KAD	dr. Aji.,Sp.PD Raber dr.Robby.,Sp.An
4	Tn. Indra Setiawan	IGD	Bradi Aritmia	dr. Endra
5	Tn. Nawi	IGD	DOA	dr. Yeni
6	Tn Santoso	IGD	ARDS+DOC	dr Heru Sp An
7	Tn. Rudik Sujiono	ICU	Pneumonia, Susp TB, HT,	dr Andy Sp P
8	Ny. Dina Listiyawati	ICU	ARDS, EFUSI PLEURA D	dr. Aji, Sp. PD
9	Ny. Ainur Rosidah	ICU	Shock condition	dr. Aji, Sp. PD
10	Ny. Misenah	IRNA	Ileus obstruksi curiga adesi + Colangitis + dd malignasi	dr. Zaki, Sp. B
11	Ny. Rasemi	IRNA	SUSP CF CAPUT HUMERUS DEXTRA,	dr Oka Sp OT
12	Ny. Tianik	ICU	CVA ICH, Hydrosefalus, Post EVD, AF RVR	dr. Fachriy Sp. BS
13	Tn. RAIM	ICU	Uroseptic, COPD AE, BPH	Dr. dr Pradana Sp B. Uro
14	Tn Agus Aidul Efendi	IGD	DOA	dr Isrotul
15	Tn. Sunomo	IRNA	Anemia Hemoragic, Kista Ginjal Kanan, Hydroureteronefrosis Sinistra	dr.Heri Sp.PD
16	Ny Sugik Nurlaila	ICU	Krisis Dm hiperglikemia, syock cardiogenic, susp pneumonia	dr Ardhi Sp PD
17	Ny Umul Khasanah	IRNA	ADHF, dilated cardiomiopatyy	dr Yoga Sp JP
18	Tn. Sulung Abidin	IGD	DOA	dr. gandha
19	Tn. Achmad Suyuthi Dahlan	IRNA	CEPALGIA	dr. FARID SP.S
20	Tn. Beni Kiswanto	IGD	DOA	dr. Isrotul
21	Tn. Satar	IGD	DOA	dr. Isrotul
22	Tn. Muntarib	IRNA	CKD, AF, Syok Septic	dr Ardhany SP PD
23	Tn. Nanang Sujatmoko Diarjo	IGD	Stemi Anterior luas	dr Ira Sp JP
24	Ny. Muliati	IRNA	DM Tipe 2, Dm Hiperglikemi, CKD	dr Aji Sp PD

			st IV	
25	Tn. D.Wahjoeharjanto	ICU	CVA ICH, IVH, LEUKOSITOSIS SUSP DT REAKTIF	dr. Dewi Sp. S
26	Ny.Sunariyah	ICU	DM + Leukositosis	dr.Ardhi.,Sp.PD
27	Ny. Mahmudah	IRNA	Intra Tumoral Hemorrhagic	dr.Farid, Sp.S
28	Achmad Yani	IGD	DOC EC SYOK KARDIOGENIK	DR. IRA SP.JP
29	Tn Solikan	ICU	COB, ICH, SDH, EDEMA CEREBRI	dr. Fachriy, Sp.BS
30	Tn Karto	IGD	SYOK KARDIOGENIK	dr Miryanti, Sp.JP
31	Tn Sadi	IGD	DOA	dr GANDA
32	Tn Muhaimin	IGD	CVA ICH	dr Dewi Maharani, Sp.S
33	Tn Abdalah	IGD	DOC ec DKA dd HHS dd sepsis	dr Heri Sp PD
34	Ny SRI WASTUTIK	IGD	DOA	dr ISROTUL ANISA
35	Ny. Sadiyah Sumiyani	IGD	DOA	dr. Gandha
36	Kholik	ICU	DOC e.c hipoglikemia	dr. Ardhani Sp.PD
37	Kaliya	ICU	SYOK KARDIOGENIK	dr. Farid Sp S
38	Suprihatin	ICU	EFUSI PLEURA+DM 2+HIPERGLIKEMIA+HT	dr AJI, Sp.PD
39	Sri Widayati	IRNA	DOC, CVA 2nd attack	dr. farid sp.s

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Agustus 2025 sebanyak 39 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 15 pasien, ICU : 14 pasien IRNA : 10 pasien
3. Pada bulan Juli 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 8 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial 119lastic119 tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain – lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-

4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

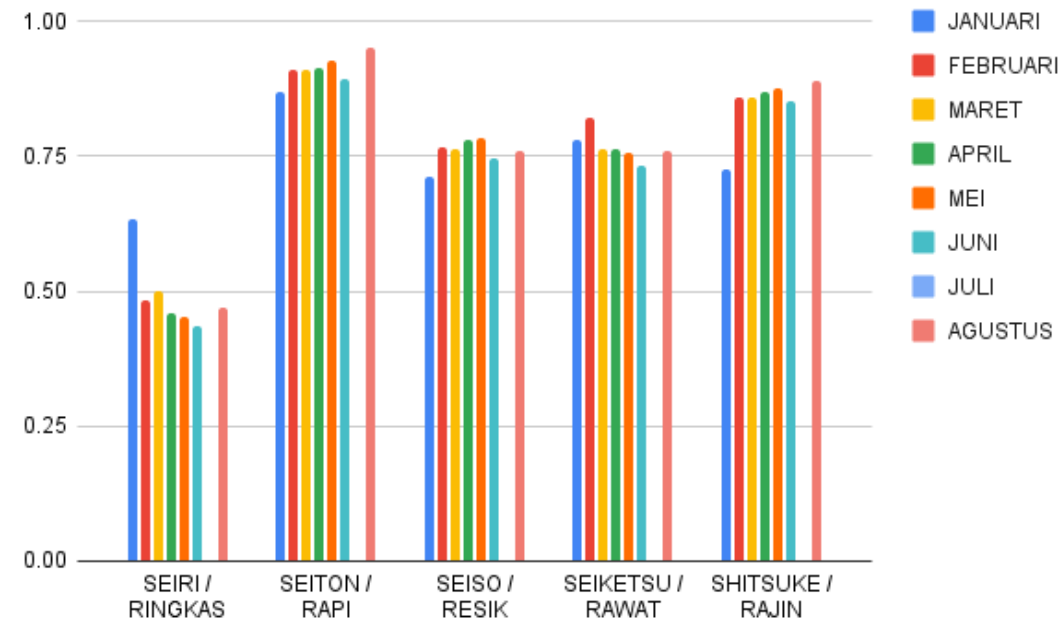
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%		47%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%		95%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%		76%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%		76%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%		89%



Analisa :
Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

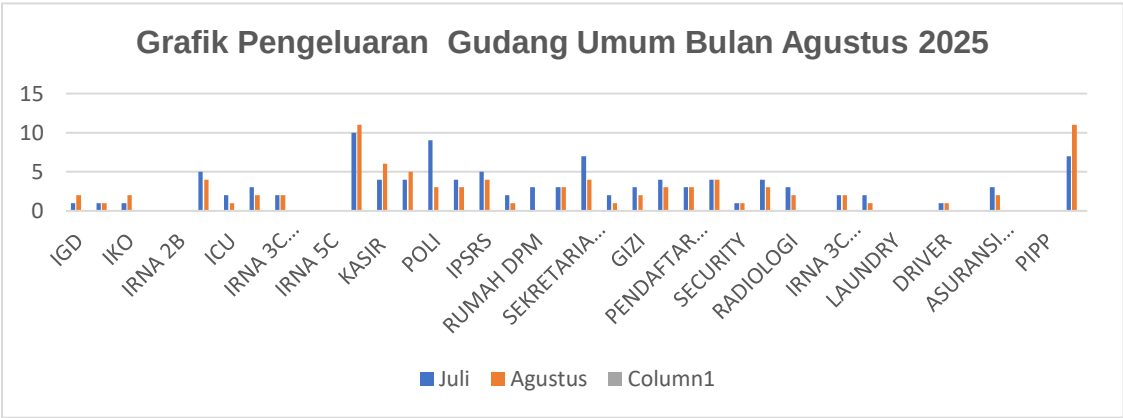
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		JULI	AGUSTUS	
1	IGD	1	2	↑50%
2	MATERNITAS	1	1	↓0%
3	IKO	1	2	↑50%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	5	4	↓-25%
7	ICU	2	1	↓-100%
8	IRNA 3A+4A	3	2	↓-50%
9	IRNA 3C DEWASA	2	2	↓0%
10	IRNA 4C	0	0	↓0%
11	IRNA 5C	0	0	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	10	11	↑-,09%
13	KASIR	4	6	↑33,33%
14	DAPUR	4	5	↑ 20%
15	POLI	9	3	↓-100%
16	CLEANING SERVICE	4	3	↓-33,33%
17	IPSRs	5	4	↓-25%
18	GUDANG FARMASI	2	1	↓-100%
19	RUMAH DPM	3	0	↑0%
20	SEKRETARIAT PT	3	3	↓0%
21	SEKRETARIAT RS	7	4	↓-75%
22	CSSD	2	1	↓-100%
23	GIZI	3	2	↓-50%
24	REKAM MEDIS	4	3	↑-33,33%
25	PENDAFTARAN	3	3	↓0%
26	DEPO FARMASI	4	4	↑0%
27	SECURITY	1	1	↓0%
28	LABORATORIUM	4	3	↓-33,33%
29	RADIOLOGI	3	2	↓-50%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	2	2	↑0%
32	NS NICU	2	1	↓-100%
33	LAUNDRY	0	0	↓0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	1	1	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	2	↓-50%
38	DPW	0	0	↓0%

39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	7	11	↑36,36%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :
 Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , Poli dan RSDH

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.7.8 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait software	61	61	100%
2	Keluhan terkait hardware	121	121	100%

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
 Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.7.9 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1.	19/8/2025	Tidak terencana	180 menit (17.00-20.00)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 120 menit info dari IT bpjs
4	31/8/2025 s/d 1/9/2025	Terencana	(17.00-05.00)	Maintenance bulanan server bpjs	Edukasi proses pencarian data peserta secara manual

Analisis : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

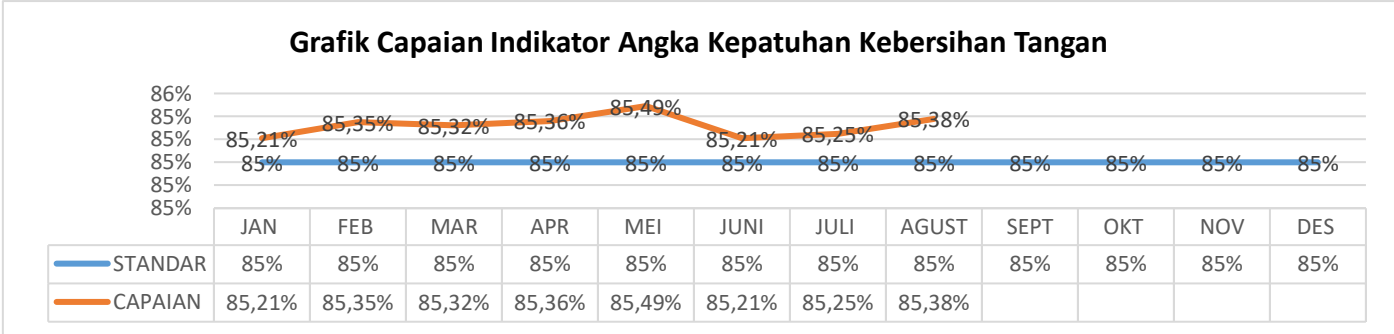
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%					85,29%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,79%	94,3%					93,05%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%					99,74%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	96,23%	96,60%					92,54%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	66,22%	60,55%					75,68%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					98,07%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	96,33%	95,04%					99,16%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					99,97%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%					99,86%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



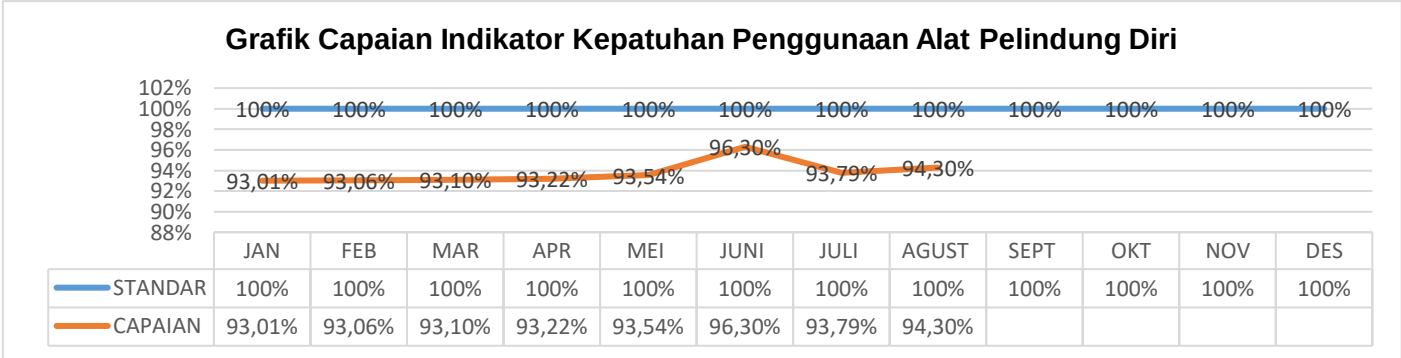
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21 dan capaian di bulan Juli adalah 85,25% serta Agustus sebesar 85,38% dengan rata rata bulan Januari hingga Agustus yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.					
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.					
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21 dan capaian di bulan Juli adalah 85,25% serta Agustus sebesar 85,38% dengan rata rata bulan Januari hingga Agustus yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.7.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



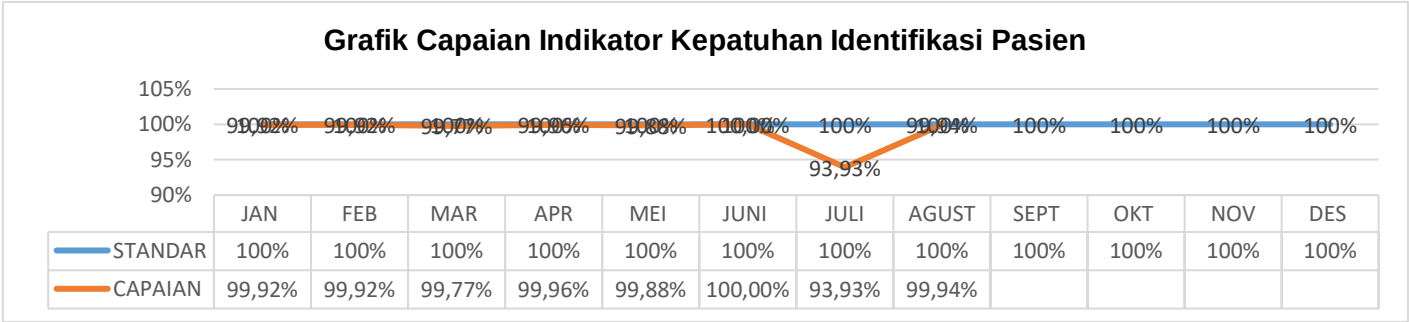
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Juli Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.

	6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% serta bulan Agustus sebesar 94,3% dengan rata-rata 93,79%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

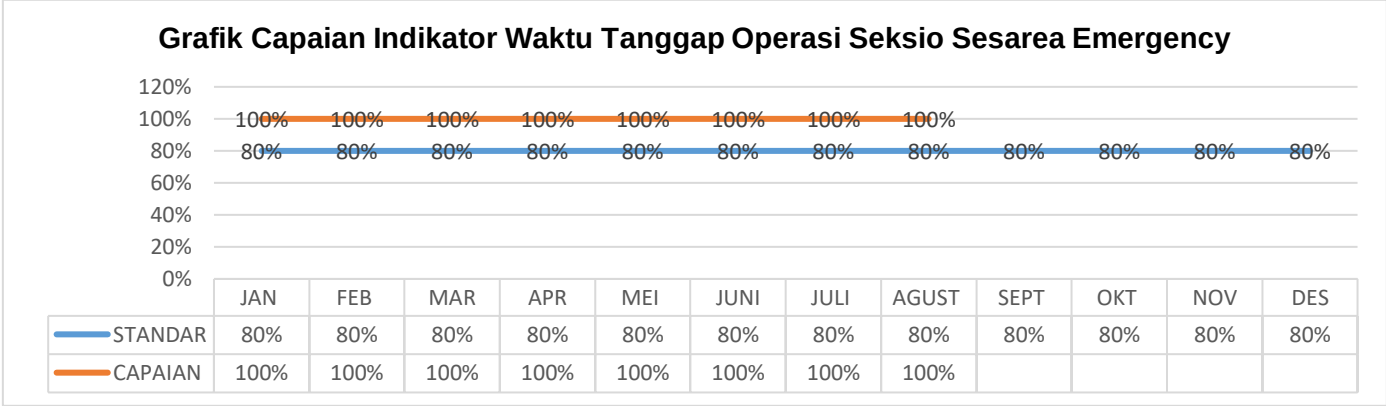
3.7.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93% dan bulan Agustus yaitu 99,94%

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan 127lastic127e pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan 127lastic127e dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian meningkat di bulan Juni menjadi 100%,namun Kembali menurun pada bulan Juli yaitu 93,93% serta bulan Agustus yaitu 99,94% dengan rata rata 99,12%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan 127lastic127e pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

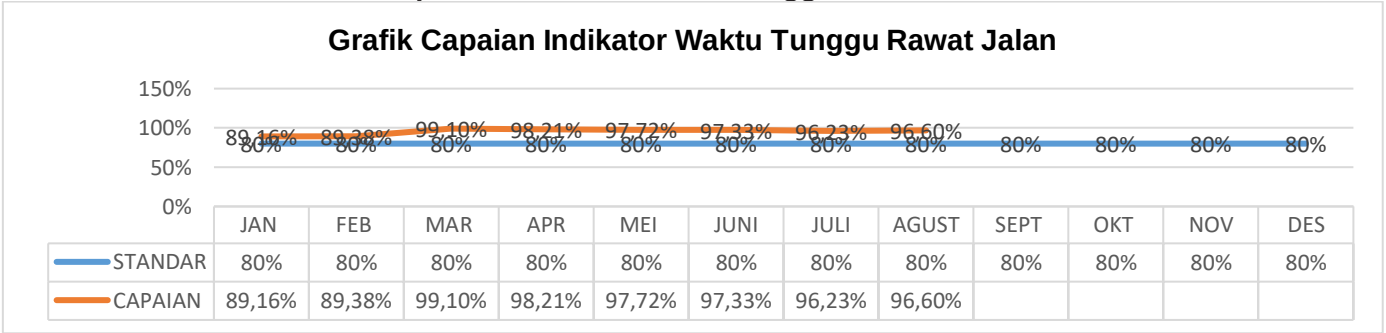
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

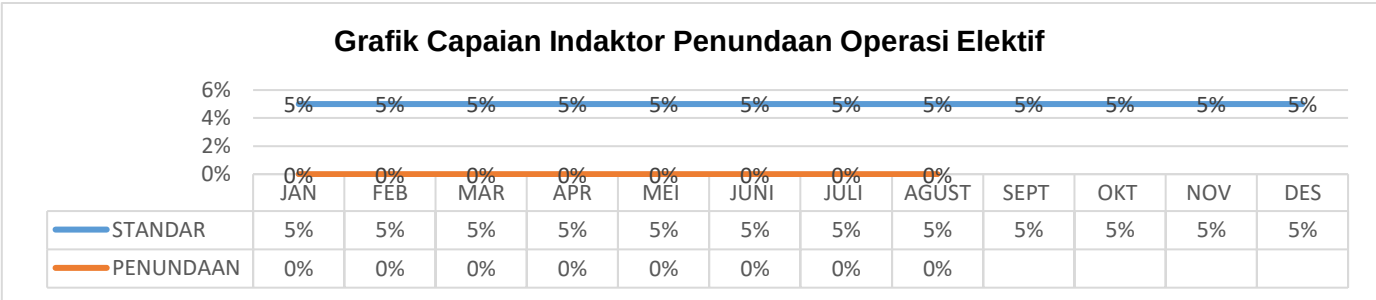
3.7.12 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23%, serta capaian di bulan Agustus yaitu 96,60% dengan rata-rata 95,45%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.7.13 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

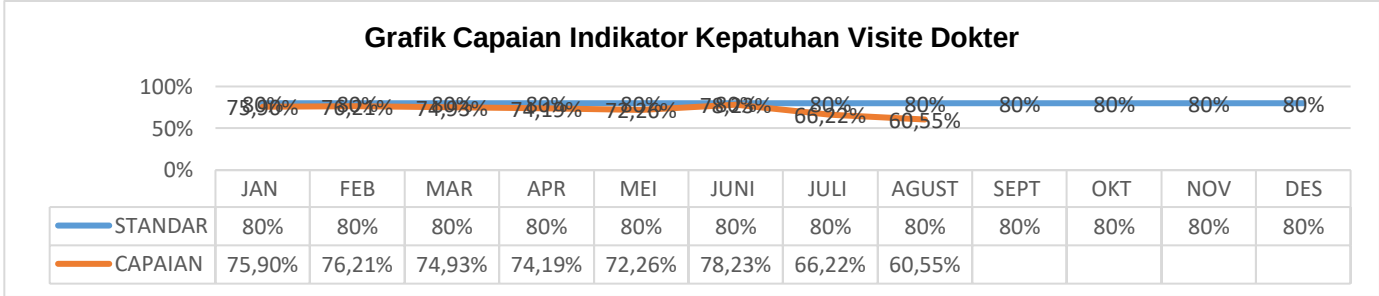


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

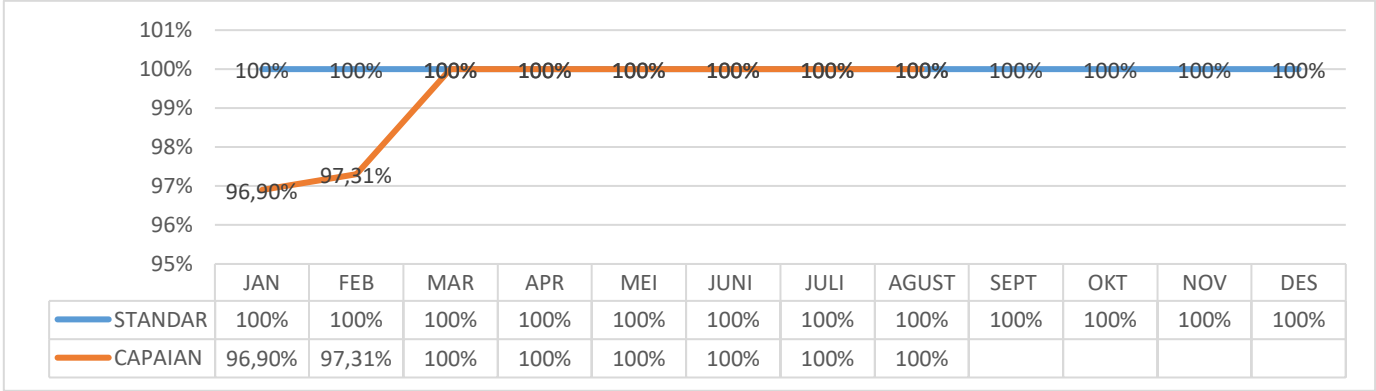


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Agustus Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dan capaian di bulan Agustus yaitu 60,55% dengan rata-rata 72,32%. Dari hasil supervisi didapatkan nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og. , dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr, dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu).				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena 130 lastic 130 besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Labororium

3.7.14 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

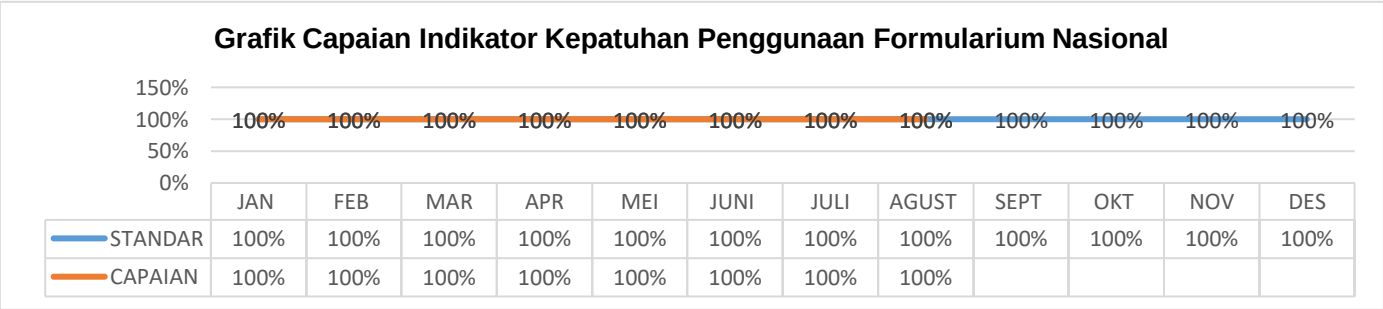


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga Agustus. Capaian meningkat pada bulan Maret hinga Juni yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan 131lastic131e baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Agustus yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

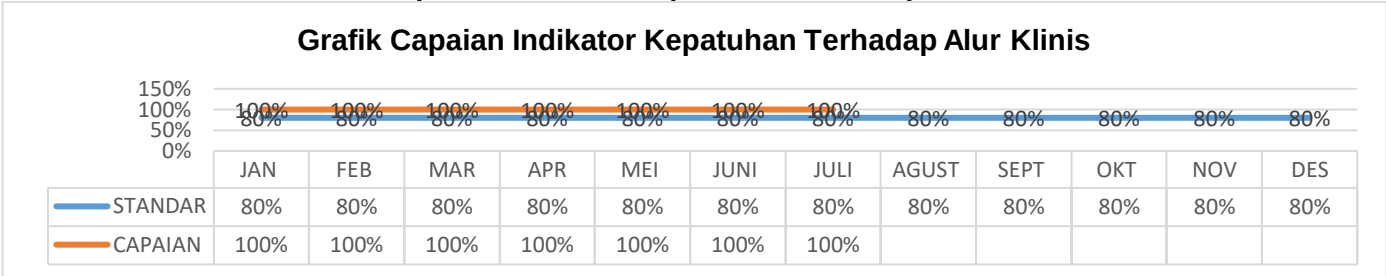
1.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.7.15 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

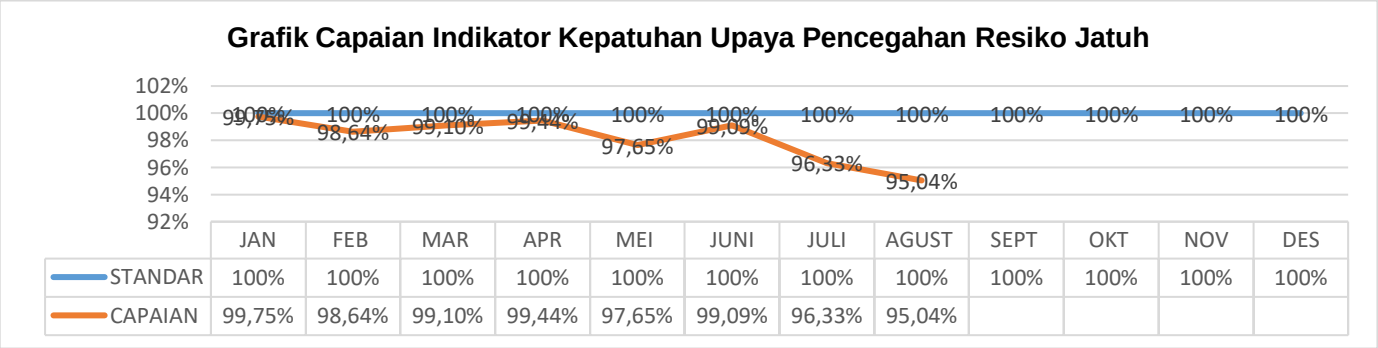
Daftar Clinical Pathway Bulan Agustus 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	39		

Partus Normal	32		
Jumlah	71	71	

3.6.1.1.6 Ketaatan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.7.16 Grafik Capaian Indikator Ketaatan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

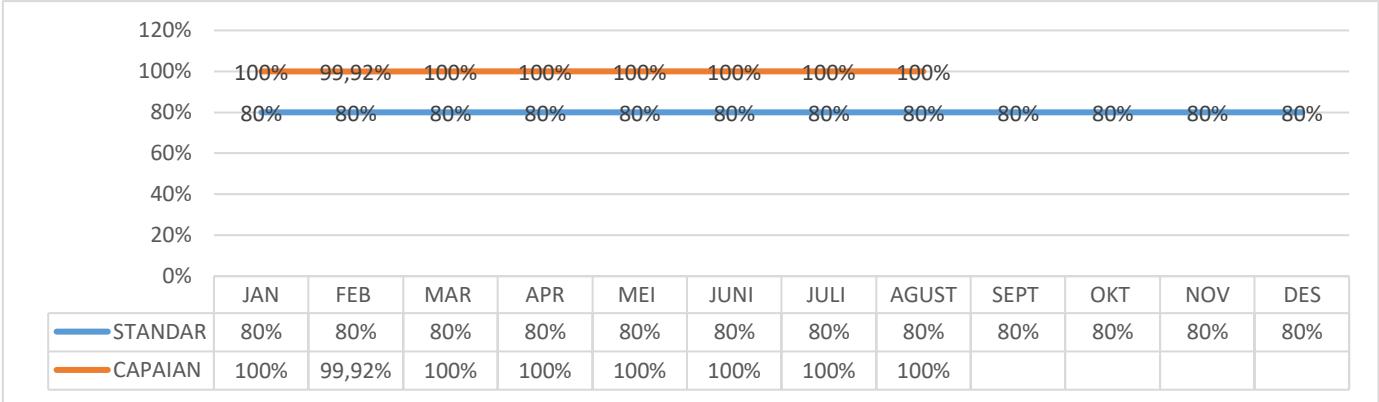


Berdasarkan grafik capaian indikator ketaatan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Agustus Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan 133last pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan 133last pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09%, capaian di bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04% dengan rata-rata 98,13%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan 133lastic133e berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang 133last pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

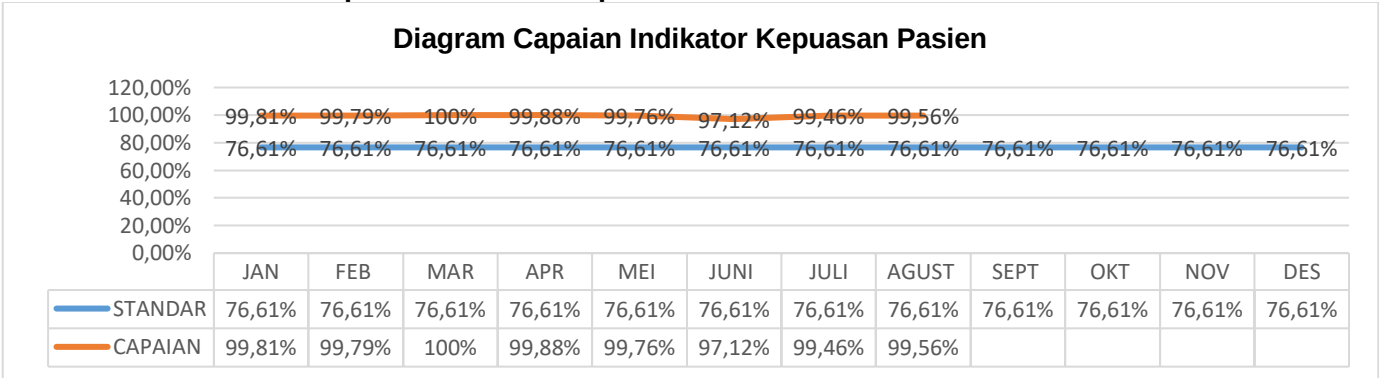
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap komplain bulan Januari hingga Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99,40%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%					99,1%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%	99,37%	99,41%					99,62%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%	100%					98,7%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%	100%	100%					98,60%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0%
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%	98,22%	98,48%					97,94%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%	99,48%	98,71%					99,1%
11.	Kepatuhan 135last pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%	96,33%	95,04%					98,57%
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%					85,31%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%					99,40%

2.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%	86,4%	80%	87,5%					85,10%

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%	98,79%	98,2%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%	95,23%	95,445					

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6.	Kepatuhan 137last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%	98,45%	98,92%	98,82%					
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%	100%	100%					
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%	1,96%	1,72%					
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%	100%	100%					
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

	gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)														
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0	0	0					

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-	-	-	-			
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-				-	-	-	-			
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	Kepatuhan 138last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22.	Kepatuhan penandaan 139lasti operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

3.7.17 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%	96,88%	95,41%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%	96,9%	95,26%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%	72,31%	69,88%					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 140last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%	100%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%	100%	100%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%	97,71%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%	100%	95,27%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%	100%	100%					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%	1,81%	-	-					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%	100%	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

	dibawa pulang														
21.	Kepatuhan penandaan 141lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%	100%	100%					

3.7.18 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%	97,22%	95,31%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%	96,34%	95,22%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%	100%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%	95,52%	89,30%					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 141last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%	67,38%	100%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%	90,27%	100%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%	100%					

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%	100%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%	100%	97,93%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%	100%	95,48%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%	41,84%	100%					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%	-	-					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%	100%	100%					
21.	Kepatuhan penandaan 142lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%	82,4%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%	100%	100%					

3.7.19 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%	97,88%	97,92%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%	93,52%	93,88%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%	74,42%	72,22%					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 143last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%	96,15%	96,42%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%	100%	100%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%	100%	100%					
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%	100%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%	100%	100%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%					

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%	100%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
21.	Kepatuhan penandaan 144lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%	90,48%	100%					

3.7.20 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%	96,22%	96,82%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%	98,24%	98,60%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	100%					
7.	Kepatuhan 145last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	-					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%	-	100%					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-					

21.	Kepatuhan penandaan 146lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.21 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%	97,44%	97,47%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%	99,62%	99,80%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%	99,4%	99,54%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%	90,71%	72,22%					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 146last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%	96,43%	96,52%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%	97,73%	97,6%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%	91,3%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%	100%	100%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%	100%	100%					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%	99,12%	99,72%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%	100%	0%	0%					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%	-	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,01%	99,48%					
21.	Kepatuhan penandaan 147lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%					

3.7.22 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,78%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%	99,72%	97,44%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%	99,66%	99,62%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%	99,4%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%	75%	90,71%					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 148last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%	84,15%	96,43%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,9%	97,73%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,3%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,47%	100%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%	100%	100%					

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,12%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0%	0%					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%					
21.	Kepatuhan penandaan 149lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.23 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%	96,62%	98,92%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%	97,66%	97,21%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%	98,68%	97,92%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%	68,1%	52,88%					

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 150last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%	100%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%	100%	100%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%	100%	100%					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%	-	0%					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

21.	Kepatuhan penandaan 151lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.24 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%	97,2%	98,93%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%	97,22%	97,22%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%	100%	97,93%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%	68,1%	52,90%					
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-					
7.	Kepatuhan 151last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	100%	100%	92,88%					
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%					
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
21.	Kepatuhan penandaan 152lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.25 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%	97,22%	98,24%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%	98,2%	99,89%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%	74,66%	70,21%					
6.	Kepatuhan 153last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-					
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%	-	-	-					
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-					
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%	100%	100%					
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.26 HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%	85,22%	99,52%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%	99,2%	99,57%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%	74,66%	70,22%					

6.	Kepatuhan 155last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-					
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-	-	0					
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-					
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.27 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%	95,62%	96,22%%					
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%	96,8%	96,92%					
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%	96,23%	96,66%					
6.	Kepatuhan 156last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%	78,6%	82,44%					
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15	17	21	34					
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.27 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%	62,22%	64,43%					
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6.	Kepatuhan 157last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Kejadian keterlambatan operasi 157lastic caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%	0%	0%					

10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0	0	3					
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15	11	13					
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3	1	1					
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0	0	1					
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	17,2%					
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	16,5%					
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90	98	96					
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.7.28 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1	3	0					
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%	99,8%	99,88%					
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%	99,67%	99,86%					
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%	76,2%	62,34%					
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%	100%	95,54%					

10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%	98,88%	100%					
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%	96,8%	88,47%					
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%	100%	100%					
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-					
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (160lastic160)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

1.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005					
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%	98,8%	98,92%					
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%	98,78%	99,21%					
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-					
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-	-	-					
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.7.29 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
4.	Kepatuhan 162last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%	100%					
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan 163lasti operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0	0	0	0					
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%	32,6%	100%					
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%	100%	100%					
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.30 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0	0	0					

2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%	100%					
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005	100%	100%					
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.31 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%					
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%	5,2%	4,8%					
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%	100%					

5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.32 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0	0	0					
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%	99,82%	98,92%	99,28%	99,40%					
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%	999,42%	99,53%					

3.7.33 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0	4	4					
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%	48,88%	47,72%					
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%	24,03%	19,97%					
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1	1	0					
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0	1	0					
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0	0	0					
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0	0	0					
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32	0	0					
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%	100%	87,72%					
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%	100%	100%					
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.34 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%	0,26%	0,17%					
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.35 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%					

2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰					
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰					
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰					
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%	0,73%	0,78%					
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%	85,25%	85,38%					
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%	93,79%	94,3%					
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%	93,77%	94,35%					
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

3.7.36 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%					
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%	16,32%	14,22%	19,16%					
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%	100%	100%	99,52%					
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
----	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

3.7.37 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1	0	0					
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%	99,03%	98,96%					
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%	2,41%	2,23%					
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.38 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%	36,06%	80,93%	78,88%					
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%	0,49%	0,27%					
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%%	98,04%	1,57%	7%	6,67%	100%	100%					
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%	2,05%	100%	100%					
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%	7,54%	7,6%					
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%	95,94%	100%					

3.7.39 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.7.40 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19	1,12%	1,32%					
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31	1,42%	1,21%					
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%	99,22%	99,425					
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0	0	0					

3.7.41 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%	80%	95%					
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%	95%	95%					

3.7.42 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2	2	3					
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3	7	3					

3.7.43 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%	28,88%	22,35%					
2.	Kejadian 172lastic172 Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%	98,21%	98,40%					
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%	99,37%	99,55%					

3.7.44 KESEKRETARIATAN

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%	26,19%	23,8%					
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%	18,18%	34,5%					
3	Angka tindak lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%	13,51%	46,7%					

3.7.45 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%	1,15%	1,22%					
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0	2	0					
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%	100%	100%					
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%	100%	100%					

3.7.46 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1	0	0					
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1	1	1					
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%	100%	100%	100%					

3.7.47 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%	89,32%	94,52%					
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%	91,7%	91,88%					
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81,44%	75%	78%					
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%	76,22%	100%	92,75%					

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pencatatan pada buku register	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.7.48 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%	86,45%	84,75%					

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Respon time Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Respon time Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%	100%	100%					

3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, 175lastic rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21	13	18	19					
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1	1	0					
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9	7	4					
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

1.6.2 Komite PPI

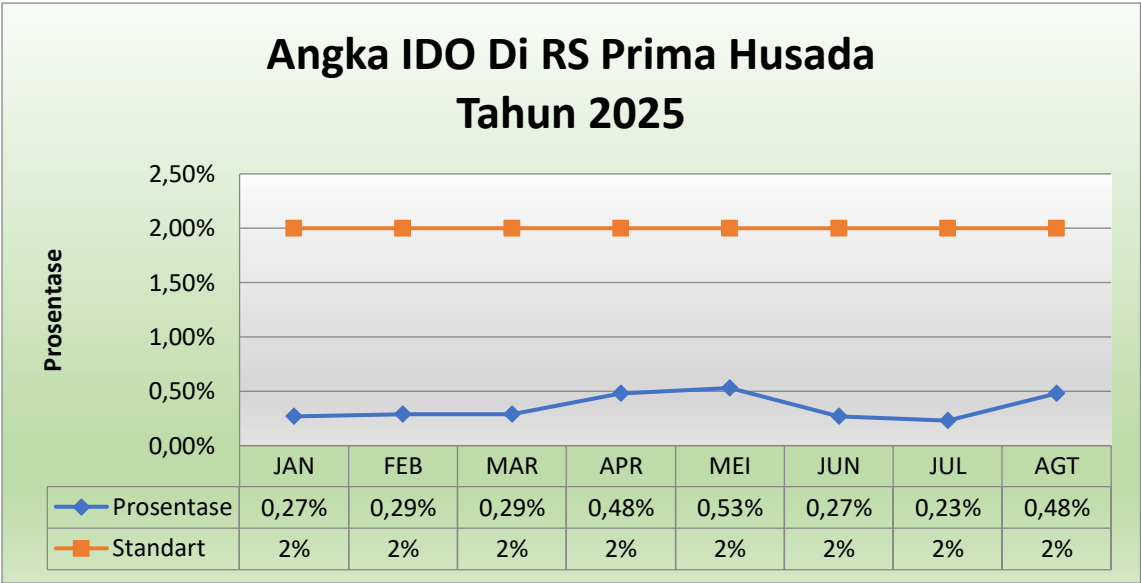
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	89	0%
Seksio Sesaria	1	60	1,67%
Apendiktomi	0	8	0%
Herniotomi	0	10	0%
Katarak	0	42	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	7	0%
Semua Operasi	2	412	0,49%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa

Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi SC dan 1 lagi pada kasus Laparatomi.

- Dari hasil assesmen pasien post SC diperoleh data bahwa pada saat operasi 7 orang staf ikut operasi dan proses sterilisasi sudah sesuai (indikator internal & eksternal). Ditemukan luka terbuka tidak langsung diidentifikasi hingga kontrol ke-8 hari pasca operasi. Kemungkinan kepatuhan prosedur aseptis kurang optimal dan monitoring pasca operasi belum maksimal.

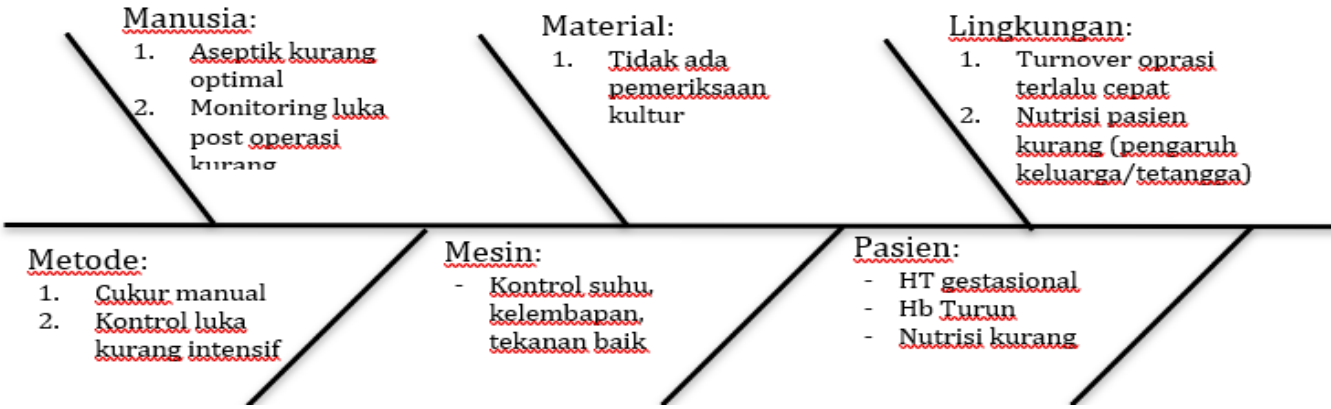
Profilaksis antibiotik sudah diberikan dan luka diklasifikasikan bersih terkontaminasi, serta cukur masih dengan pisau silet manual meskipun disposable. Teknik pencukuran manual meningkatkan risiko mikrotrauma kulit.

Antiseptik yang digunakan saat operasi: povidone iodine, alkohol 70% namun tidak dilakukan kultur pus saat luka bernanah dan dapat berakibat antibiotik tidak tepat sasaran berisiko resistensi bakteri.

Ruang OK suhu 25°C, kelembapan 57% (masih standar), dan tekanan positif (baik).

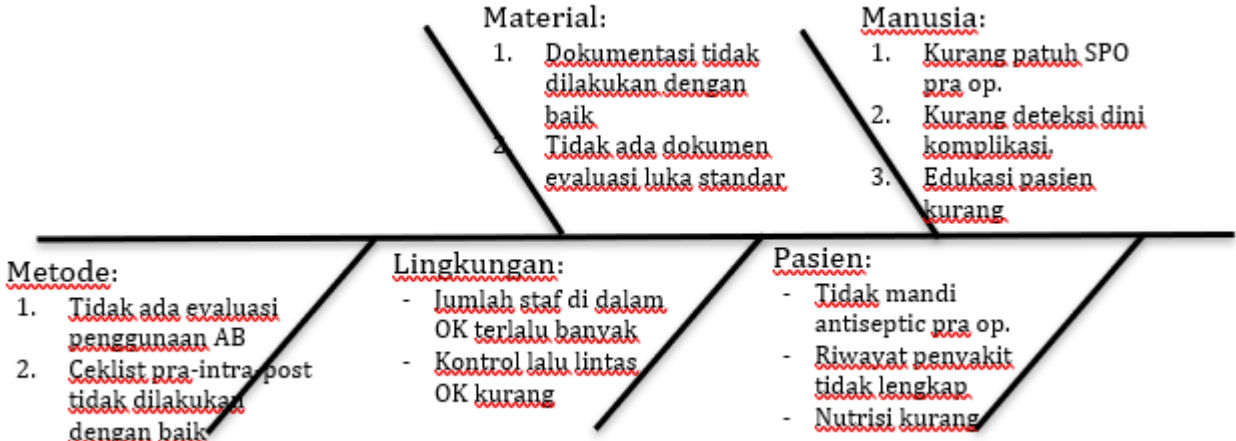
Pasien urutan ke-2 operasi, jeda hanya 30 menit dari operasi pertama dan nutrisi sempat terekalkan makan pasca operasi. Turnover ruang operasi cepat berpotensi kurang optimal desinfeksi lingkungan dan nutrisi pasien kurang → memengaruhi penyembuhan luka.

Usia pasien 29 tahun, BB 70 kg - HT gestasional, TD 160/90 mmHg pre-op - Hb turun dari 12,2 → 9,2 g/dl, Leukosit meningkat 17.540 (post op), Luka infeksi dengan pus ±30 cc, terbuka 5 cm. Dengan riwayat hipertensi & kondisi obstetri kompleks → daya tahan tubuh menurun, Penurunan Hb memperlambat penyembuhan, luka cukup luas dan dalam, risiko IDO meningkat.



- Dari kasus IDO pada pasien laparatomi ditemukan hasil analisa terkait tidak ada pemeriksaan penunjang awal(USG/BNO, Thorax PA >40 tahun), Pasien tidak mandi ≤1 × 24 jam pre-op, riwayat penyakit penyerta awalnya tidak terkaji jelas & nutrisi pasien saat post op sempat tidak mau makan (nafsu makan turun). SPO pemeriksaan pra-operasi tidak dijalankan penuh, kurangnya koordinasi antara DPJP, IGD, dan perawat pre-op. Tidak ada evaluasi antibiotik pasca operasi berdasarkan kultur dan nutrisi pasien kurang → memengaruhi penyembuhan luka.

Jumlah staf di OK banyak (6 orang) dan tidak ada catatan pencegahan lain seperti pemeliharaan suhu tubuh pasien intra-op. Kontrol lalu lintas OK kurang ketat dan okumentasi pencegahan infeksi intra-op minim.

	Keluhan pasien saat kontrol 1 tidak direspon dengan pemeriksaan lanjutan, edukasi pasien pasca operasi tidak terdokumentasi dan diagnosis infeksi terlambat ditegakkan serta tidak ada evaluasi luka harian yang terstruktur. Kurangnya deteksi dini komplikasi, edukasi tidak diberikan atau tidak tercatat, Observasi post-op tidak terstandarisasi, dan tidak ada jadwal evaluasi luka jelas.  <pre> graph LR Material[Material: 1. Dokumentasi tidak dilakukan dengan baik 2. Tidak ada dokumen evaluasi luka standar] Manusia[Manusia: 1. Kurang patuh SPO pra op. 2. Kurang deteksi dini komplikasi 3. Edukasi pasien kurang] Metode[Metode: 1. Tidak ada evaluasi penggunaan AB 2. Ceklist pra-intra post tidak dilakukan dengan baik] Lingkungan[Lingkungan: - Jumlah staf di dalam OK terlalu banyak - Kontrol lalu lintas OK kurang] Pasien[Pasien: - Tidak mandi antiseptic pra op. - Riwayat penyakit tidak lengkap - Nutrisi kurang] Material --- Root(()) Manusia --- Root Metode --- Root Lingkungan --- Root Pasien --- Root Root --- Problem[Keluhan pasien saat kontrol 1 tidak direspon...] </pre>				
Masalah saat ini	1. Faktor Manusia (kurangnya Teknik aseptik, monitoring luka post operasi kurang, kurang patuh terhadap SPO, kurang deteksi dini komplikasi, edukasi pasien kurang). 2. Faktor Pasien (Riwayat penyakit penyerta pasien tidak lengkap terkaji sehingga tidakan perawatan dan persiapan pra operasi masih kurang, tidak mandi antiseptic, dan nutrisi pasien yang masih kurang). 3. Faktor Lingkungan (Jumlah staf yang memang terlalu banyak di dalam OK dan turn over OK yang terlalu cepat sehingga desinfeksi ruangan tidak maksimal). 4. Faktor metode (Kontrol luka masih kurang maksimal, cukur manual masih digunakan, tidak ada evaluasi AB berdasarkan kultur). 5. Faktor material (dokumentasi tidak dilakukan dengan baik, tidak ada pemeriksaan kultur pus).				
Permasalahan sebelumnya	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi pada ibu yang beresiko tinggi dan belum pernah menjalani operasi sebelumnya. 2. Mandi dengan cairan antiseptic/sabun belum berjalan baik terutama pada pasien dengan operasi cyto.				
Tindakan yang dilakukan	1. Monitoring prosedur klinis dengan baik (monitoring perawatan luka pasien post operasi, kontrol proses pencukuran dan perawatan/desinfeksi alat cukur dan penggunaan pisau cukur disposable). 2. Melakukan edukasi ulang perawat tentang deteksi dini tanda infeksi luka, terutama pasien di poli saat kontrol pertama. 3. Melakukan monitoring kepatuhan aseptik di ruang-ruang perawatan. 4. Mengkonfirmasi pada Karu kamar operasi untuk membantu menjadwalkan operasi dengan jeda minimal 1 jam dari operasi sebelumnya untuk proses desinfeksi ruangan kamar operasi. Termasuk untuk mengurangi padatan jumlah petugas didalam kamar operasi, untuk tim anastesi setelah dilakukan anastesi bisa keluar dari kamar operasi sementara 5. Malakukan koordinasi dengan ahli gizi untuk edukasi terkait kebutuhan nutrisi pasien pasca operasi, terutama pasien dengan operasi saluran cerna.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

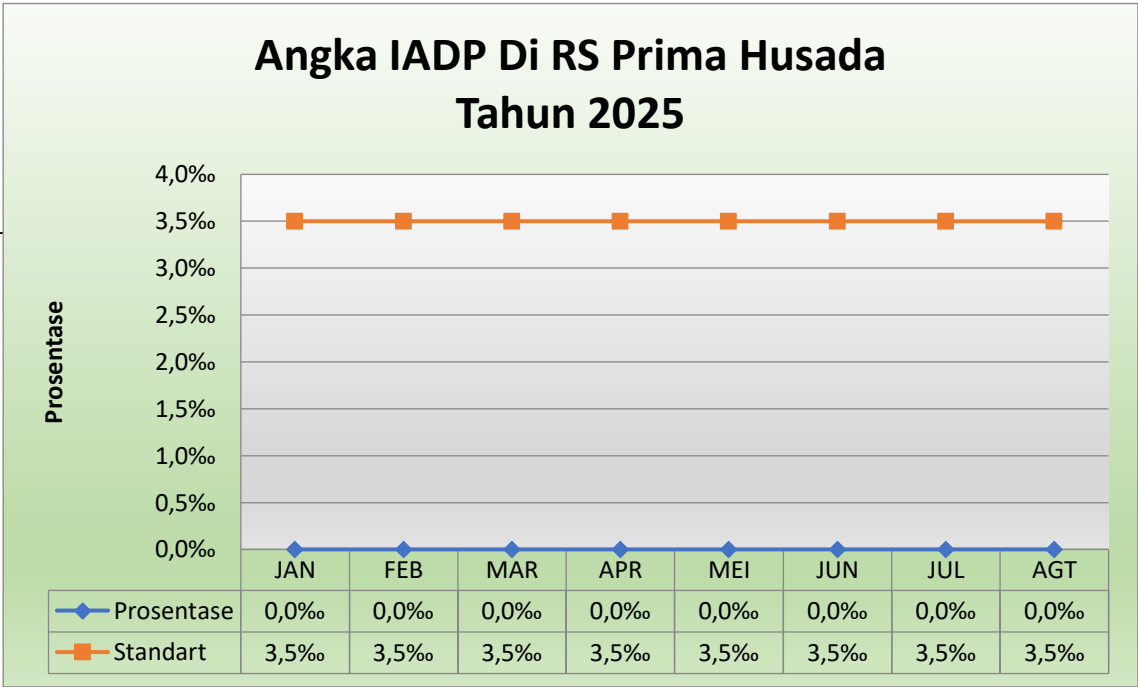
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 2. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 3. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. 4. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCEN	Satu bulan
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Bantu berikan dorongan afirmasi positif atas keadaan yang terjadi pada pasien agar tidak mengganggu proses penyembuhan agar pasien lebih semangat untuk sembuh. 5. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPCEN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	15	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.7.49 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 6hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

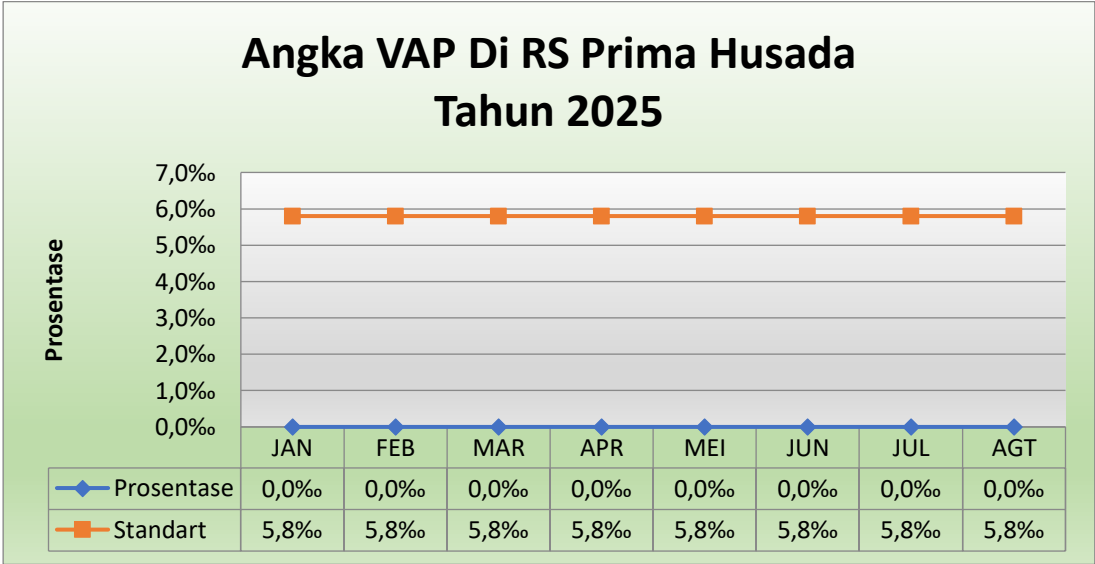
			4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	44	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	1	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 106 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan 181lasti / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

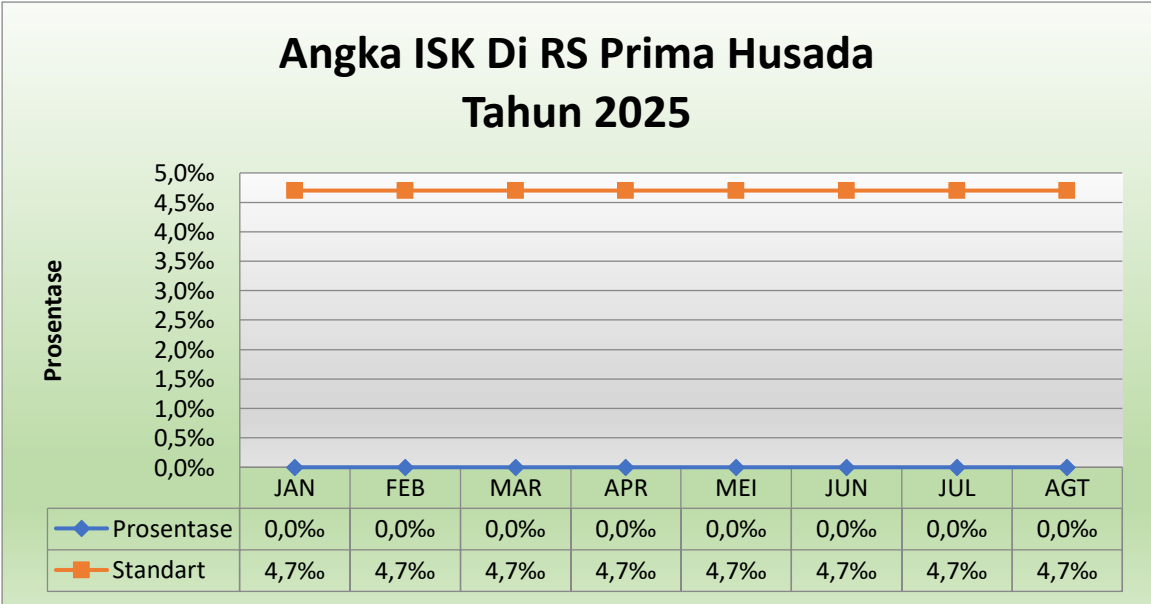
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan
--	---	--	--	--	------------

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	179	0‰
HCU	0	29	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

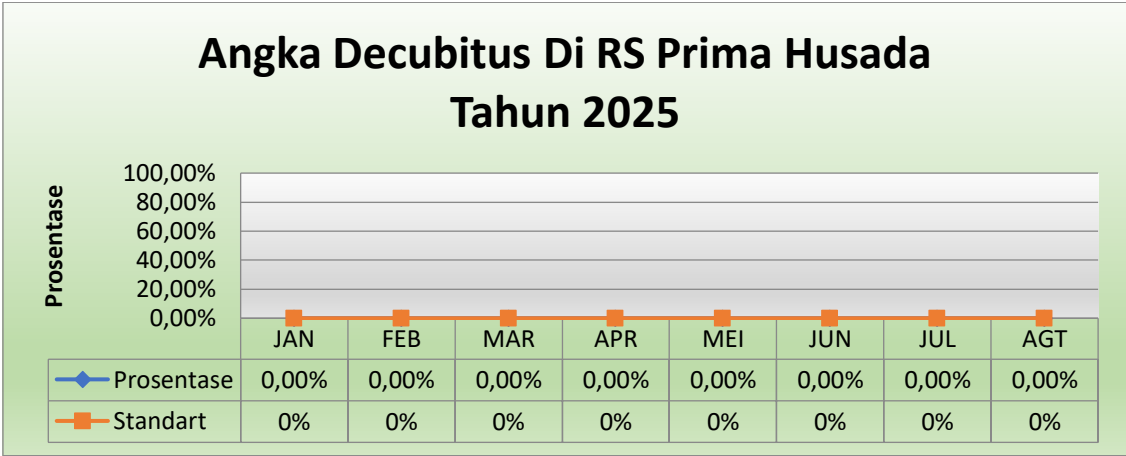
3.7.50 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1151 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.5 Decubitus

3.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

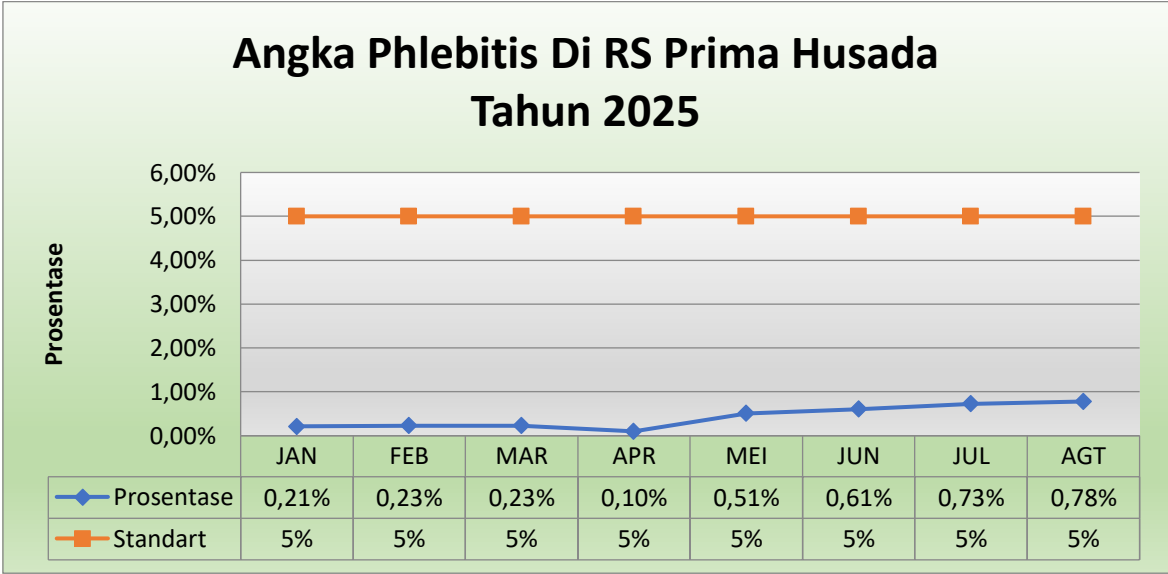


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 25 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan kepatuhan pencegahan 184lastic184e.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan 184 last anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---	--	--	---	--	------------

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.51 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

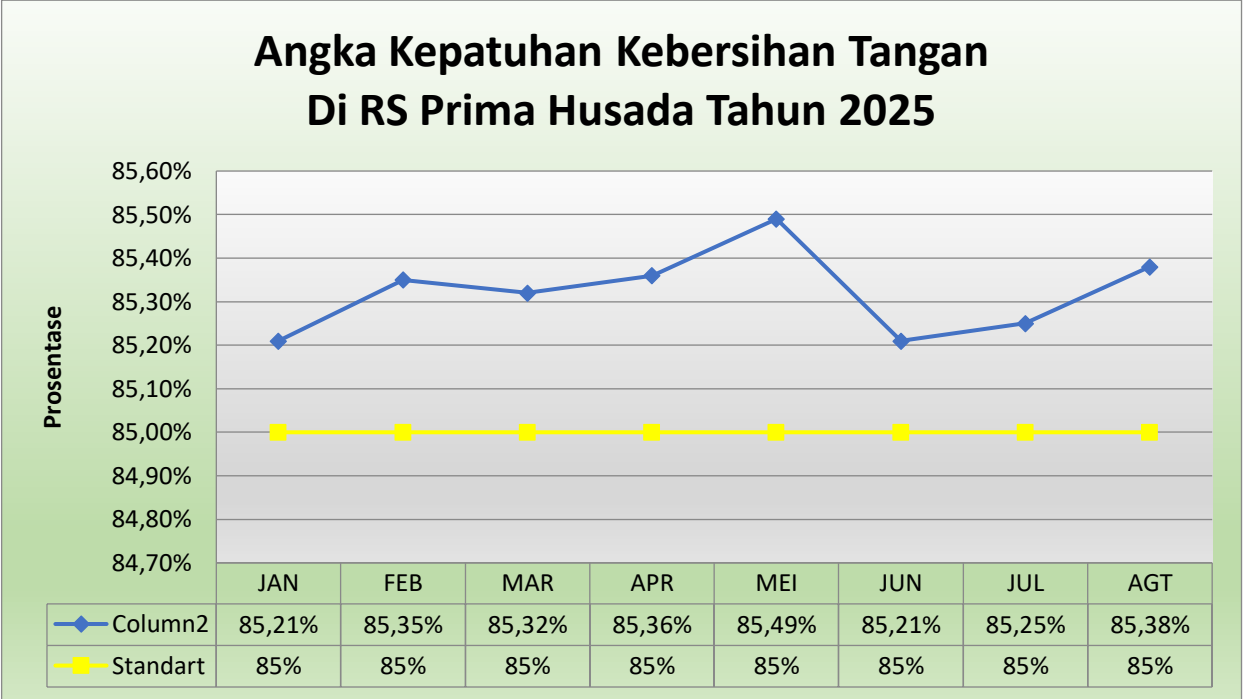


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2965 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,78%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat 23 pasien yang mengalami phlebitis, 4 diantaranya merupakan pasien berusia >60 tahun, 3 pasien anak-anak dan sisanya pasien dewasa, dimana 30% masuk pada faktor usia beresiko phlebitis. 3 diantara 23 pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat seperti D40%-NS 3%-D10% dan 1 orang mendapat 2 antibiotik berbeda saat premed dan setelah operasi, serta 2 pasien yang mendapatkan transfusi PRC. Pasien lainnya tidak mendapatkan cairan pekat hanya mendapat 1 antibiotik dan injeksi pekat seperti metamizole. Pemasangan plester tidak transparan juga membuat kesulitan untuk memantau kondisi luka tusukan infus. Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis). Terdapat peningkatan kesadaran petugas terhadap pelaporan phlebitis dan pemahaman skor phlebitis sehingga terjadi peningkatan laporan kejadian phlebitis juga.
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini. 3. Faktor pemilihan lokasi pemasangan infus dan pemilihan pemakaian plester transparan perlu diperhatikan.
Permasalahan sebelumnya	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga infus pekat dan antibiotik dobel.. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.

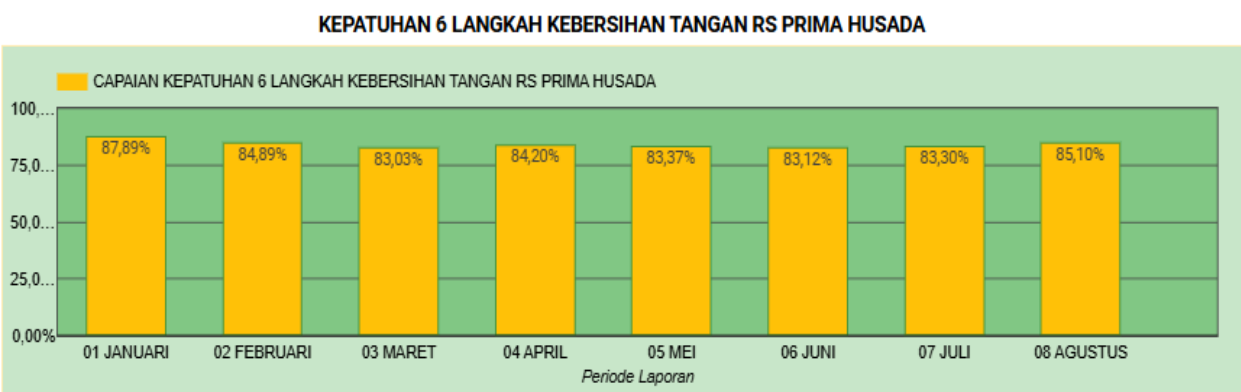
	3. Faktor pemilihan lokasi pemasangan infus dan pemilihan pemakaian plester transparan perlu diperhatikan.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengkoordinasikan dengan kabid dan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. 2. Mengajukan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. 3. Mengajukan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 4. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. 5. Mengajukan perawat untuk menggunakan plester transparan supaya area luka infus dapat lebih mudah dikontrol.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

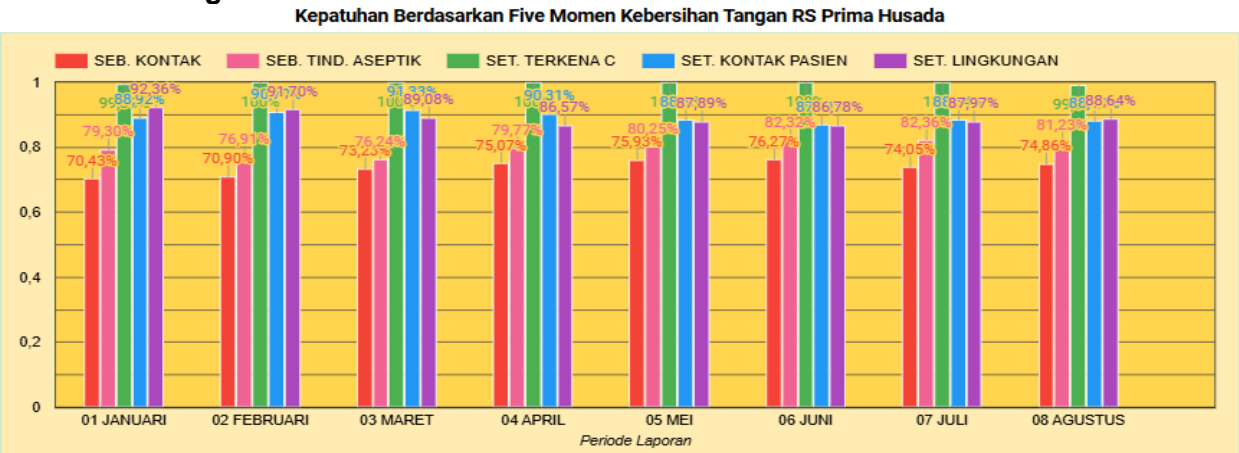
3.7.52 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



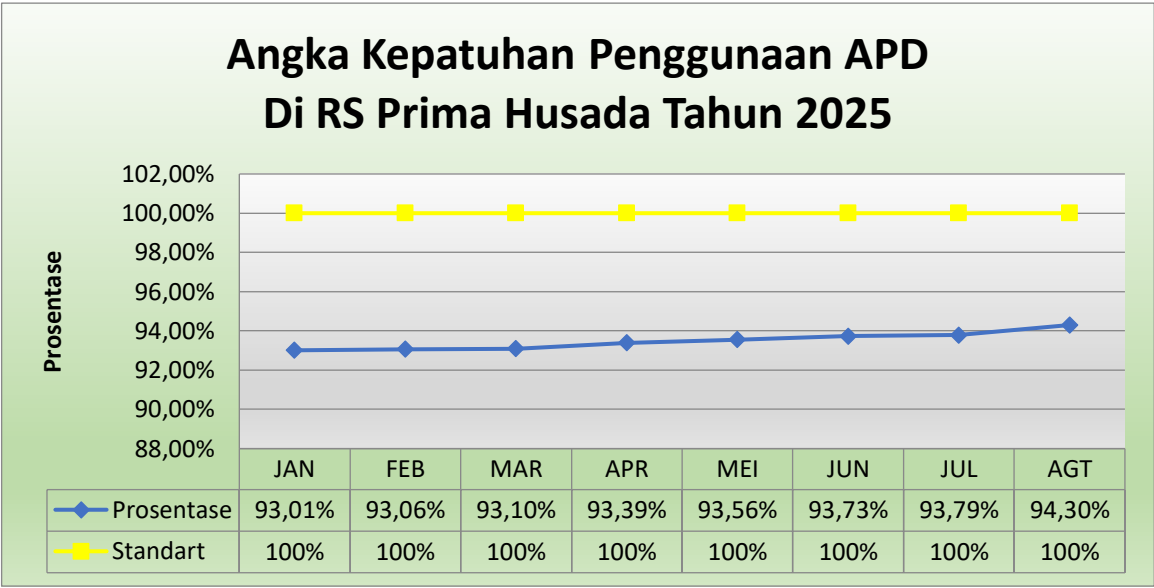
1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan



Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,38%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (74,86%). Terjadi sedikit peningkatan kepatuhan kebersihan tangan hal ini disebabkan karena supervisi yang dilakukan tidak hanya oleh IPCN tetapi IPCLN juga turut bantu mengingatkan untuk melakukan 5 moment 6 langkah cuci tangan dengan baik. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 85,10% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik, karena pada saat diklat KE juga dipastikan kemampuan satu per satu petugas untuk melakukan 6 langkah cuci tangan. Namun				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dibiasakan dalam melakukan tindakan sehari-hari.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa), hanya pada saat ada event saja terjadi peningkatan, belum menjadikan suatu kebiasaan petugas.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasienlain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

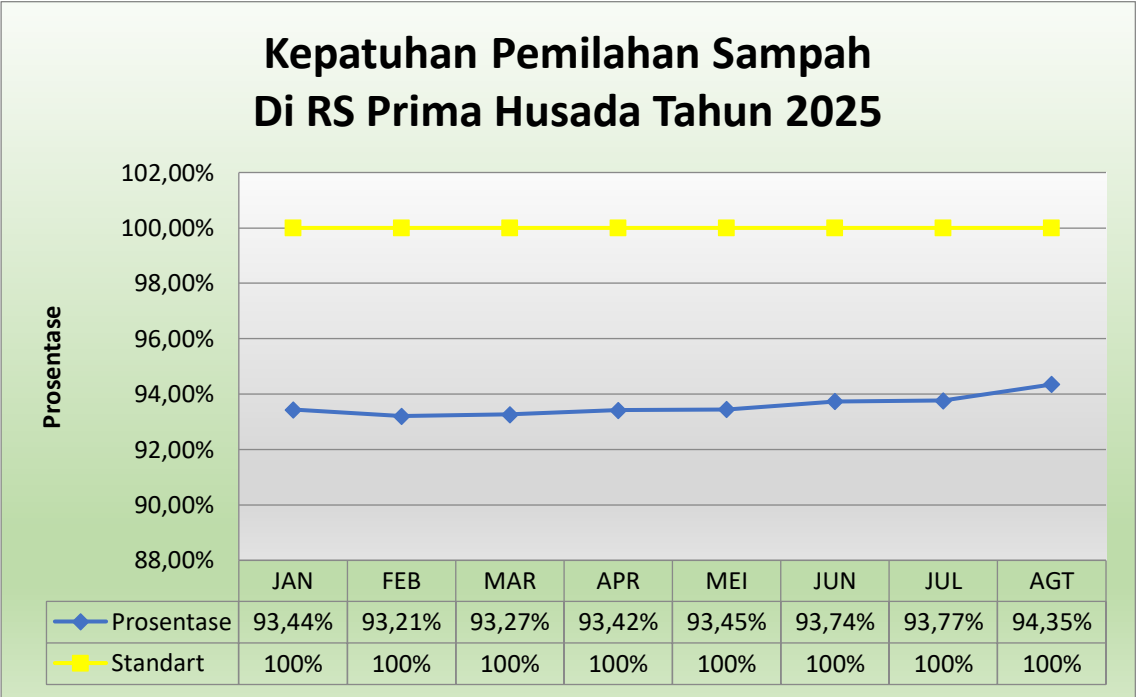


Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 94,3%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, terutama pada petugas penjamah makanan yang sudah rutin memakai masker dan perawat sudah lebih tertib untuk pemakaian sarung tangan sesuai tindakan yang akan dilakukannya. Namun masih ada 1 DPJP yang saat visite masih selalu memakai APD lengkap walaupun tidak melakukan tindakan invasif.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. 5. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

			6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 7. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

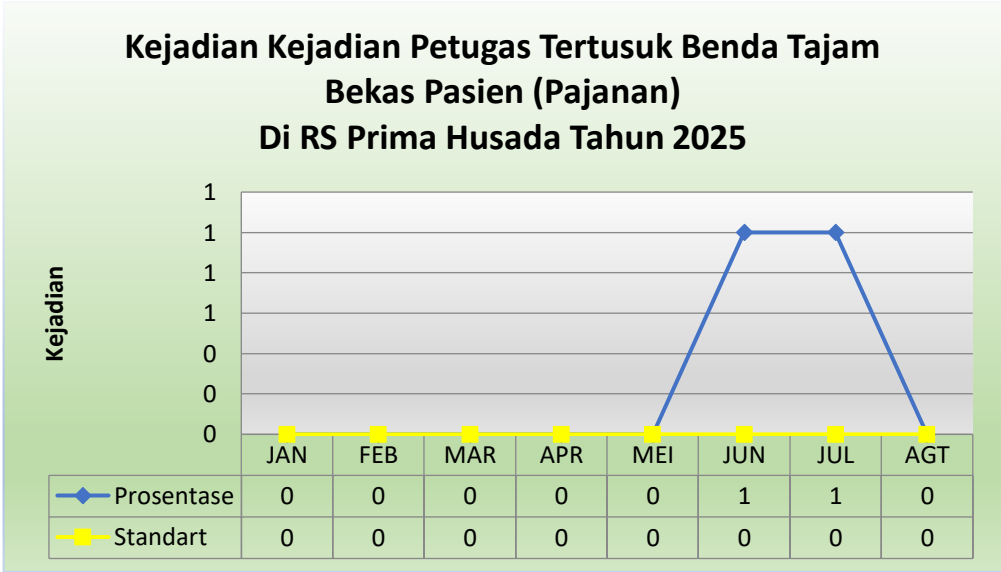
3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 94,35% mengalami sedikit peningkatan. Dari hasil monitoring dan supervise, memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan namun setelah dilakukan diklat komunikasi efektif yang berkolaborasi dengan seluruh pokja akreditasi termasuk PPI yang didalamnya juga ada materi kasus pemilahan sampah. Dimana staf terutama staf paramedis secara individu mendapat materi tersebut sehingga diharapkan memang pemahaman lebih mendalam terkait pemilahan sampah..					
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius (terutama bungkus alkes).					
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.					
Tindakan yang dilakukan	1. Memberikan materi diklat kolaborasi dengan pokja akrditasi tentang pemilahan sampah. 2. Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau 2 bengkok. 3. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 4. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 5. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 6. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit					
Rencana	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Tindak Lanjut					
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam
 3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Ditemukan 1 kali kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas (Cleaning service) di ruang maternitas, dikarenakan jarum yang menembus badan safety box dan mengenai tangan petugas saat petugas akan membetulkan posisi gantungan safety box, padahal isi safety box masih belum mencapai ¾ bagian.				
Masalah saat ini	Safety box tidak tahan tusukan (tembus jarum).				
Permasalahan sebelumnya	Jarum suntik yang bengkok meskipun sudah di tutup.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. 2. Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. 3. Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	----------------------------------	--	----------------------------------	------------

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

UNIT	TARGET	JUNI	JULI	AGUSTUS	%	MANDOK	KETERANGAN
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	75%	50%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C mengalami Penurunan dari Bulan Juli
ICU/HCU	4x/Bulan	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU Mengalami Kenaikan
IRNA 3C	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 3C Tidak mencapai Target mulai bulan Juni
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS mengalami Kenaikan
PERINATOLOGI	4x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI Sesuai Target
IRNA 5C	4x/Bulan	25%	100%	50%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C mengalami Penurunan
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	75%	100%	50%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A mengalami Penurunan
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	0%	0%	100%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Sesuai Target dan mengalami kenaikan
IGD	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IGD Tidak mencapai Target mulai bulan Juni
FARMASI	4x/Bulan	25%	50%	50%	Meningkat	Lampiran B	FARMASI perlu ditingkatkan kembali
GIZI	4x/Bulan	0%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	Gizi Sesuai Target
IRJA	4x/Bulan	25%	100%	100%	Menurun	Lampiran B	IRJA Sesuai Target

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Agustus Petugas PKRS

tiap unit tidak terlaksana dengan baik, dari data tersebut Unit IRNA 2C, 5C, IRNA 2A,3A,4A, FARMASI, IGD tbelum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal, terutama untuk UNIT IGD dan 3C terlihat tidak tercapai target mulai bulan JUNI.

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar keteringgalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	JUNI	JULI	AGUSTUS	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	JUNI	JULI	AGUSTUS	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	25%	75%	25%	Tidak Tercapai	√	Belum terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	25%	0%	25%	Tidak Tercapai	√	-
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	50%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	25%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan Agustus PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

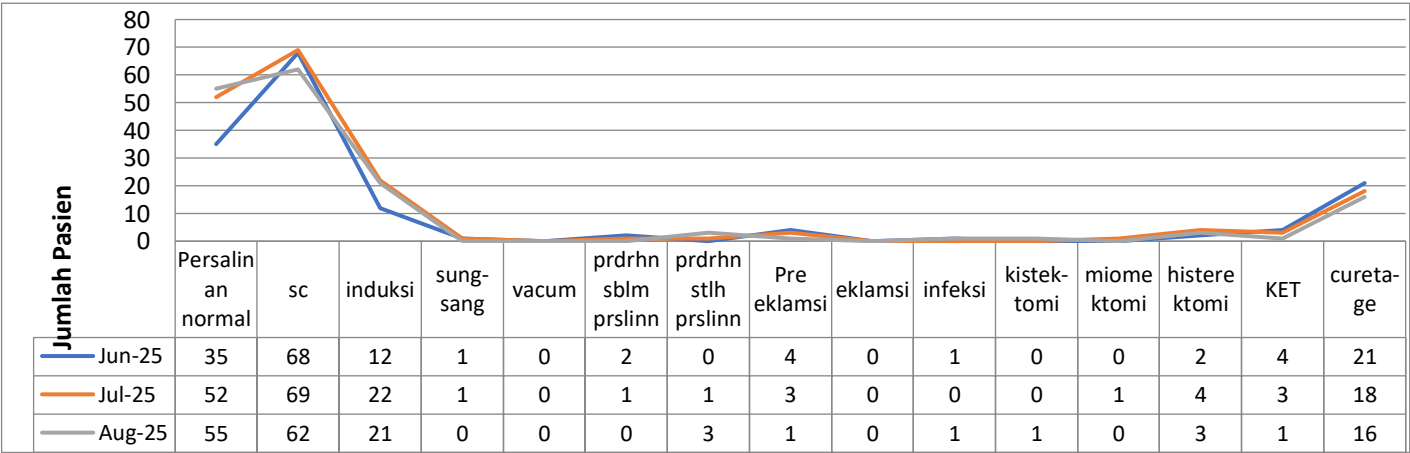
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	35	52	55
	b. SectioCaesaria	68	69	62
2				
	a. Induksi / Drip	12	22	21
	b. Sungsang	1	1	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	2	1	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	0	1	3
	c. Pre Eklamsi	4	3	1
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	1	0	1
4				
	a. Curretage	21	18	16
	b. Kistektomi	0	0	1
	c. Miomektomi	0	1	0
	d. Histerectomy	2	4	3
	e. KET	4	3	1

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Agustus 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 62 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Agustus 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 55 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih

- dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan Agustus sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien di maternitas yang juga menurun pada bulan Agustus 2025.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
 3. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Agustus 2025, sedangkan pada bulan Juni dan Juli 2025 ada 1 persalinan sungsang. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Agustus 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 4. Induksi Persalinan pada bulan Agustus mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 21 pasien
 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Agustus 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien. Dan ada tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Agustus 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 6. Jenis pelayanan curretage di bulan Agustus 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 16 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

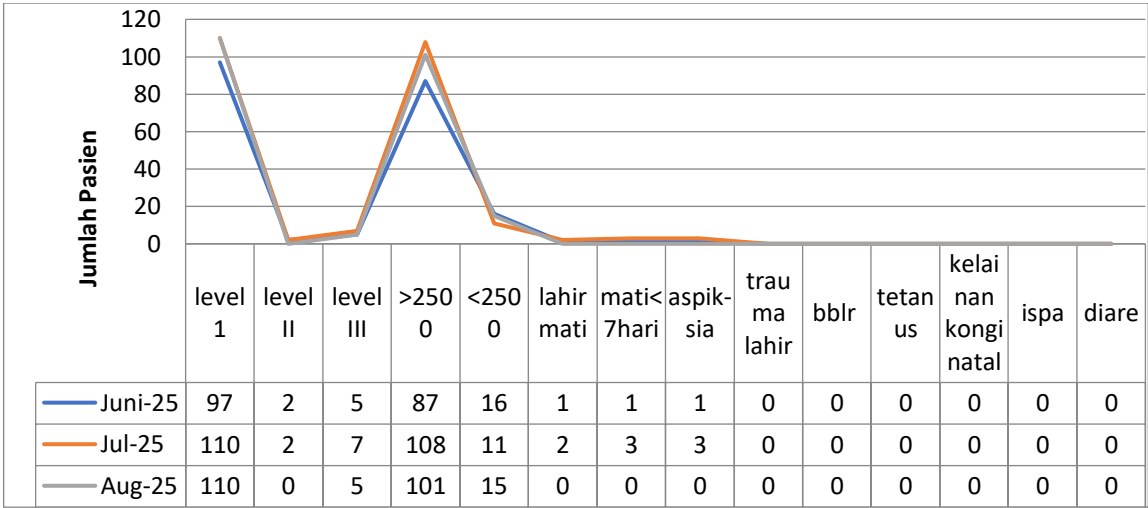
3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Agustus 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1				
	a. Level 1	97	110	110
	b. Level II	2	2	0
	c. Level III	5	7	5
2				
	a. ≥ 2500 gram	87	108	101
	b. ≤ 2500 gram	16	11	15
3				
	a. Kelahiran Mati	1	2	0
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	3	0
4				
	a. Asphyxia	1	3	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	16	11	15
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0

	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Agustus 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Agustus 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 110 bayi. Dan tidak ada pelayanan level 2 pada bulan Agustus. Sedangkan pada level 3 juga menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 5 bayi. Jumlah bayi bulan Agustus 2025 menurun seiring dengan jumlah persalinan pada bulan Agustus 2025
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Agustus 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 101 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Agustus 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Agustus 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 15 bayi.
5. Tidak ada kasus kelahiran mati pada bulan Agustus 2025, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 1 kasus. Dan Juni 1 kasus.
6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Agustus, sedangkan pada bulan Juli 2025 ada 3 kasus dan 1 kasus pada bulan Juni 2025.

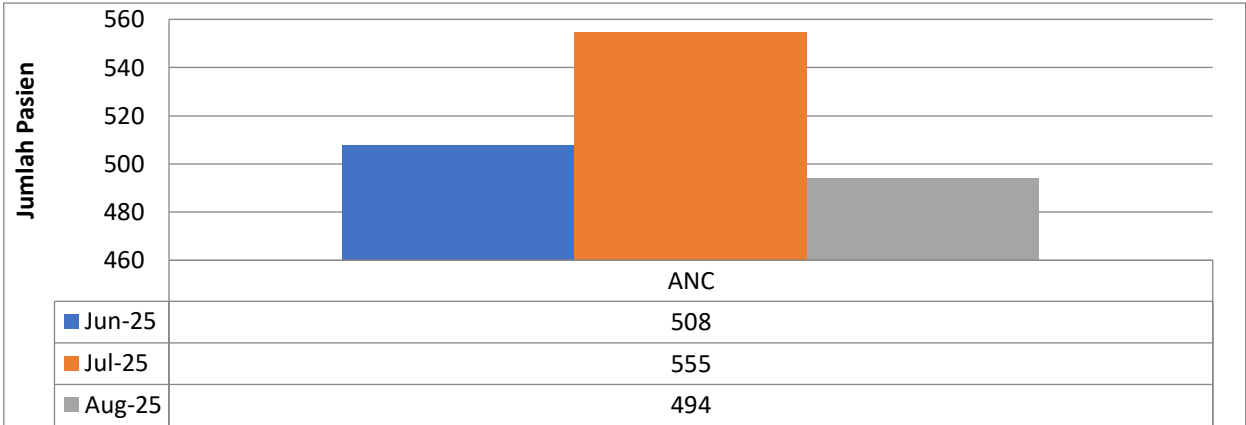
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.53 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Juli 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	ANC	508	555	494

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Agustus 2025



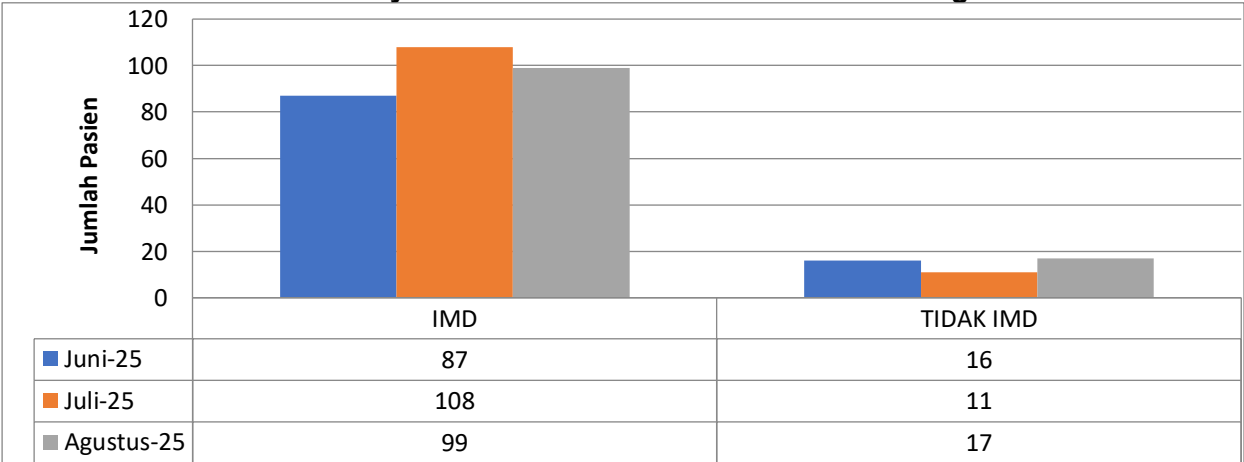
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Agustus 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 494 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.7.54 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Agustus 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	IMD	87	108	99
2	Tidak IMD	16	11	17

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Agustus 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 99 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Agustus meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi, Sedangkan pada bulan Juli sebanyak 11 bayi, dan bulan Juni sebanyak 16 bayi.
- 3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Agustus 2025

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Erika	NKB + BBLR	Cuvis
2	By Ny Wikke	NKB + BBLR	Inkubator + CPEP
3	By Ny Lisfiatul	NCB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Siska	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Siti Nur	NCB + BBLR	Cuvis
6	By Ny Hilda	NCB + BBLR	Cuvis
7	By Ny Myra	NCB + BBLR	Cuvis
8	By Ny Siti Nur	NKB + BBLR	Cuvis
9	By Ny Widya	NKB + BBLR	Cuvis
10	By Ny Lailatul	NCB + BBLR	Cuvis
11	By Ny Ngatinah	NKB + BBLR	Cuvis
12	By Ny Indah	NCB + BBLR	Cuvis
13	By Ny Rianti	NKB + BBLR	Cuvis
14	By Ny Sofiatul	NKB + BBLR	Cuvis
15	By Ny Ainun	NCB + BBLR	Cuvis
16	By Ny Siti K	RDS	Inkubator + CPEP
17	By Ny Fanisa	NKB + RDS	Inkubator + CPEP

Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

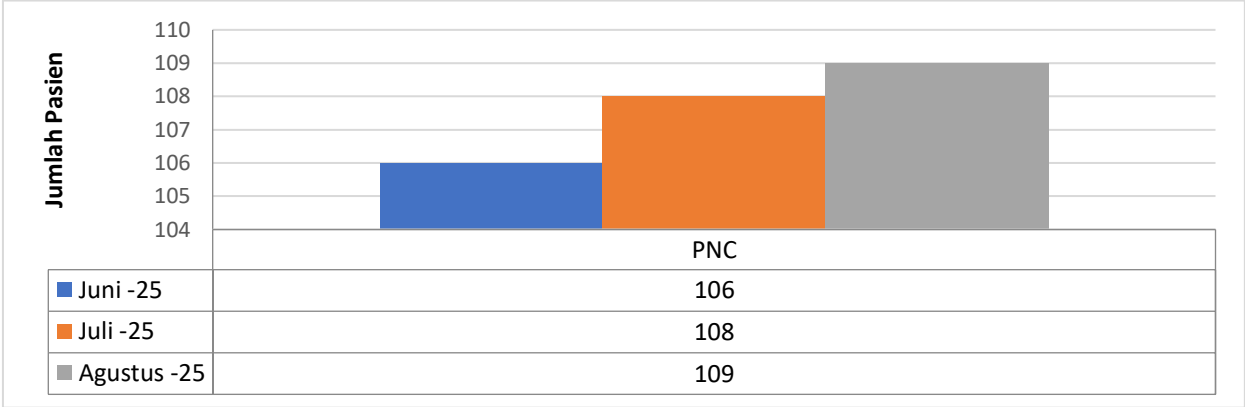
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak.

3.7.55 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponok Agustus 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	PNC	106	108	109

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Agustus 2025 penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 109 kunjungan.

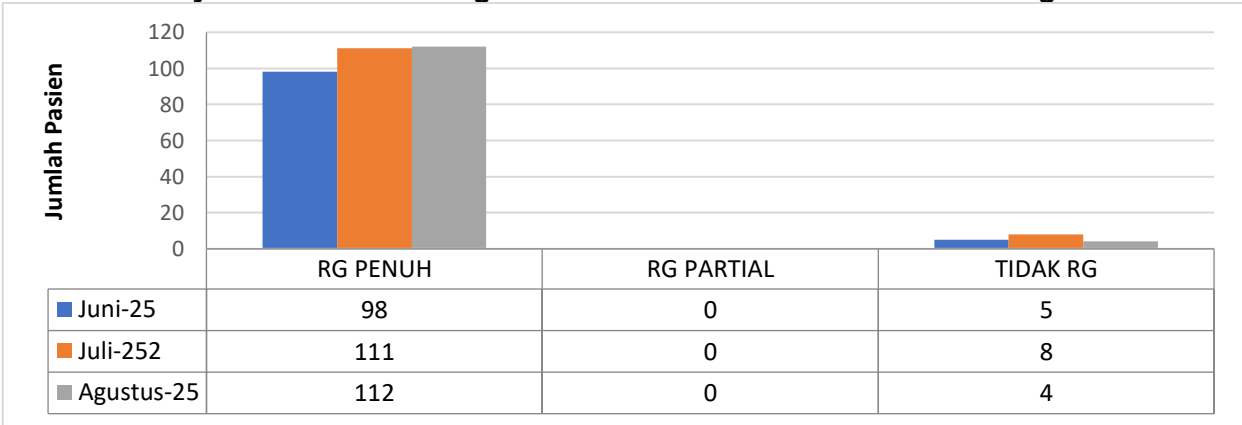
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Agustus 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	Rawat gabung penuh	98	111	112
2	Rawat gabung partial	0	0	0
3	Tidak Rawat gabung	5	8	4

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :

1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Agustus 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 112 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Agustus 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 bayi.
3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Wikke	NKB + BBLR	Inkubator + CPEP
2	By Ny Nur Aini	NCB + RDS	Inkubator + CPEP
3	By Ny Siti K	RDS	Inkubator + CPEP
4	By Ny Fanisa	NKB + RDS	Inkubator + CPEP

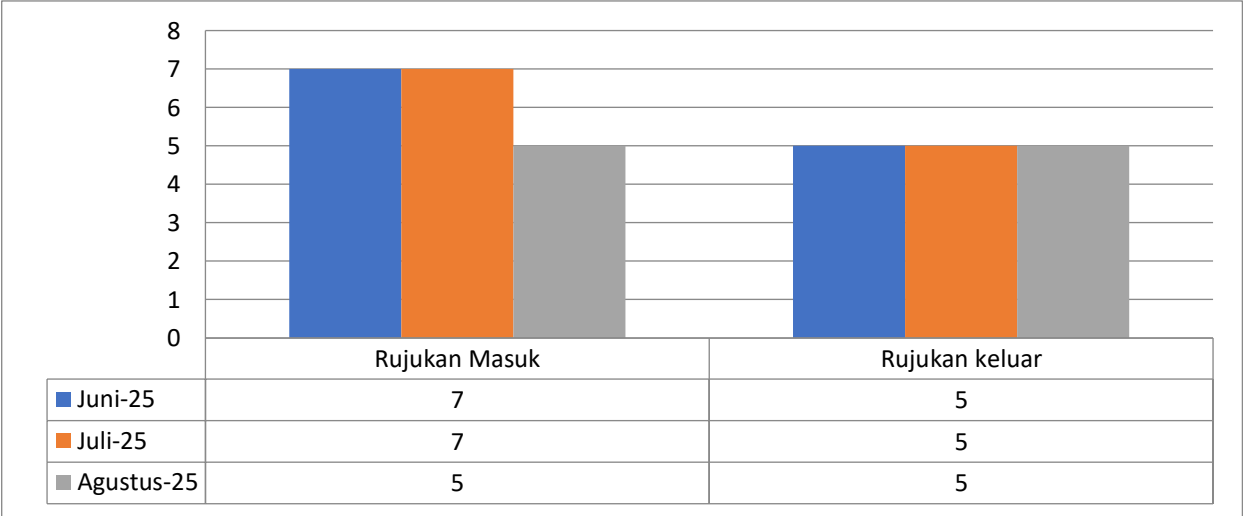
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek Agustus 2025

NO	RUJUKAN	BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	Rujukan Masuk	7	7	5
2	Rujukan keluar	5	5	5

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Agustus 2025

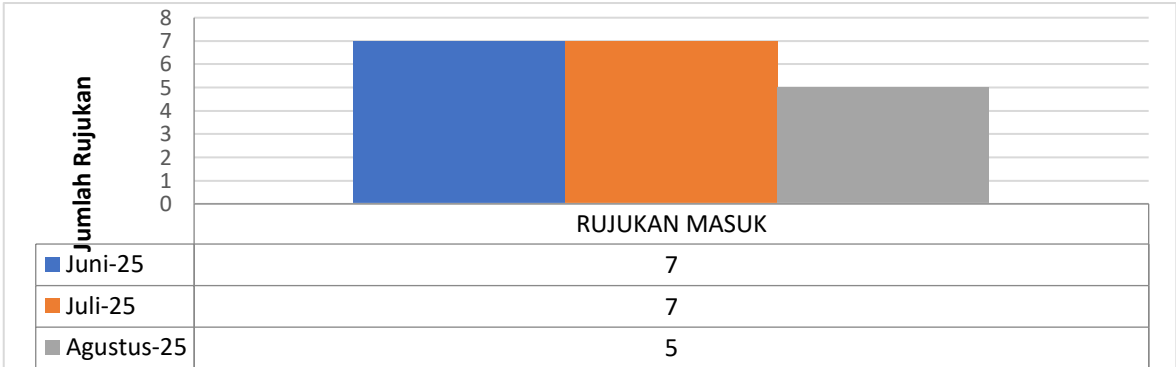


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponek Agustus 2025

BULAN JUNI 2025			
1	Sri Wahyuni	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 mgg dg KIFA + letsu	PKM Singosari
2	Nimas Ayu M	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg d PEB	BPM Lilik A
3	Indahwati	G2 P1001 AB000 UK 35-36 mgg dg HT + Gemeli + PPR0M	BPM Subaedah
4	Angesti Pina	G2 P1001 Ab000 UK 38-39 mgg dg KPD	Klinik Mutiara Sehat
5	Viqi Ijatul	G2 P1001 Ab000 UK 41-42 mgg dg Kala 2 Lama	BPM Sumaiyah
6	Siti Rosita	G2 P1001 Ab000 UK 41-42 mgg dg KIFL + APB EC Plasenta Previa + IUFD	PKM Singosari
7	By Ny lin K	RDS OK Neonatal	PKM Singosari
BULAN JULI 2025			

1	By Ny Marita	Asfiksia	PMB Tri
2	Ny Anis Puspita Sari	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PEB	PKM Singosari
3	Ny Evi Yuniarti	G3 P2002 Ab000 UK 40-41 mgg dg KPD + KIFL	PKM Ardimulyo
4	Ny Nurul Sa'adah	G2 P1001 Ab000 Uk 8-10 mgg dg Abotus Inkomplit	PMB Tri W
5	Ny Dita Puri A	G1 P0000 Ab000 Uk 38-39 mgg dg KIFA	Klinik Mutiara Sehat
6	Ny Shifatul Husni	G1 P0000 Ab000 Uk 41-42 mgg dg KIFL	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Vira	G1 P0000 Ab000 Uk 34-36 mgg dg PEB	Klinik Muslimat
BULAN AGUSTUS 2025			
1	By Ny Nur Fitri	RDS	PMB Tri W
2	Ny. Illa Rodhiyah	G4 P1103 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Siska A	G1 P0000 AB 0 UK 32-34 MGG dg kala 2	PKM Singosari
4	Ny Siti Nur H	G1P000 AB00 UK 39-40 Mgg dg kala 2	PKM Lawang
5	Ny Widya A	G1 P0000 AB000 UK 32-34 Mgg dg PPR0M	Klinik Mutiara Sehat

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan Agustus menurun yaitu 5 rujukan, sedangkan pada bulan Juni dan Juli 2025 sama, yaitu 7 rujukan.

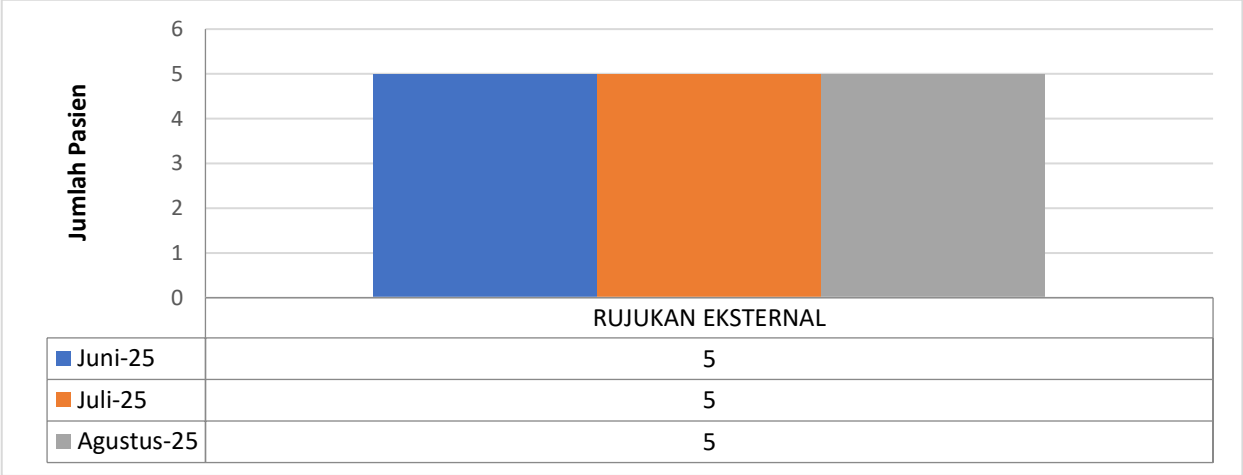
Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
 Tabel Rujukan Keluar Ponек Agustus 2025

BULAN JUNI 2025						
1	Ny Churi	30 th	Maternitas	P3104 Ab100 dg Post SC +VSD+ Hematuria + Akut Abdomen	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	RS Saiful Anwar
2	By Ny Any	2 hari	NICU	RDS + BBLSR	Pro Ventilator	RS Saiful Anwar
3	By Ny Indah	4 hari	NICU	BBLASR + obs distress nafas dd RDS	Pro NIPPV dan tata laksana	RS Lavalette

					subspesialistik neonatologi	
4	By Ny lia	3 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro NIPPV dan tata laksana subspesialistik neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny lin	3 hari	NICU	RDS dd MAS, Neonatal seizure, susp HIE, neonatal pneumonia	Tatalaksana supneurologi anak, subspesialistik neonatologi	RST Soepraoen
BULAN JULI 2025						
1	Stefia Shallom	16 th	IGD	Abdominal pain susp Neoplasma Ovarial	Pro laparotomi back up bedah digestive	RS Saiful Anwar
2	By Ny Manda Kumalasari	3 hari	NICU	RDS + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Nadia	4 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Marita	1 hari	NICU	RDS + Susp DS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Retnosari	1 hari	NICU	RDS + Bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
BULAN AGUSTUS 2025						
1	Riyanti	41 Th	Maternitas	P2103 Ab000 dg Post SC+MOW hari ke 2 a/l Inpending eklamsi + anuria	Pro Hemodialisa	RS Saiful Anwar
2	Nn Nafisa	17 Th	Irna 5C	Susp Internal bleeding ec KET + trombositopenia + anemia	Pro Laparatomy cito dg backup transfusi TC	RS Saiful Anwar
3	By Ny Wikke	1 hr	NICU	NKB + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Nur Aini	2 hr	NICU	NCB + Pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Nur Fitri	3 hr	NICU	RDS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Agustus 2025



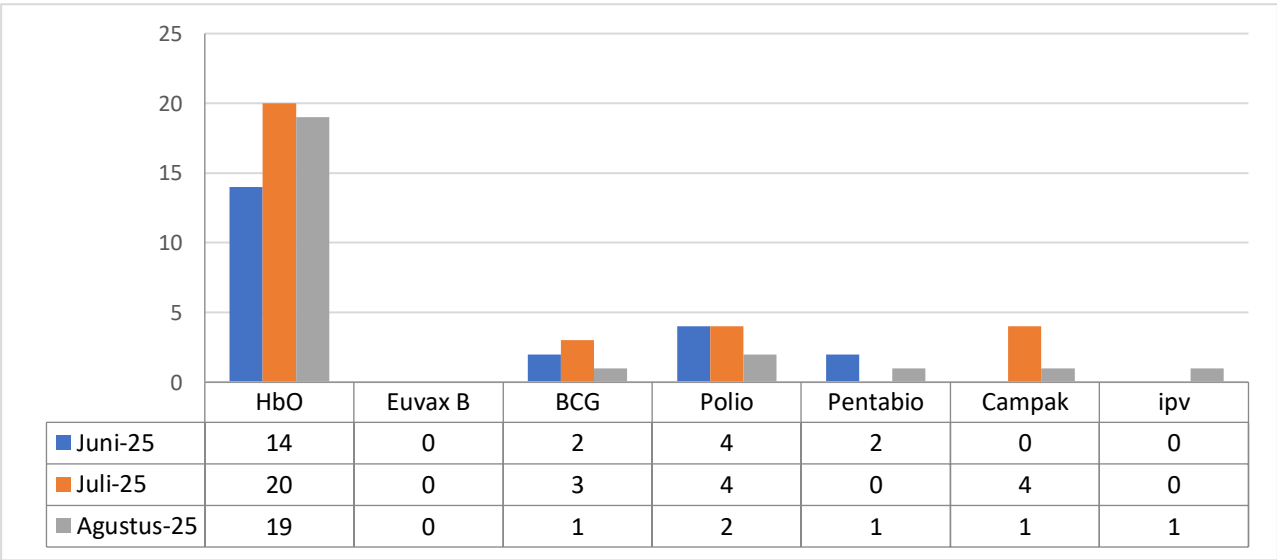
Analisis :
Pada bulan Agustus dan 2 bulan sebelumnya jumlah rujukan eksternal sama yaitu 5 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Agustus 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	HbO	14	20	19
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	3	1
3	Polio	4	4	2
4	Pentabio	2	0	1
5	Campak	0	4	1
6	IPV	0	0	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Agustus 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
- 2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Agustus sebanyak 19 bayi, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 20 bayi, dan bulan Juni sebanyak 14 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterersediaan vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi, sedangkan 2 bulan sebelumnya tidak ada.
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Agustus menurun sebanyak 1 bayi, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 3 bayi, dan Juni sebanyak 2 bayi.
- 5. Bayi yang melakukan Imunisasi Campak pda bulan agustus menurun yaitu 1 bayi, sedangkan bulan Juli sebanyak 4 bayi, dan pada bulan Juni tidak ada
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Agustus sebanyak 2 bayi, sedangkan Juni dan Juli sama, yaitu 4 bayi.
- 7. Bayi yg imunisasi Pentabio pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi, sedangkan bulan Juli tidak ada, dan pada bulan Juni sebanyak 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

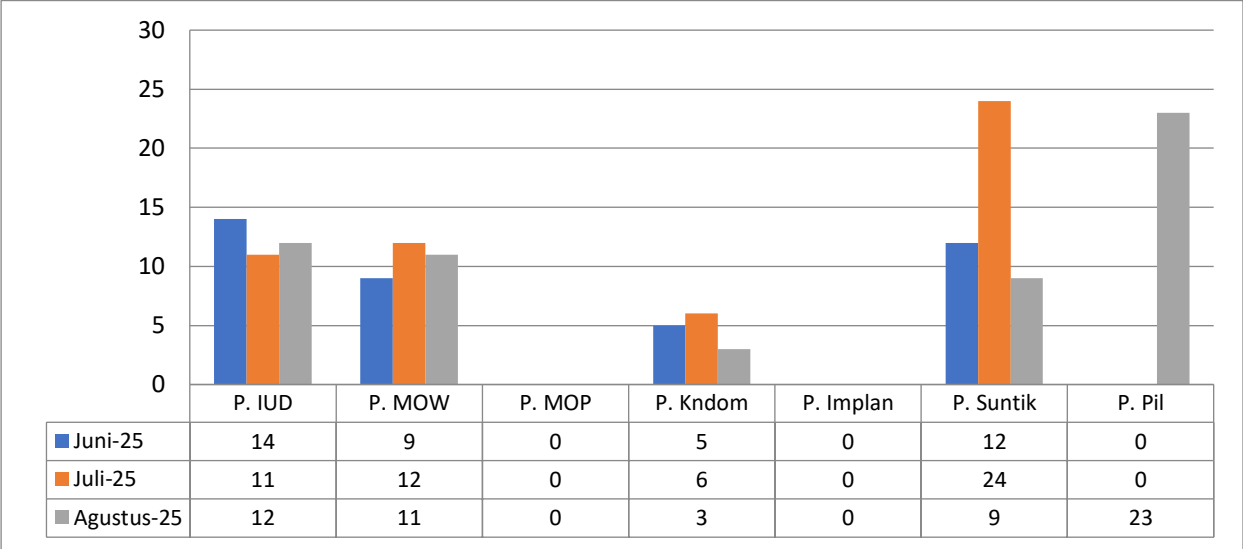
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Agustus 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	IUD	14	11	12
2	MOW	9	12	11
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	5	6	3
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	12	24	9
7	Pil	0	0	23

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2025



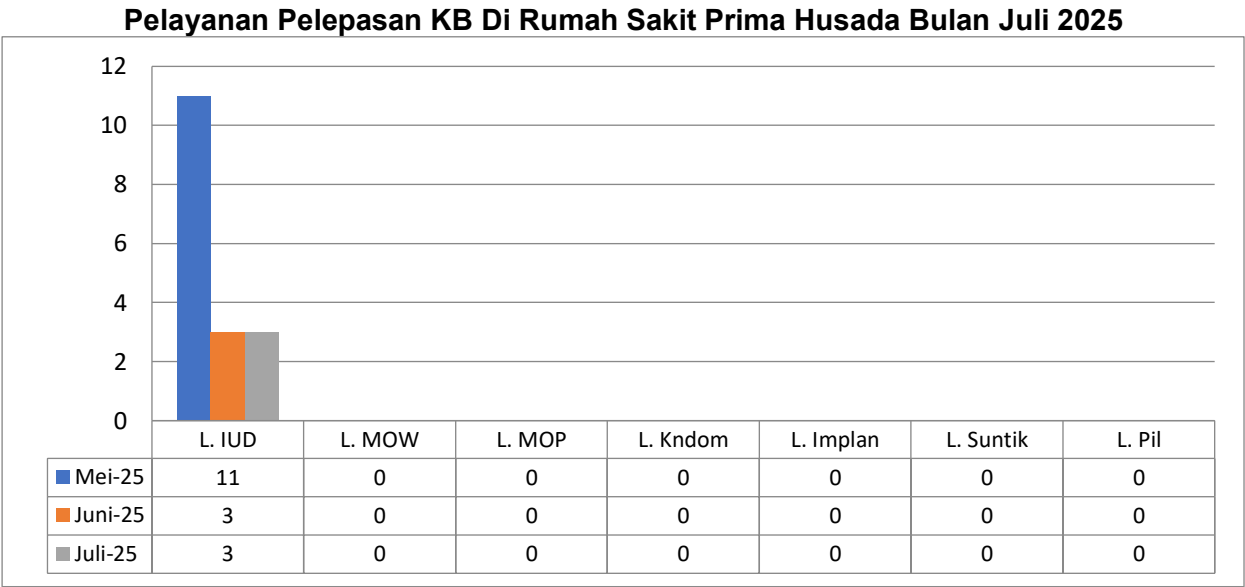
Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Agustus 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 12 akseptor yang terdiri dari 8 akseptor IUD Nova T dan 4 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Agustus 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 11 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Agustus menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu sebanyak 3 pengguna, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 6 pengguna, dan Juni 5 pengguna.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Agustus sebanyak 23 pengguna, sedangkan Juni dan Juli tidak ada.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Agustus menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 9 pengguna, sedangkan bulan Juli sebanyak 24 pengguna dan Juni 12 pengguna.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

NO	JENIS	JUMLAH LEPAS		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	IUD	3	3	8
2	MOW	0	0	1
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0



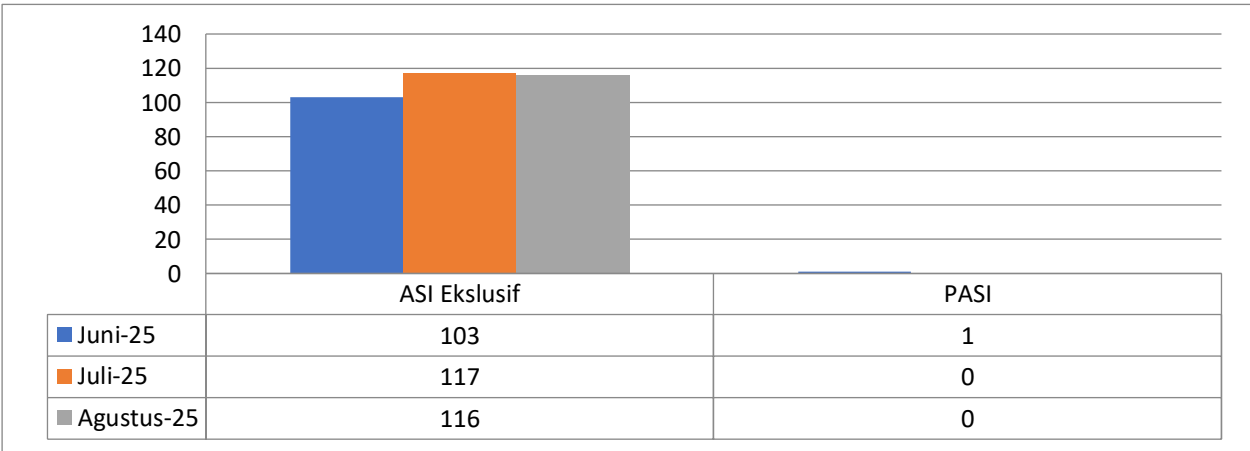
- Analisis :**
- 1. Pelepasan KB IUD pada bulan Juli dan Juni sama yaitu 3 Akseptor, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 11 Akseptor
 - 2. Tidak ada pelepasan KB Implan pada bulan Juli 2025 dan juga 2 bulan sebelumnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Juli 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	Asi eksklusif	103	117	116
2	Asi /PASI	1	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2025

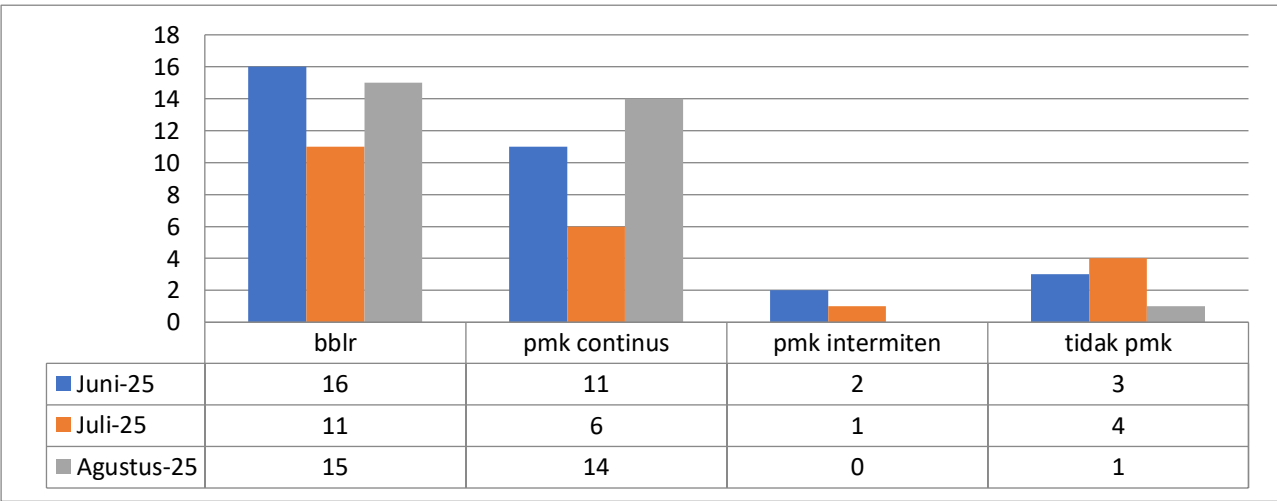


- Analisis :**
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Agustus sedikit menurun yaitu 116 bayi, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 117 bayi, dan Juni sebanyak 103 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan Agustus dan Juli, sedangkan bulan Juni sebanyak 1 bayi. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponik Agustus 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	Bayi BBLR	16	11	15
2	PMK continuos	11	6	14
3	PMK Intermiten	2	1	0
4	Tidak PMK	3	4	1



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Agustus 2025

- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - 2. Tidak ada pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Agustus, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 1 bayi, dan pada bulan Juni 2 bayi. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
 - 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Agustus meningkat yaitu 14 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan Juli 2025 sebanyak 6 bayi, dan bulan Juni sebanyak 11 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
 - 4. Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Agustus, sedangkan pada bulan Juli ada 4 bayi, dan Juni ada 3 bayi.
- Berikut daftar bayi yang tidak dilakukan PMK

Berikut daftar bayi yang tidak dilakukan PMK

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL	Alasan
1	By Ny Wikke	NKB BBLR	Inkubator dan CPEP	Bayi di rujuk

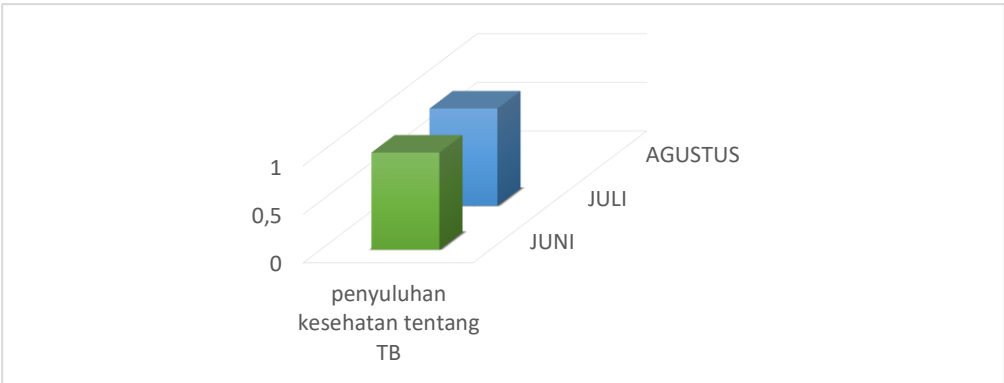
Rencana dan Tindak Lanjut
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.7.56 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	1

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

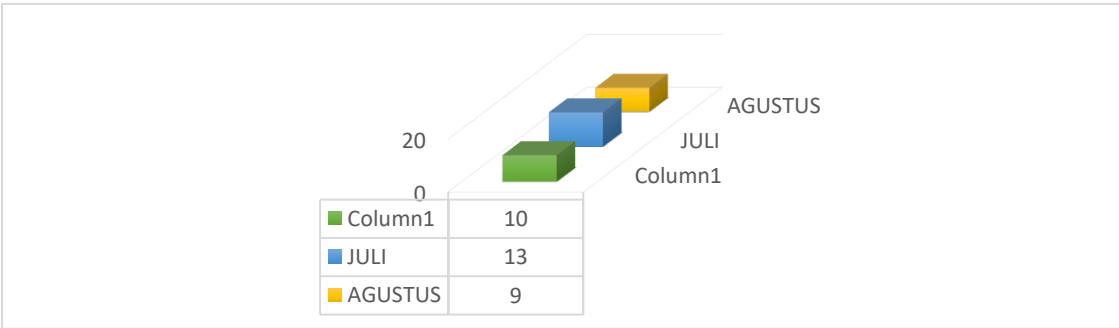
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian Masker	10	13	9

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- 1) Pada bulan Juni 2025 terdapat 10 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 2) Pada bulan Juli 2025 terdapat 13 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 3) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 9 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

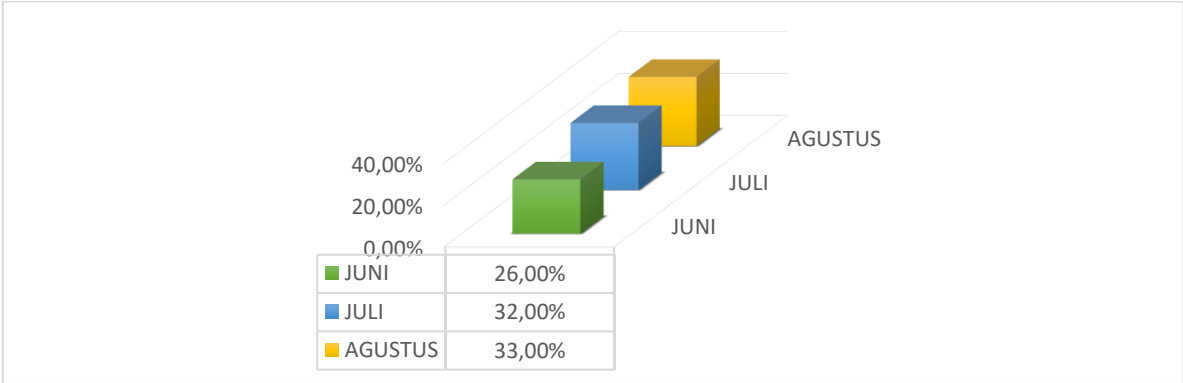
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	26	32	33

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1) Pada bulan Juni 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 26 orang
- 2) Pada bulan Juli 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 32 orang
- 3) Pada bulan Agustus 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 33 orang

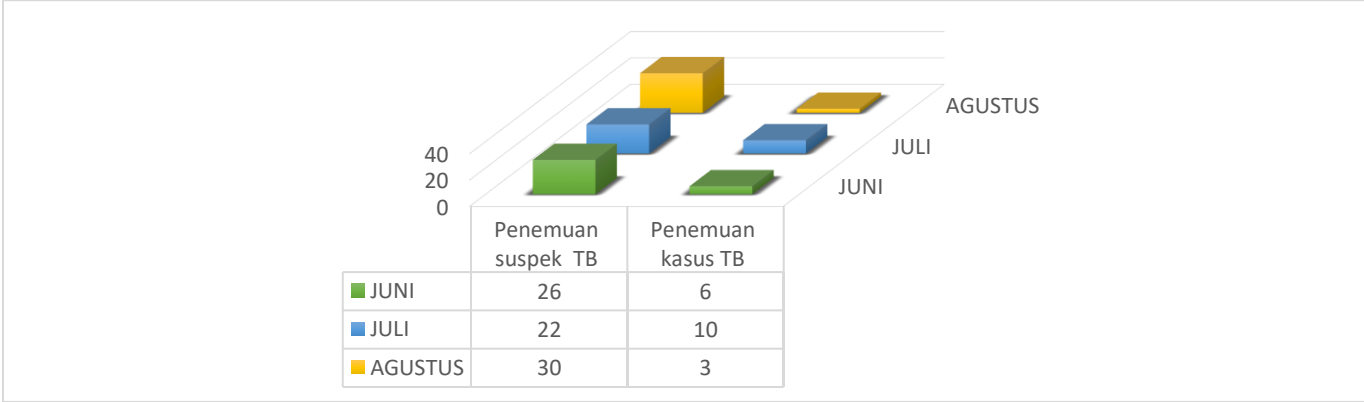
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Penemuan suspek TB	26	22	30
2	Penemuan kasus TB	6	10	3

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 26 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien
- 2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 22 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 10 pasien
- 3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 33 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 3 pasien

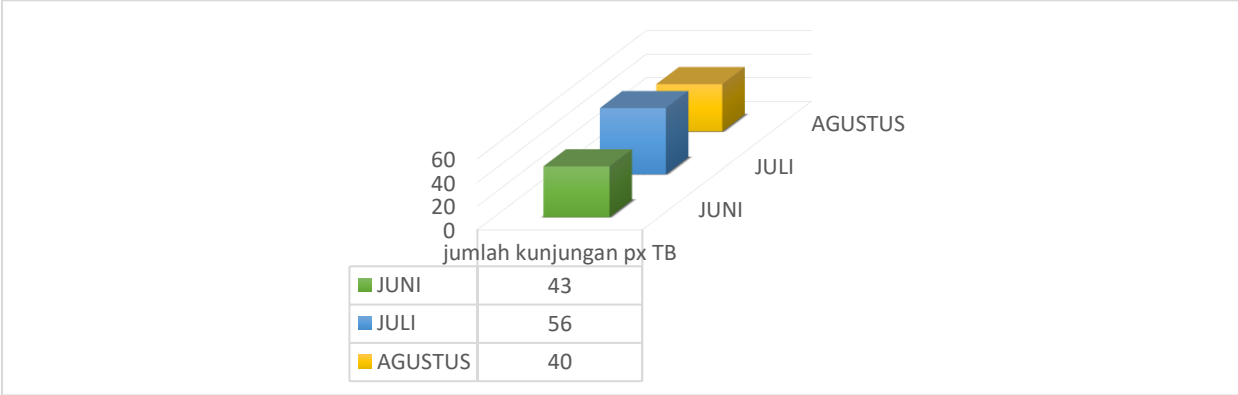
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	43	56	40

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juni 2025 di poli pasien TBC mencapai 43 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juli 2025 di poli pasien TBC mencapai 56 pasien.
- 3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Agustus 2025 di poli pasien TBC mencapai 40 pasien.

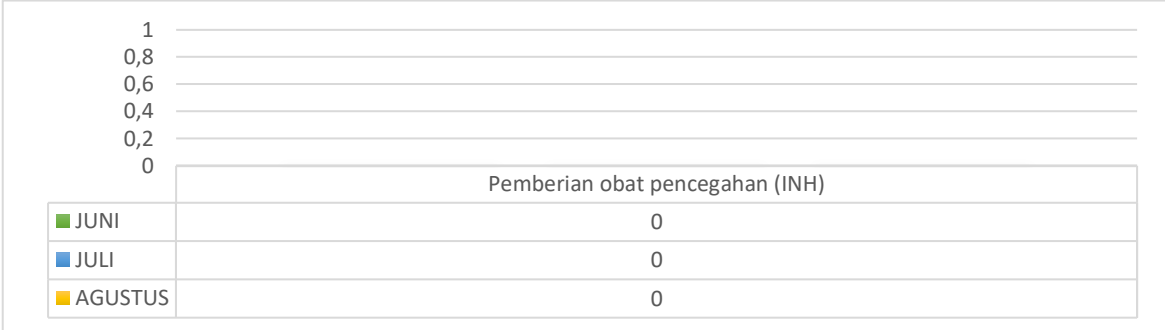
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

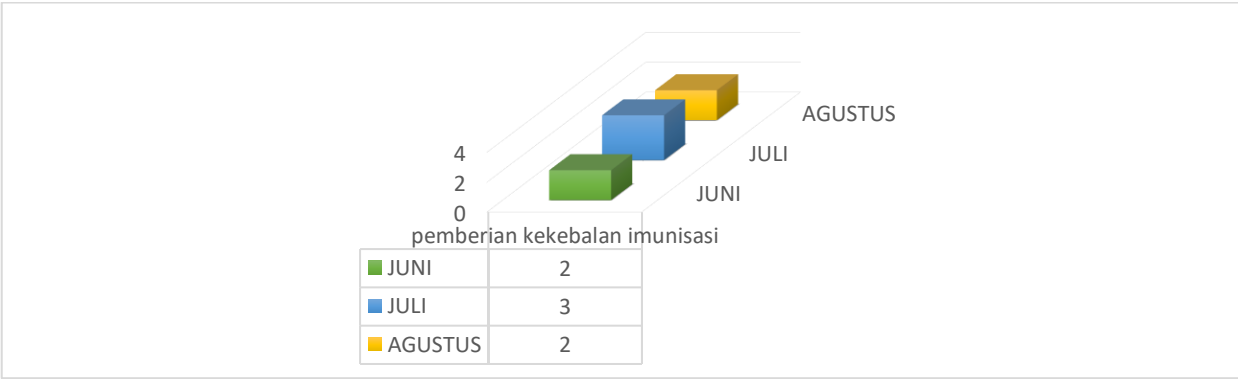
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pemberian imunisasi BCG	2	3	2

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada



Analisis :

1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Juli
3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Agustus

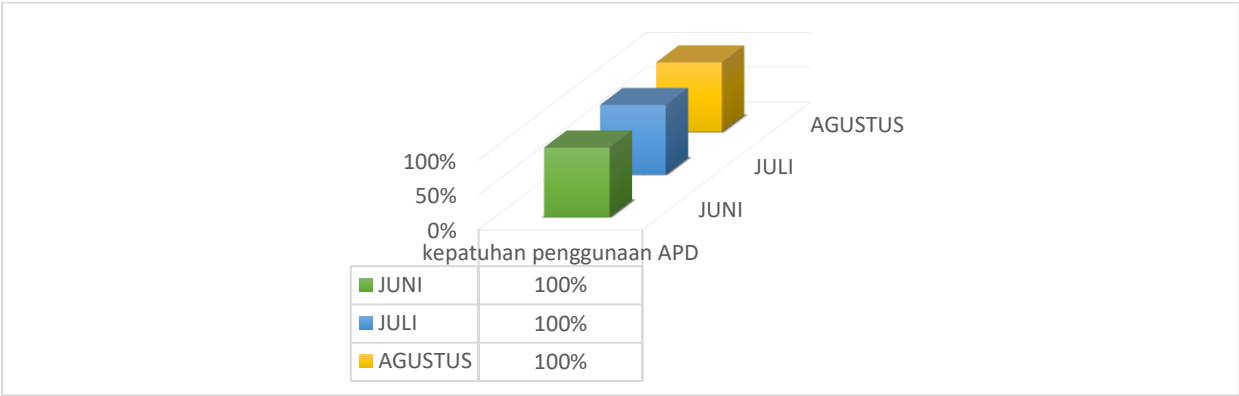
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG

2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%

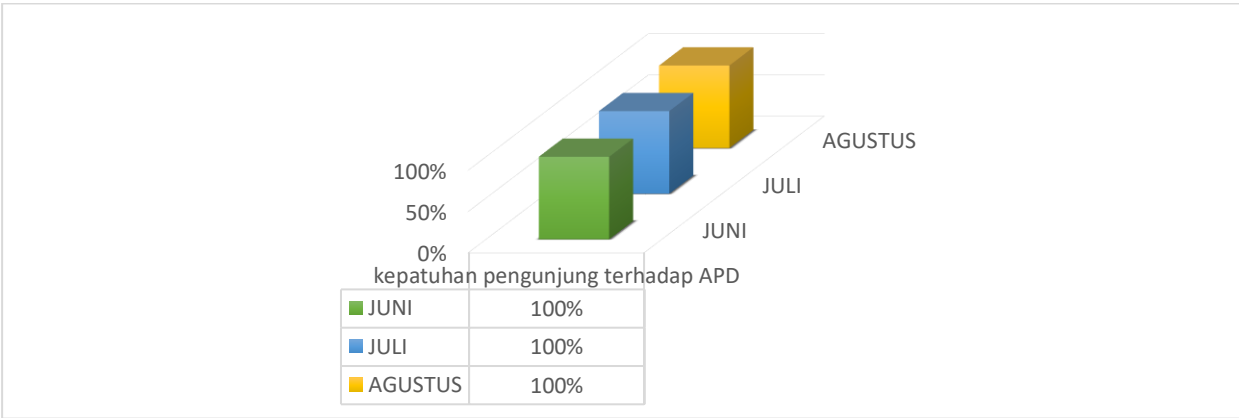


Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%



Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker

kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

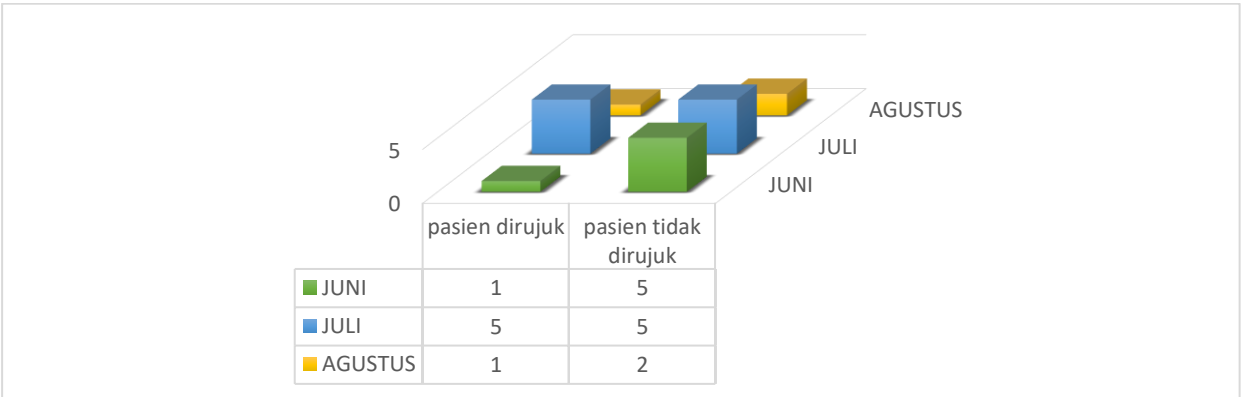
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien TB yang dirujuk	1	5	1
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	5	5	2

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	OAT Anak	3	3	1
2.	OAT Harian Dewasa	18	11	10
3.	Ethambutol	1008	896	672
4.	Pirazinamid	940	890	890
5.	Isoniazid	1380	1380	1380
6.	Rimfapicin 450 mg	1570	1570	1470
7.	Rimfapicin 300 mg	36	0	0

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



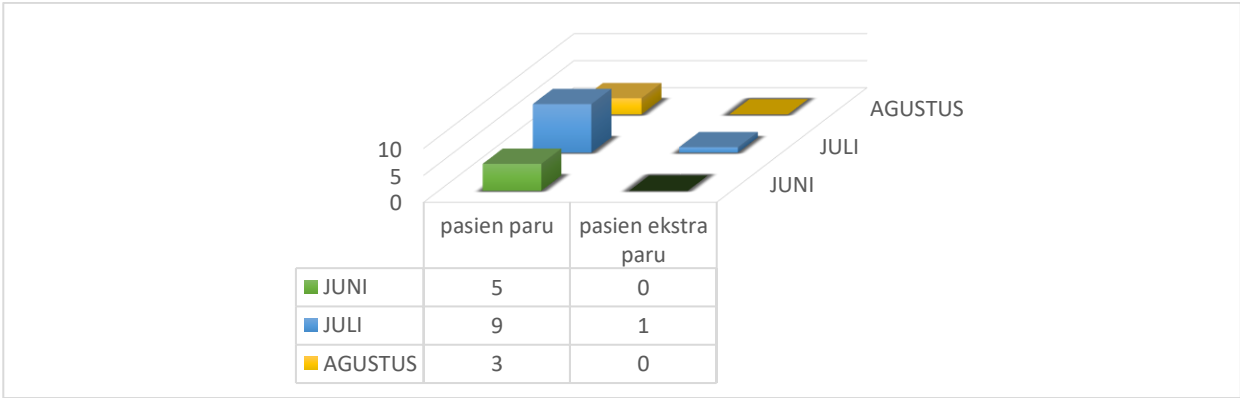
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien paru	5	9	3
2.	Pasien Ekstra paru	0	1	0

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

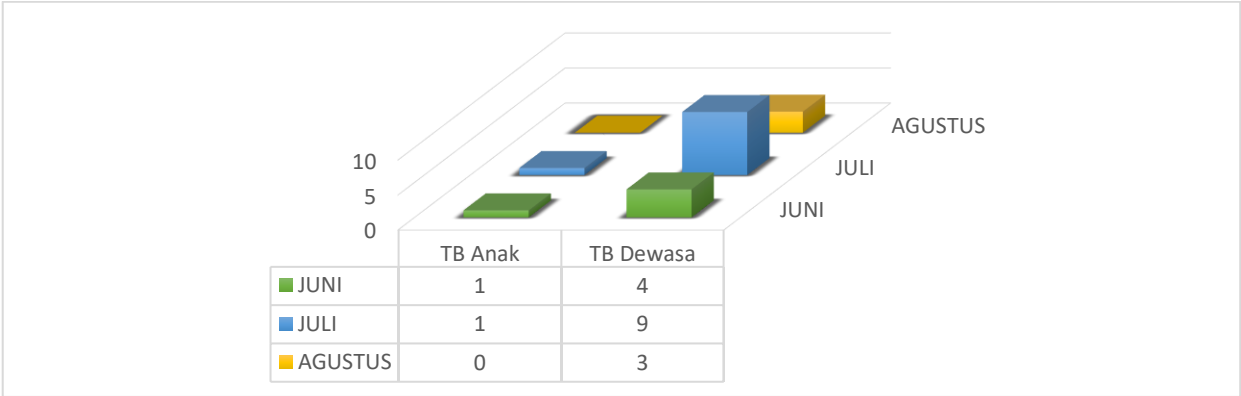
1. Pada bulan Juni 2025 terdapat 5 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru
2. Pada bulan Juli 2025 terdapat 8 pasien paru dan 1 pasien ekstra paru
3. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 3 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI	JULI	AGUSTUS
1.	Pasien Anak	1	1	0
2.	Pasien Dewasa	5	9	3

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :

- 1. Pada bulan Juni terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien
- 2. Pada bulan Juli terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 9 pasien
- 3. Pada bulan Agustus terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Tn. R	V		
		Tn.P	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	TN. T	V		

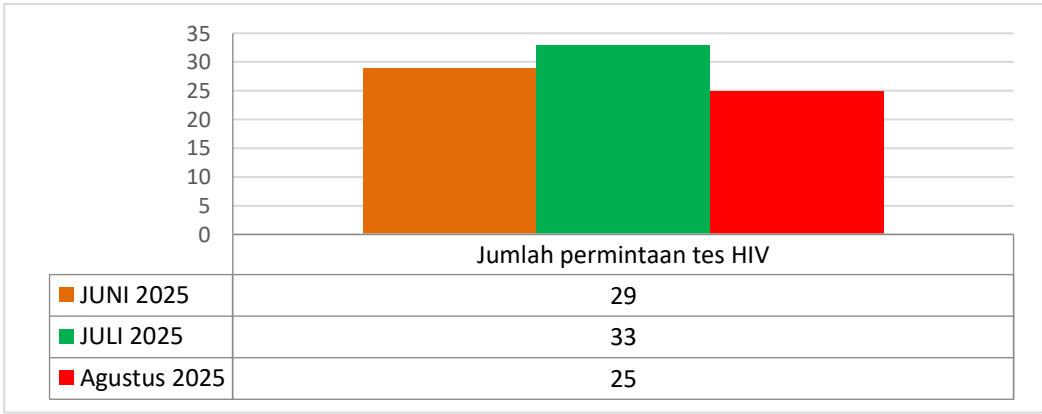
Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Permintaan Test HIV	29	33	25

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
 Bulan Agustus 2025



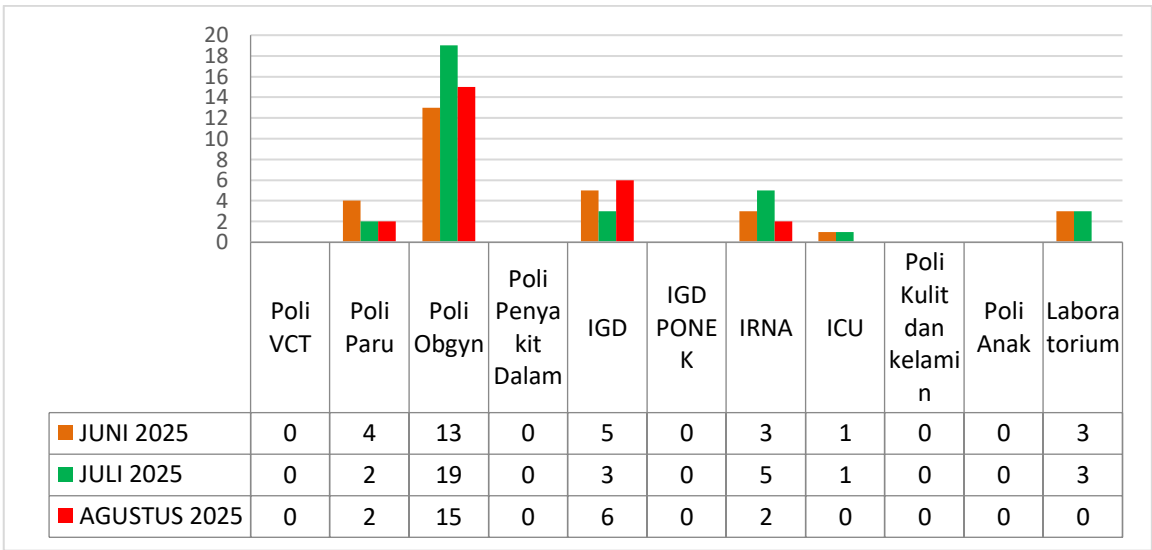
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan juni 2025 sebanyak 29 pemeriksaan. pada bulan Juli 2025 sebanyak 33 pemeriksaan. Sedangkan pada bulan Agustus 2025 sebanyak 25 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.57 Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	2	2
3	Poli Obgyn	13	19	15
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	5	3	6
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	3	5	2
8	ICU	1	1	0
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	3	3	0

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Agustus 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Juni sebanyak 13 pasien. pada bulan Juli 2025 sebanyak 19 pasien. Sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 15 pasien.

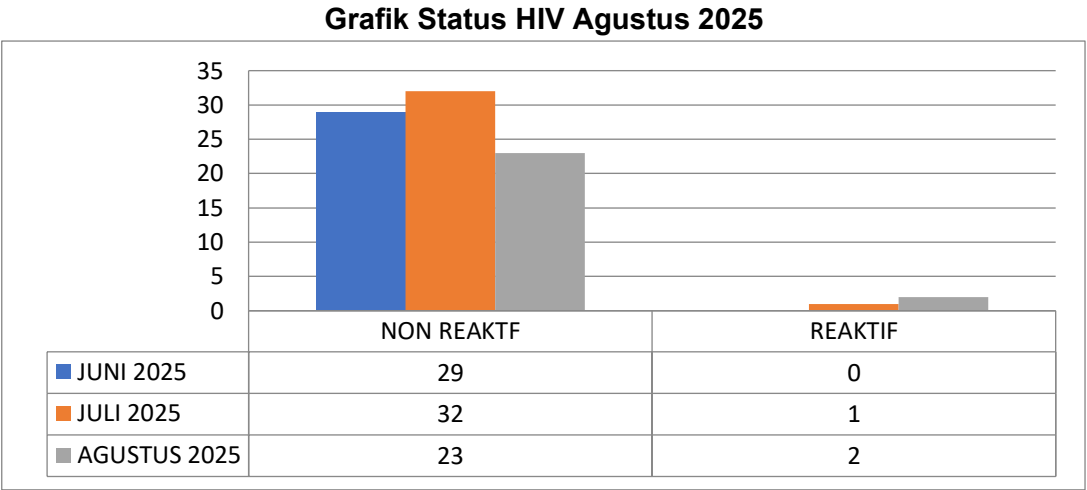
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Non Reaktif	29	32	23
2	Reaktif	0	1	2

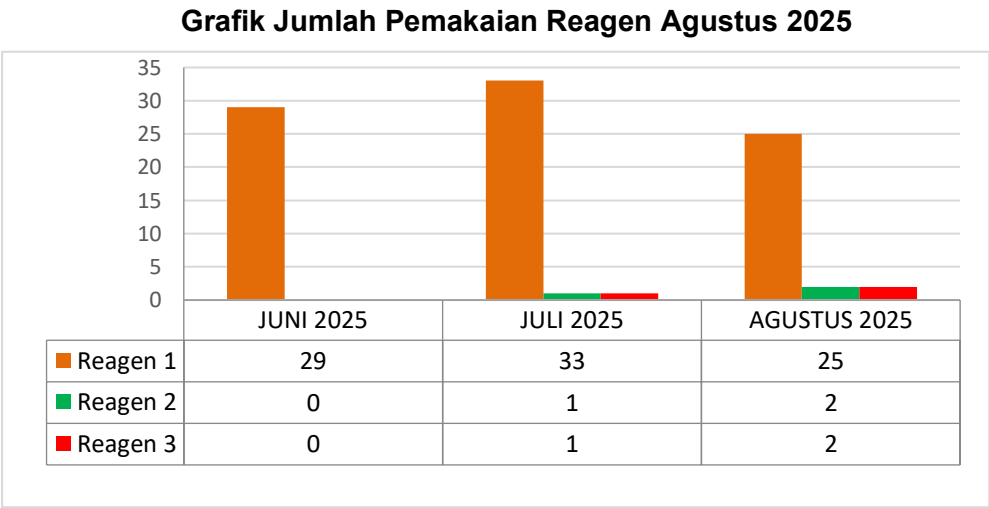


Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan juni 2025 tidak ada pasien dengan status HIV reaktif. pada bulan juli 2025 sebanyak 1 pasien dari poli rawat jalan, Sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 2 pasien dari IGD.

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.58 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Reagen 1	29	33	25
2	Reagen 2	0	1	2
3	Reagen 3	0	1	2



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Juni 2025 hanya memakai reagen 1 sebanyak 29 pasien. pada bulan Juli 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien Sedangkan pada bulan Agustus memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

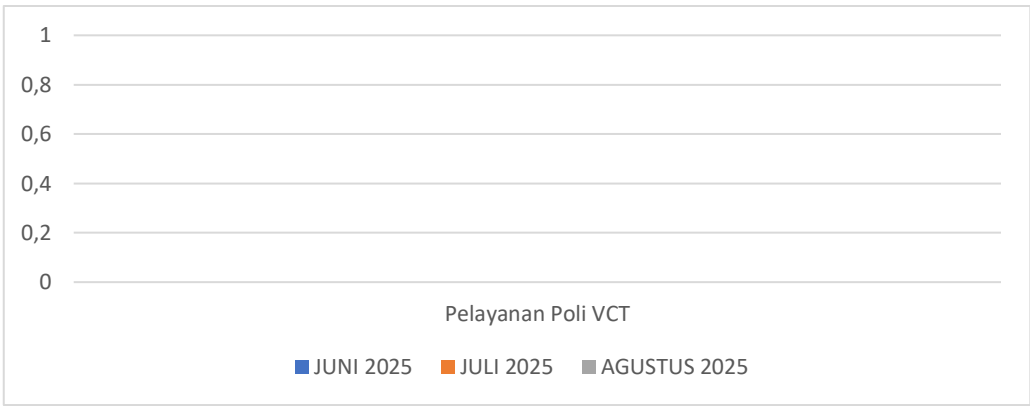
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.59 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Agustus 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

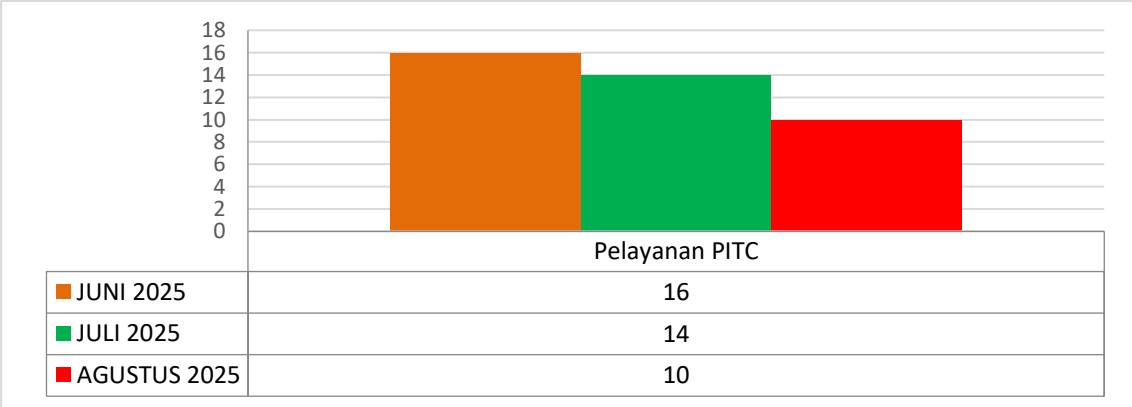
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.60 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Pelayanan PITC	16	14	10

Grafik Pelayanan PITC Agustus 2025



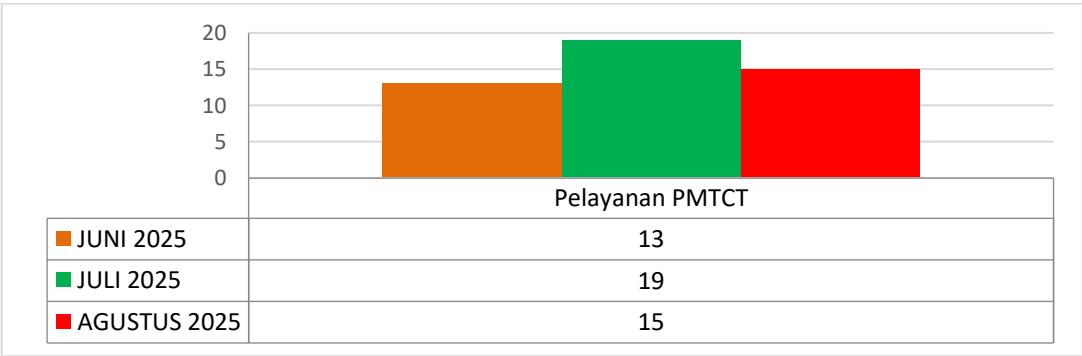
Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan Juni 2025 sebanyak 16 pasien. Pada bulan Juli 2025 sebanyak 14 pasien. Sedangkan pada bulan Agustus 2025 sebanyak 10 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.61 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Pelayanan PMTCT	13	19	15

Grafik Pelayanan PMTCT Agustus 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan pada bulan Juni 2025 sebanyak 13 pasien. pada bulan juli 2025 sebanyak 19 pasien. Sedangkan pada bulan agustus 2025 sebanyak 15 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

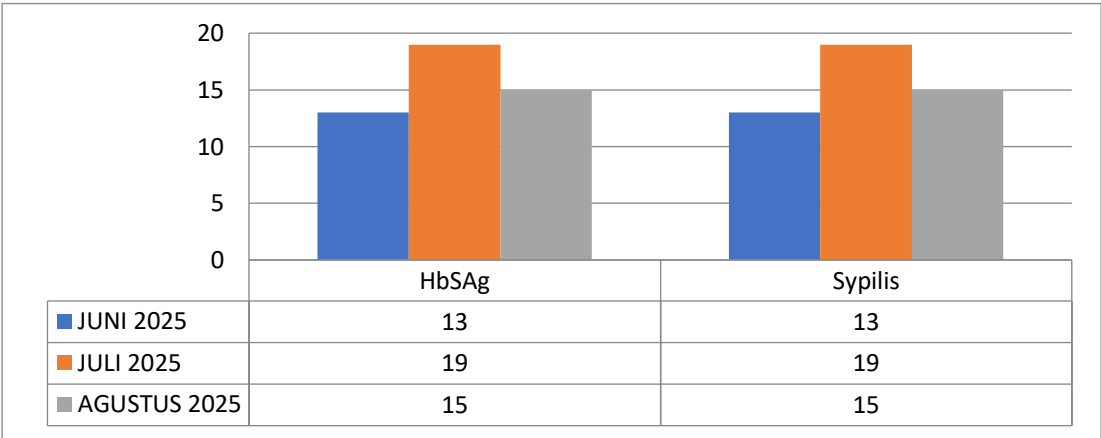
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.62 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	HbSAg	13	19	15
2	Sypilis	13	19	15

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Agustus 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan pada bulan Juni 2025 sebanyak 13 pasien, pada bulan Juli sebanyak 19 pasien desangkan pada bulan agustus sebanyak 15 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

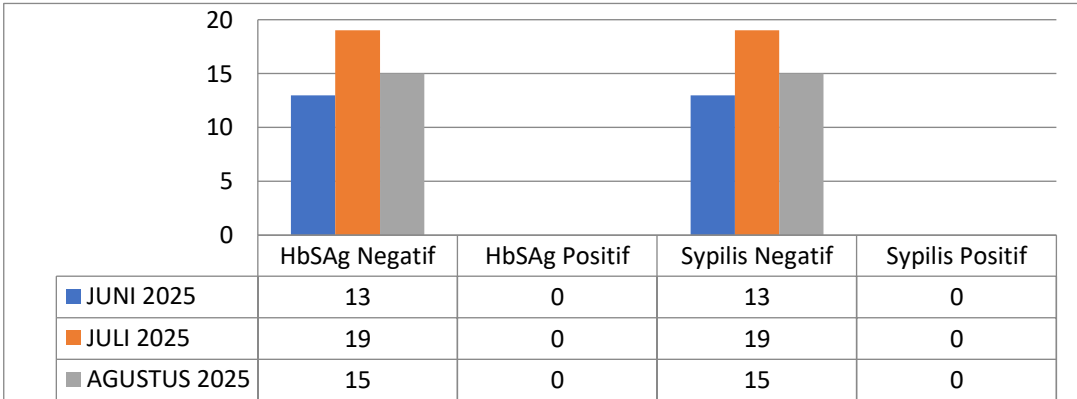
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.63 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	HbSAg			
	Negatif	13	19	15
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	13	19	15
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Agustus 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

Rencana Tindak Lanjut :

- Pada pasien HbSAg

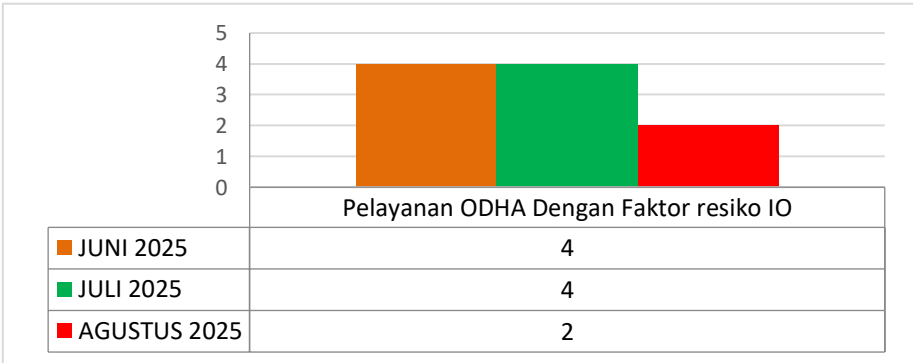
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Sypilis

Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.64 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	4	2

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Agustus 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. pada bulan Juni 2025 sebanyak 4 pasien. pada bulan Juli sebanyak 4 pasien. Sedangkan pada bulan agustus sebanyak 2 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

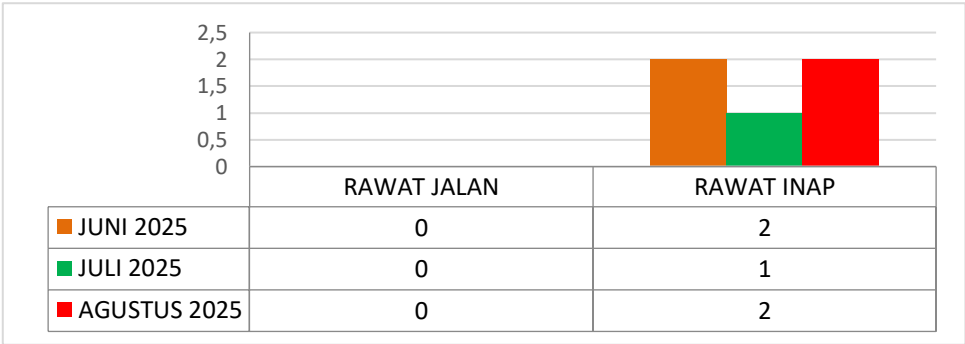
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.65 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	2	1	2

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Agustus 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan juni 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap pada bulan Juli 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk. Sedangkan pada bulan Agustus 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap.
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Agustus 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan

	eksklusif	2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung	1	1	1

	asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat		baru lantai 5			
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberia	Memastik	Pasien anak	IRJA	1	1	1

n Imunisasi	an ketersedia an imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	dan Bayi baru lahir	anak			
Pemberia n vitamin A	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberia n Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberik an PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersdiaa n bahan pangan di lingkunga n	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberia n Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberia n Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

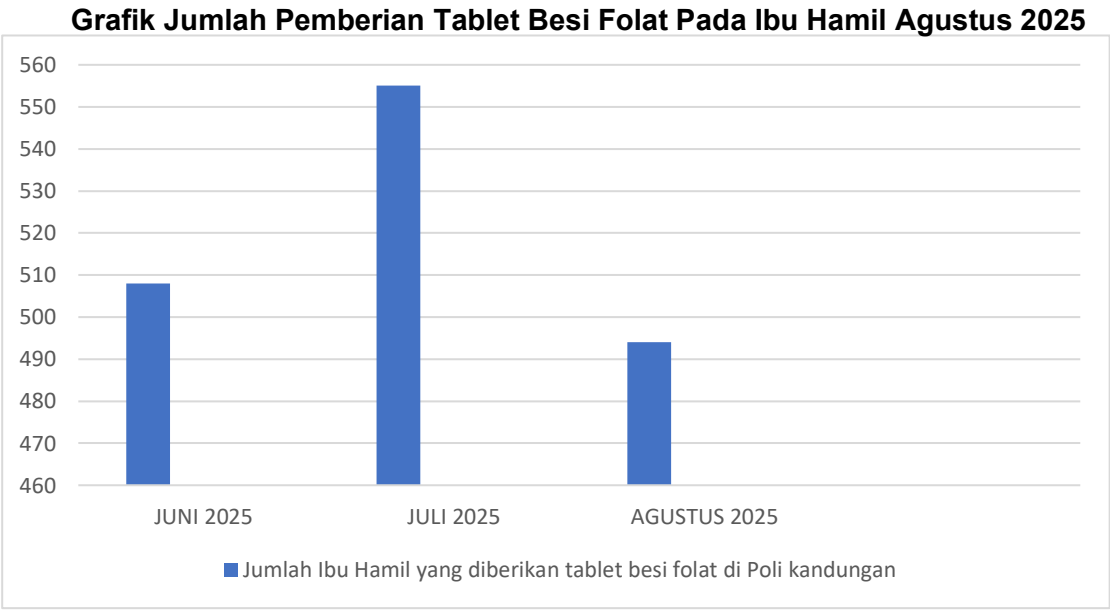
	mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil					
--	---	--	--	--	--	--

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	508	555	494



Analisis :
 Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 555 di bulan Juli menjadi 494 pada bulan Agustus yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

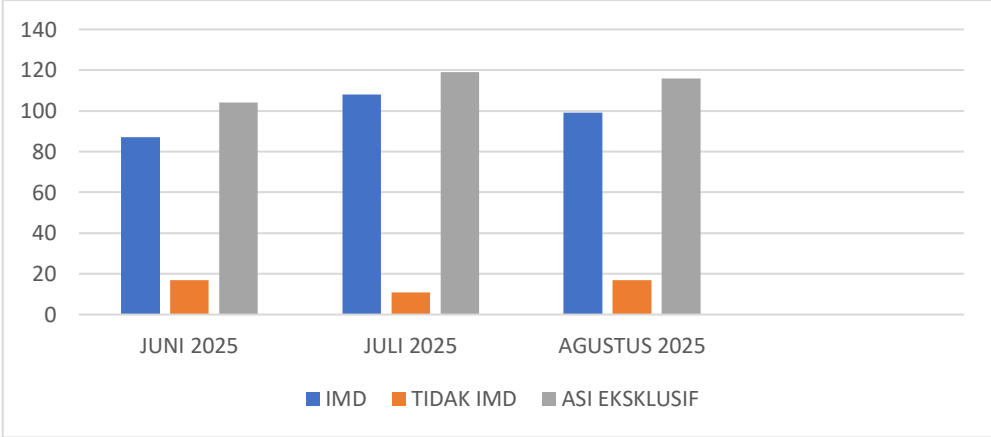
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
- 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	IMD	87	108	99
2	Tidak IMD	17	11	17
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	104	119	116

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif Agustus 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Agustus sebanyak 99 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Agustus 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan Agustus 2025 yaitu sebanyak 116 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

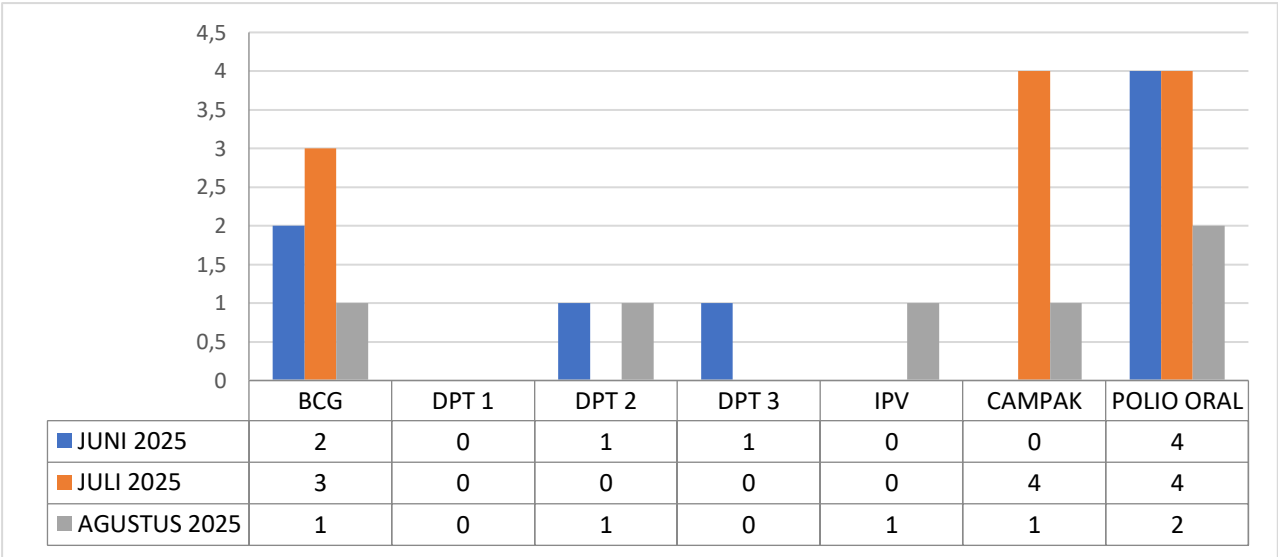
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JUNI 2025	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025
1	BCG	2	3	1
2	DPT 1	0	0	0
3	DPT 2	1	0	1
4	DPT 3	1	0	0
5	DPT 4	0	0	0
5	IPV	0	0	1
6	Campak	0	4	1
7	Polio Oral	4	4	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Agustus 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi BCG, DPT 2, IPV, dan campak di bulan Agustus 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 1, DPT 3 pada bulan Agustus 2025.
- 3. Pada periode Agustus 2025 terdapat 2 bayi yang melakukan Imunisasi Polio.

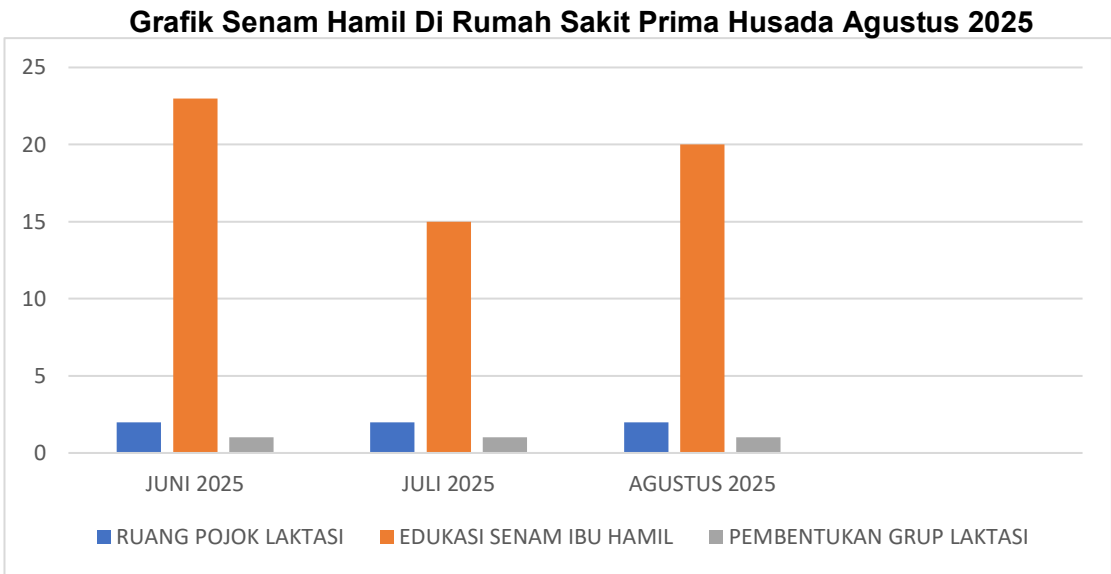
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	23	15	20
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



- Analisis :**
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
 - 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
 - 3. Pada bulan Agustus edukasi pada senam ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Grafik Tumbuh Kembang Balita pada Ibu Hamil sebanyak 13 peserta. Dan dilakukan penyuluhan pasien rawat jalan di poli obgyn sebanyak 7 peserta.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
 - 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Agustus 2025



Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
Jumlah Pasien Stunting	1	0	1
Jumlah Pasien Wasting	1	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Pada bulan Agustus 2025 ditemukan 1 pasien stunting dan wasting. Hal tersebut berkaitan

dengan kebiasaan makan yang kurang adekuat pada pasien. Ibu pasien mengatakan anak suka makan, dan aktif. Di mana kebutuhan energi anak tidak adekuat, makanan yang dimakan tidak dapat memenuhi kebutuhan energi yang keluar. Selain itu, aktivitas fisik anak sangat aktif diharapkan makanan harus lebih beragam dan tinggi kalori dan protein. Berdasarkan berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan pasien termasuk kategori *stunting* dan *wasting*. BB pasien saat masu rumah sakit di BB 11.35 kg dan saat keluar rumah sakit berat badan pasien 11,6 kg. Terdapat kenaikan pada BB selama di RS sebesar 3 gram

Rencana Tindak Lanjut :

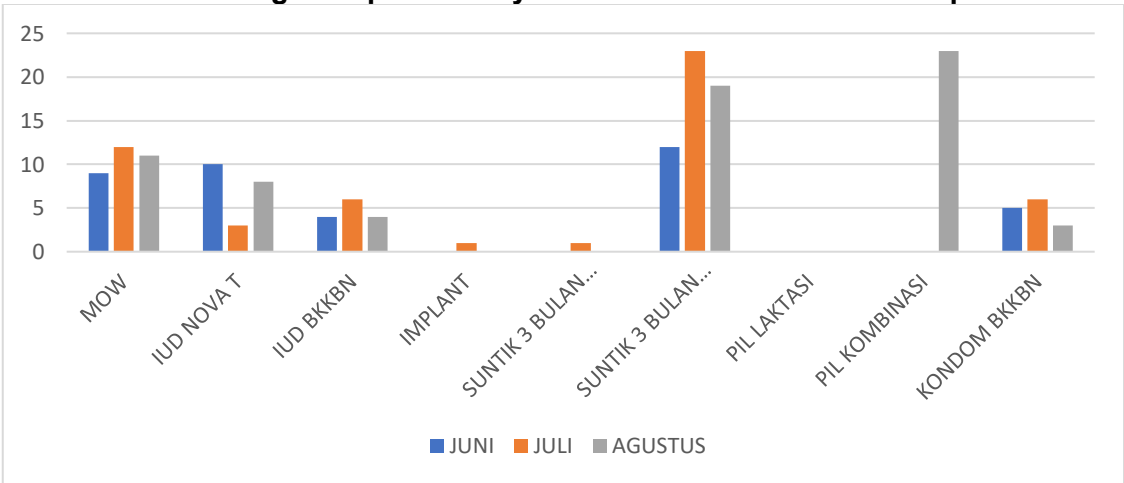
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan

3.1.2.5 KBRS

3.7.66 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	MOW	9	12	11
2	IUD Nova T	10	3	8
3	IUD BKKBN	4	6	4
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	0	0
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	12	23	19
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	0	0	23
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	5	6	3

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Juni naik (9) Juli naik (12) Agustus (11)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Juni (10) Juli turun (3) Agustus naik (8)
- 3. Peserta IUD BKKBN Juni turun(4) Juli naik (6) Agustus (4)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Juni (0) Juli (1) Agustus dioperkan ke faskes lain sebanyak 80 vial

- 5. Peserta KB suntik progestin Juni (12)Juli naik (23) Agustus dipakai sebanyak (9) dioperkan ke faskes lain sebanyak (10) vial
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Juni (0) Juli (0) Agustus (23)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan Juni (5) Juli (6) Agustus (3)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

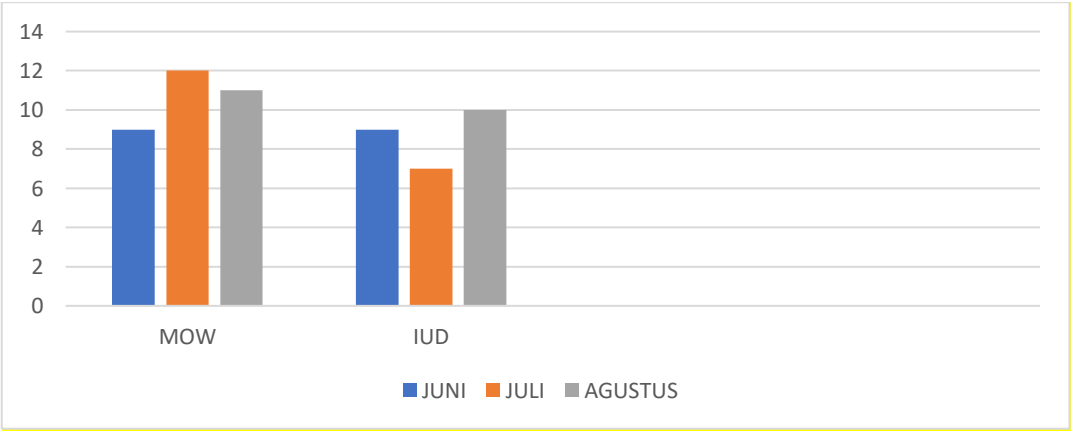
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

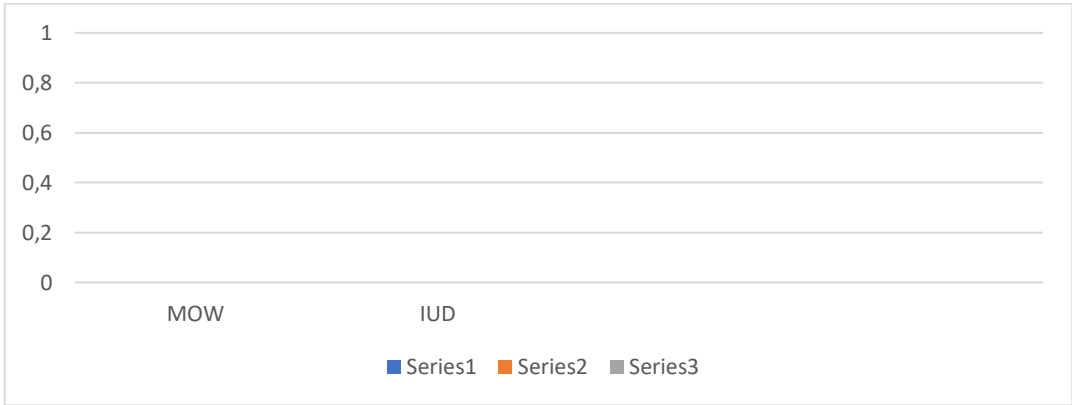
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	MOW	9	12	11
2	IUD	9	7	10

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		JUNI 2025	JULI 2025	AGUSTUS 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Juni-Juli-Agustus meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Juni-Juli-Agustus menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1.	Dewi Agung	P/46	dr. Zaki, Sp.B	155781	Gangrenen	03/06/2025	04/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
2.	HJ. Praptini	P/69	dr. Ira, Sp.JP	223270	ALO	04/06/2025	07/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	0,5	0,5	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
3.	Syafa Nabila	P/16	dr. Anton, Sp. B	232241	Abdominal pain	06/06/2025	09/06/2025	4	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
4.	Tasmi	P/85	dr. Zaki, Sp.B	232263	Hemoroid	07/06/2025	08/06/2025	2	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
5.	Sa'i	L/65	dr. Andi A, Sp. B	232330	Carcinoma thyroid	08/06/2025	11/06/2025	4	Cefoperazone	1	2x1	6	4	1,5
6.	Tri Agustinayanti	P/34	dr. Ardhi, Sp.Pd	232331	TF	08/06/2025	11/06/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
7.	Asniwati	P/61	dr. Ardhandy, Sp.Pd	232373	Cholelithiasis	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8.	Mutmainah	P/82	dr. Ira, Sp.JP	232361	Ventricular premature	09/06/2025	11/06/2025	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
9.	Misri	L/41	dr. Yoga, Sp.JP	206726	NSTEMI	09/06/2025	12/06/2025	4	Levofloxacin inf	2	1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
10.	Nike Chusnul	P/30	dr. Humaira, Sp.OG	214788	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11.	Nasrul Ilham M	L/25	dr. Pradana, Sp. U	175034	Hydronephrosis	10/06/2025	12/06/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
12.	Erista Yustiana	P/28	dr. Humaira, Sp.OG	224330	SC Eracs	10/06/2025	12/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
13.	Ngatoko	L/68	dr. Elvi, Sp. P	232410	Pulmonary Hypertension	10/06/2025	15/06/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Meropenem		2x1	7	3	2,3
14.	Solicha	P/28	dr. Farid, Sp.N	135511	Stroke	13/06/2025	17/06/2025	5	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	8	2	4
15.	Clarisa Venta	P/25	dr. Zaki, Sp.B	199240	Neoplasm of breast	17/06/2025	19/06/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,57
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
16.	Sri Ari Bawaning	P/62	dr. Elvi, Sp.P	217237	Asthma	20/06/2025	24/06/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin		1x0,5	1,5	0,3	5
17.	Harwati H	P/70	dr. Mira, Sp. JP	180211	Syok condition	21/06/2025	26/06/2025	6	Cefoperazone	1	3x1	14	4	3,5
18.	Isnaniyah	P/60	dr. Zaki, Sp.B	211220	Gangren Necrotic	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
19.	Endang Tri	P/54	dr. Zaki, Sp.B	227974	Diabetic foot	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefoperazone	3	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
20.	Latifatul Z	P/23	dr. Aida, Sp.OG	232991	Premature	22/06/2025	24/06/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Ardiansyah	L/30	dr. Arianto, Sp.OT	233336	Open wound of other of hand	30/06/2025	02/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
2	Reva Aldo	L/29	dr. Anton, Sp.B	233308	Gangren Anogenital	30/06/2025	02/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

3	Ni Luh Elinda	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	162043	SC	04/07/2025	06/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Mukiyat	L/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	016856	TF + ISK	08/07/2025	12/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8	2,5
5	Umul Habibah	L/51	dr. Andy, Sp.P	233948	Asthma	11/07/2025	14/07/2025	4	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
6	Nadila Munip	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	232809	Oligohydramnios	14/07/2025	16/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Alipah	P/62	dr. Ardhanay, Sp. Pd	105460	DM	15/07/2025	19/07/2025	5	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
8	Ngateni	P/63	dr. Ardhi, Sp.Pd	110454	Hiperglikemi + ISK	15/07/2025	19/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
9	Dullah	L/49	dr. Aji, Sp.Pd	234155	DF	16/07/2025	18/07/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
10	Kalsum	P/72	dr. Anton, Sp.B	198907	Necrotizing facitis	21/07/2025	23/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Musilan	L/54	dr. Fahima, SP.N	234508	CVA ICH	23/07/2025	25/07/2025	3	Cefoperazone	1	2x1	3	4	0,75
12	Marsan	L/75	dr. Ira, Sp.JP	140599	NSTEMI	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2.5
13	Artinilis	L/48	dr. Ira, Sp.JP	203877	ALO	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
14	Parman	L/74	dr. Catur, Sp.P	234586	Acute Respiratory Acute	24/07/2025	27/07/2025	4	Meropenem	2	3x1	9	3	3
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Samsul Arifin	L/55	dr. Anton, Sp.B	221994	Gangren necrotic diabeticum	25/07/2025	27/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5

16	Sunardi	L/71	dr. Edi, Sp. U	198133	BPH	26/07/2025	28/07/2025	3	Cetfizoxime	1	1x2	2	4	0,5
17	You wan	L/20	dr. Sigit, Sp.BP	234721	Multiple vulnus	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
								Ceftriaxone	2x1		4	2	2	
18	M Misbahul M	L/17	dr. Zaki, Sp.B	175470	Lymphadenopati	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
								Ceftriaxone	2x1		4	2	2	
19	Nengah Ratna T	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	229454	KPD	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
								Cefadroxile	2x0,5		2	2	1	
20	Rizky Eka	L/19	dr. Oka, Sp.OT	233174	Union Phalenx	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
								Ceftriaxone	2x1		4	2	2	

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Agustus 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Yanti Ningsih	P/26	dr. Aida, Sp.OG	162043	Pre Eklamsia	30/07/2025	01/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Eny Zuhriah	P/63	dr. Anton, Sp.B	160878	Necrotizing facitis	01/08/2025	03/08/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
3	Kusairi	L/58	dr. Ardhan, Sp.Pd	235268	DM Hiperglikemi	06/08/2025	08/08/2025	3	Levofloxacin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
4	Ra'im	L/73	dr. Catur, Sp. P	125436	COPD	06/08/2025	09/08/2025	4	Meropenem	1	3x1	6	3	2
5	Dasuki	L/65	dr. Andy, Sp.P	186331	COPD	07/08/2025	11/08/2025	5	Azitromycin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
6	Hilda Dwi Vanka	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	171684	Oligohydramnios	08/08/2025	10/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Faradilla S	P/25	dr. Andy, Sp.P	235471	Pneumoni	10/08/2025	13/08/2025	4	Azitromycin	2	1x0.5	0.5	0.3	1.67
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Patrum	L/71	dr. Pradana, Sp. U	234831	BPH	12/08/2025	14/08/2025	3	Ceftizxime	1	1x2	2	4	0.5

9	Lailatur R	P/51	dr. Andi, Sp.B	235567	Hemorrhoids with complication	12/08/2025	15/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Chofifa	P/53	dr. Fachriy, Sp.BS	235247	Necrotizing facitis	13/08/2025	15/08/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
11	Anang Fakhmi	L/35	Dr. Ardhi, Sp. Pd	235486	TF	13/08/2025	16/08/2025	4	Levofloxacin	1	1x1	2.25	0.3	7.5
12	Aan Trinova	L/35	dr. Zaki, Sp.B	166558	Peritonitis akut	21/08/2025	24/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
13	Soewarsih	P/76	dr. Heri, Sp.Pd	074832	TF + ISK	22/08/2025	25/07/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
14	lin Budi	P/58	dr. Ardhi, Sp.Pd	001240	DM Hiperglikemi + ISK	22/08/2025	26/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,8	0,8	3.5
15	Sulistiani	P/57	dr. Arianto, Sp.OT	172936	CF Distal	23/08/2025	25/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
16	Ririn Wijayanti	P/48	dr. Yoga, Sp.JP	066465	Dyspnea	23/08/2025	26/08/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Ester Ningmawati	P/59	dr. Anton, Sp.B	194608	Necrotizing facitis	25/08/2025	26/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
18	Ony Devita	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	118438	SC	26/08/2025	28/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tohit	L/55	dr. Aji, Sp.Pd	236147	TF + Shock Condition	26/08/2025	29/08/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Cefotaxime		3x1	6	4	2
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0.8	3
20	Rahit German	L/19	dr. Catur E, Sp. P	236262	Cronic fever, Efusi pleura	28/08/2025	31/08/2025	4	Ceftriaxnoe	1	2x1	6	2	3

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

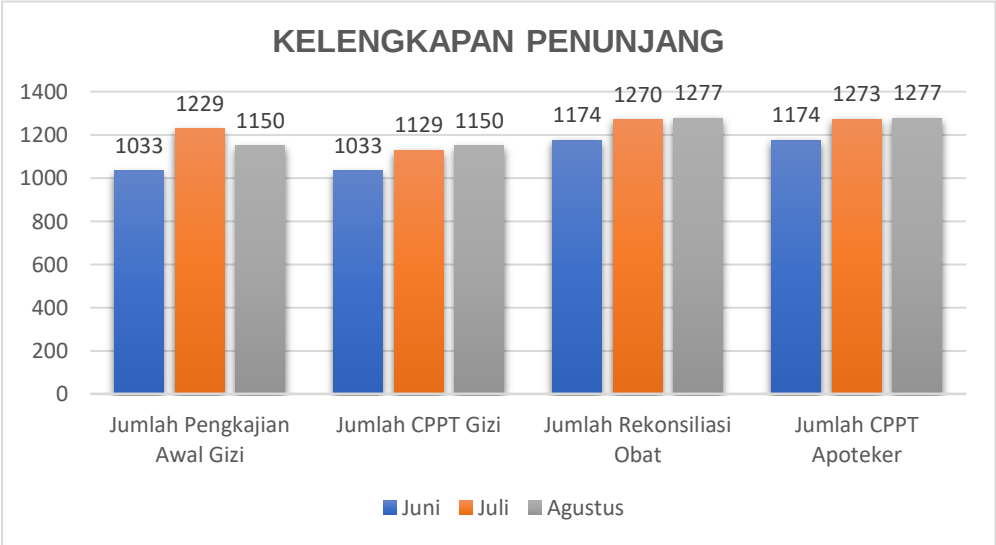
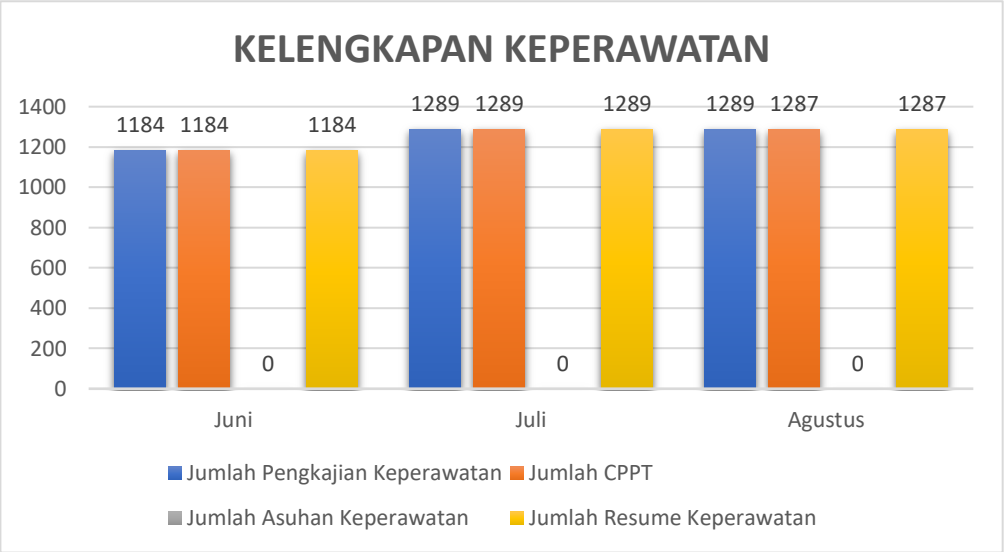
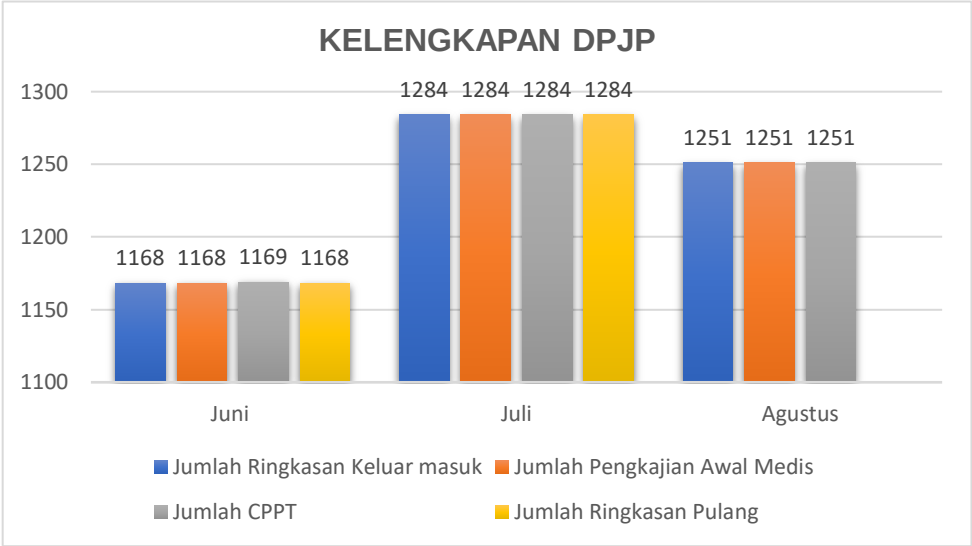
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Agustus Tahun 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99.89	3	0,10	1281	99.89	3	0,11	1281	99.89	3	0,11	1281	99.89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99.65	5	0.35	1269	96.67	1	3.33	1272	96.67	1	3.33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0

3.1.1.7 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Agustus 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi terisi lengkap 100% , sebanyak 1150 dokumen
- 2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan Agustus 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan Agustus 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.67 Permasalah Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	DPJP komplain karena penulisan catatan operasi tidak tersimpan di ERM, dan harus menunggu perawat IKO mengisi tanggal dan jam pelaksanaan operasi	P	1. Observasi penulisan laporan operasi di IKO 2. Penulisan saling keterkaitan dengan perawat, sehingga jika pengisian tidak diisi perawat, DPJP tidak dapat mengisi 3. Catatan operasi tidak tersimpan otomatis jika belum di klik simpan
		D	Koordinasi dengan programmer untuk memisahkan dan membedakan kolom yang diinput dokter dan perawat agar bisa diinput tanpa harus menunggu
		S	Laporan operasi sudah bisa diakses dan tidak ada kendala selama pengisian, hanya ada satu pasien tidak muncul di review cetakan laporan operasi karena ada masalah di programmer untuk pengubahan cara bayar
		A	Lakukan evaluasi dan koordinasi ulang dengan programmer apabila ada trouble dan kendala baik pengisian maupun preview cetak nya.
2	Alat phaco error, handpiece mengalami kendala saat durante operasi pasien mata yang terakhir	P	1. Identifikasi penyebab alat mata phaco tidak berfungsi 2. Koordinasi dengan IPSRS (atem) untuk memperbaiki saat durante op 3. Koordinasi untuk peminjaman cito alat ke PHS 4. Alat sudah bisa digunakan sebelum alat handpiece dari PHS datang
		D	1.Buat berita acara kerusakan alat, apakah dari handpiece atau dari alat phaco 2. Hubungi vendor untuk melaporkan kerusakan alat 3. Lapor PT untuk pengecekan dari pak parno saat durante op

			4. Sementara alat masih dalam pengecekan, PHM melakukan peminjaman handpiece phaco ke PHS
		S	Saat pengecekan alat handpiece PHM tidak maksimal, sehingga harus pembelian baru
		A	Lakukan follow up berkala sampai barang datang

3.7.68 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Plotting perawat IGD beserta pembagian PJ nya	P	Dalam satu shift harus ada plotting sebagai berikut : 1. Pj menerima pasien (triase) + follow up lab + P3 : 1 2. Pj tindakan (grading merah) : 1 3. Pj administrasi (depan computer) : 1 4. Pj transfer + folow up GC + pj penulisan semua hardcopy : 1 5. Mengerjakan PR erm + DRM utk proses klaim. : 1 6. Jika job utama sudah terhandel, harus membantu yang lain Siapkan plan B (plotting insidentil) jika terjadi keadaan crowded dan pasien gawat datang bersamaan
		D	Dari hasil implementasi, ditemukan beberapa perawat yang kurang paham terkait dengan plottingnya, sehingga ada beberapa pasien yang tidak terhandel dengan baik
		S	Plotting tidak dapat dilaksanakan dengan sistematis pada keadaan crowded, pasien gawat datang secara bersamaan sehingga Karu atau PJ Shift harus koordinasi untuk membantu tindakan
		A	Monitoring dan evaluasi pembagian plotting dan siapkan plan B jika
2	PR ERM pengkajian awal IGD	P	Mengidentifikasi PR ERM dari verifikator terkait kesesuaian SPRI maupun pengkajian awal
		D	Ingatkan dan sosialisasikan kembali bagian yangs sering di PR kan oleh verifikator diantaranya GCS, Operasi/tidak operasi, nama keluarga yang diberikan edukasi
		S	Pembetulan PR ERM wajib diselesaikan dalam waktu 1x24 jam
		A	Monitoring dan evaluasi kerjasama dengan kains RM untuk mengecek PR ERM saat itu juga, agar bisa dilengkapi dengan segera.
3	Penerimaan rujukan dari luar	P	Respon cepat semua rujukan yang masuk dari IGD by WA
		D	Pengisian link dan mempermudah akses masuk ke IGD
		S	Berikan prioritas penuh untuk diterima (fast track)

			di IGD terutama Klinik FKTP/perusahaan, PSC, Resita
		A	Monitoring penertiban dalam penulisan rujukan yang masuk, jika rujukan ditolak, alasannya harus jelas dikarenakan fasilitas berupa DPJP, sarana dan prasana RSPHM tidak ada.
4	Pengukuran TB dan BB realtime untuk pasien IGD di triase	P	Pengukuran BB dan TB harus realtime dilakukan saat pasien datang, kecuali pada kondisi pasien tidak sadar, kesakitan hebat atau kondisi kegawatan lainnya
		D	Menempatkan BB dan TB di triase yang sebelumnya di depan PONEK, tujuannya agar memudahkan pasien datang langsung bisa di ukur TB dan BB
		S	Pengukuran BB dan TB harus sesuai untuk menentukan dosis obat dan terapi lanjutan
		A	Koordinasi dengan gizi dengan menjalankan skrining gizi yang sesuai sehingga jika ditemukan ada resiko malnutrisi , dapat di TL oleh ahli gizi nya.
5	Waktu tunggu IGD lebih dari 6 jam sehingga menyebabkan penumpukan pasien dan pasien baru tidak masuk	P	Identifikasi penyebab waktu tunggu IGD yang lama
		D	- PJ atau Karu harus mengatur sirkulasi perpindahan pasien di IGD - Plotting perawat belum dibentuk sehingga masing-masing perawat masih belum jelas harus memegang pasien apa saja - Koordinasi dengan dokter IGD dan PIPP, untuk memindah pasien yang stabil ke ruangan
		S	Operan antar shift harus jelas dan terdokumentasi
		A	Pendampingan operan pasien dan penunjukan plotting yang sesuai harus dipatuhi setiap shift

3.7.69 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Masih ada complain pasien rawat inap melalui kuesioner atau WA MOD karena complain tersebut yang tidak terkaji oleh Karu rawat inap saat pasien di ruangan	P	Karu harus keliling ke pasien di tiap ruangan unitnya untuk menanyakan kendala pelayanan selama rawat inap
		D	1. Review ulang terkait alur handling complain 2. Tangani segera jika kendala bisa diselesaikan Tingkat karu, contoh AC tidak dingin, ruangan kotor, remote rusak, lampu mati dll 3. Apabila ada kendala administrasi dan penjamin, bisa koordinasi dengan MOD
		S	Monitoring dan supervisi apakah kegiatan sudah dilakukan secara kontinu di unit
		A	Kolaborasi dengan MOD untuk meminta feedback kepuasan pasien dari unit rawat inap untuk

			perbaiki pelayanan rawat inap
2.	Pengaktifan bed transit karena lonjakan pasien rawat inap	P	Pengaktifan bed transit di lantai 2 saat awal agustus 2025 dengan kapasitas 6 bed, dan penambahan 5 bed di lantai 6,7,8
		D	Penempatan bed di lantai 6,7,8 hanya sementara saja dengan kapasitas satu kamar ada 4, saat terjadi lonjakan pasien, kapasitas menjadi 5 bed
		S	Mengembalikan bed transit karena jumlah kapasitas pasien sudah stabil dan memaksimalkan di ruangan yang existing sekarang
		A	Koordinasi dengan MOD dan Karu rawa inap apabila terjadi lonjakan pasien kembali, sehingga sudah siap saat akan eksekusi
3.	Pasien rawat inap terganggu karena banyak pengunjung datang melebihi jam besuk terutama malam hari	P	Koordinasi dengan security untuk mendisiplinkan pengunjung
		D	Koordinasi untuk meminimalisir banyak pintu masuk yang ke rawat inap dengan memasang pintu di samping IKO
		S	Kunci pintu di samping IKO saat jam kunjung ditutup
		A	Security tetap monitoring dan supervisi keliling, dan koordinasi dengan PJ/ karu rawat inap apabila masih ada pengunjung yang belum keluar saat jam besuk sudah berakhir.

3.7.70 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kebijakan BPJS terkait dengan Mekanisme Perubahan Data Tenaga Medis di Aplikasi HFIS	P	Identifikasi jadwal dokter spesialis yang akan diajukan perubahan karena jadwal tidak boleh ada perubahan sampai akhir tahun
		D	1. Fokuskan pada DPJP yang praktek lebih dari kuota HFIS 2. Tawarkan penyesuaian hafiz dengan menambah kuota pelayanan , 1 jam = 10 pasien
		S	Sosialisasikan terkait kuota harian di flyer jadwal dokter dan di share kan melalui sosmed maupun di saluran wa channel
		A	Koordinasi dengan CSO untuk melakukan BC pada pasien yang sdah melebihi kuota untuk di reschedule ke jadwal dokter berikutnya
2	Kehabisan tissu di Poli Gigi, Poli obgyn dan Poli Bedah	P	1. Identifikasi penyebab kekosongan obat terutama penggunaan tissue yang dipakai oleh pasien. Untuk poli gigi untuk membersihkan setelah kumur, poli obgyn untuk membersihkan gel di perut pasien, sedangkan poli bedah untuk cuci tangan karena rata-rata banyak pasien dengan tindakan seperti rawat luka post op dan lain-lain. 2. Penggunaan tissue halus yang baru lebih cepat habis, karena jika terkena gel atau air, lebih cepat hancur dan tidak kesat, sehingga

			membutuhkan 3 tisu atau lebih untuk sekali pakai.
		D	Koordinasi dengan Gudang dan koordinator CS poli untuk cari di unit lain substitusi tissue yang memang masih ada stoknya
		S	Supervisi untuk segera order jika mendekati stok minimal
		A	Monitoring dan supervisi ke unit jangan sampai kehabisan dan identifikasi stok minimal unit harus berjalan
3	Trial pendaftaran pasien H-15 menit sebelum jadwal praktek	P	Identifikasi poli yang akan di trial untuk H-15 menit pasien didaftar sebelum jadwal praktek dokter
		D	Poli yang di trial adalah poli mata, poli saraf, poli IPD dr Heri dan poli paru
		S	Pertimbangan poli yang di trial adalah poli dengan waktu layanan tunggu pasien tertinggi bulan juli 2025.
		A	Hasil rekap bulanan waktu tunggu poli bulan agustus 2025 menurun kurang dari 1 jam. Trial akan diberlakukan ke poli yang lain koordinasi dengan plotting jaga pendaftaran
4	Kuota Phaco mata	P	Identifikasi kuota pasien operasi phaco dalam satu tahun
		D	Review dan evaluasi kuota phaco per dokter tiap 3 bulan sekali
		S	dr. diah, SpM selama 2x triwulan, tidak memenuhi kota phaco karena pasiennya sedikit, tindaklanjut untuk pengurangan kuota phaco dan mengalihkan ke DPJP mata yang lain agar target tahunan tercapai
		A	Review dan evaluasi kembali di awal bulan oktober untuk target kuota per dokter

3.7.71 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab

			rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
2	Pengambilan obat tertinggal sudah tidak ada batas waktu karena pelayanan farmasi 1x24 jam	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas agar tidak menolak pasien yang mengambil obat tertinggal
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi
		S	Evaluasi informasi waktu pengambilan obat di farmasi : Senin – jumat pukul 06.30 - 21.00 Sabtu – minggu pukul 06.30 – 14.00
		A	Farmasi melayani 24 jam jika ada pasien yang mengambil obat tertinggal
3	Alur Resep NOVA T dengan Penjamin BPJS Kesehatan	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas farmasi dan bidan IGD/ Maternitas perbaikan pelayanan resep NOVA T dengan penjamin BPJS Kesehatan
		D	Sosialisasi alur pemahaman petugas farmasi dan bidan IGD/ Maternitas
		S	Ditemukan pelayanan resep NOVA T dengan penjamin BPJS Kesehatan tidak ada inputan resep karena diinputkan non pasien. NOVA T tidak di cover BPJS Kesehatan. Sehingga tidak ada record resep yang muncul di billing bidan dan tidak tahu apakah pasien sudah pemasangan IUD atau belum khusus pasien-pasien yang transfer dari IGD ke IKO.
		A	1. Perawat/ Bidan meresepkan Nova T (pasien tagihan BPJS Kesehatan) 2. Petugas farmasi ubah cara pembayaran menjadi umum 3. Simpan resep 4. Pasien di arahkan ke kasir untuk pembayaran 5. NOVA T diberikan setelah ada nota yang di stempel lunas dan kwitansi pembayaran
4	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Juni 2025 = +3.539.452 Juli 2025 = +1.370.844 Agustus 2025 = +1.412.881 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT.	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
5	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO)	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO

	yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 47.72% dan waktu tunggu obat racikan 19.97%		digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Follow up ke Programmer. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 128 KPO.
6	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan Juli mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Farmasi sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
7	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
8	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan VVM (Vaksin Vial Monitor) untuk vaksin pemerintah warna segiempat lebih gelap dari warna lingkaran sehingga tidak layak digunakan. (Data vaksin pada Tabel 9.10)	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli. 3. Koordinasi dengan PJ Vaksin Pemerintah untuk permintaan vaksin baru ke Puskesmas.
9	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat	P	Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol.

	kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). Juni 2025 = 38 resep Juli 2025 = 40 resep Agustus 2025 = 19 resep		2. Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Konfirmasi ke grup whatsapp Surat Kontrol jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format : Form Order Perubahan Tanggal Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa c. Pendaftaran mengubah di V-Claim d. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. e. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
10	Obat Rawat Inap di tandon di Nurse Station	P	Pengecekan obat tandonan di nurse station setelah dilakukan serah terima obat ODD
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi terkait pengecekan obat tandonan di nurse station
		S	Memaksimalkan jobdesc distribusi Tenaga Vokasi Farmasi ODD dan apoteker untuk mengecek obat yang ada di nurse station
		A	Pada saat distribusi Tenaga Vokasi Farmasi wajib mengecek obat-obat yang ada di nurse station. Jika ada tandonan obat, Tenaga Vokasi Farmasi wajib menanyakan ke perawat jam pemberian obatnya. Jika sudah terlewat jam pemberiannya maka Tenaga Vokasi Farmasi wajib cek DPO obat yang ada di nurse station jika sudah lewat waktu pemberian harus di retur saat itu juga, serah terima obat dengan perawat dan perawat juga langsung input retur di billing. Apoteker rawat inap saat visite pasien juga wajib dobel cek obat yang ada di nurse station. Jika obat signa PRN / kp berkoordinasi dengan apoteker, apakah pasien masih membutuhkan terapi tersebut.
11	Pertanyaan sewaktu visite terlalu monoton dan template	P	Koordinasi dengan apoteker terkait pelayanan visite apoteker
		D	Sosialisasi ke apoteker
		S	PT. DPM menemukan cara visite apoteker terlalu monoton dan template sehingga pengecekan apakah pasien sudah

			minum obat atau belum di jalankan. Pertanyaan keluhan bisa diganti dengan pertanyaan “Bagaimana kabar bapak/ ibu hari ini? Apakah sudah membaik?”. Pertanyaan riwayat penyakit, riwayat obat, dan riwayat alergi apoteker bisa mengkaji di Asessment awal IGD sehingga tidak perlu ditanyakan kembali ke pasien dan melanjutkan pengkajian terkait obat yang dibawa dari rumah
		A	Saat visite pertanyaan tidak template dan monoton, lebih ceria, lebih humble. Langkah-langkahnya : Sebelum visite apoteker mengkaji riwayat penyakit, riwayat obat, dan riwayat alergi di asessment awal IGD. “Selamat pagi bapak / ibu, perkenalkan diri” Identifikasi pasien “Bagaimana kabar bapak/ ibu hari ini? Apakah sudah membaik?” “Apakah obatnya sudah diminum hari ini pak/ bu?” Jika belum maka apoteker meminumkan obat ke pasien. “Setelah minum obat apakah ada efek samping?” “Obat yang dikonsumsi di rumah apa saja?” Kemudian menjelaskan obat yang diterima saat rawat inap dan efek samping yang bisa terjadi/ jika ada interaksi obat.
12	Pelunasan resep non pasien	P	Koordinasi dengan keuangan PT. DPM, kasir dan farmasi
		D	Perbaiki alur pelayanan resep non pasien di SIMRS
		S	PT. DPM menemukan obat karyawan dan pembelian urinal/ pispot yang diinputkan non pasien belum dilunaskan di sistem sehingga banyak tagihan yang belum terbayarkan muncul di keuangan PT.
		A	Pembayaran obat non pasien wajib minta nota yang sudah terstempel LUNAS oleh kasir, setelah itu baru diberikan barangnya. Jika sudah terstempel lunas tetapi di billing belum dilunasi telfon kasir. Jika belum terselesaikan hingga akhir shift wajib ditulis dioperan unit farmasi. Jika pegawai RSPH yang membeli obat : tulis nama/unit

3.7.72 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terkait keterlambatan, tukar jadwal, dan human error	P	Mengajukan konseling yang bersangkutan ke SDM atau KABID
		D	Karu koordinasi dengan KABID dan SDM
		S	Memperhatikan dan mengatur jadwal staff untuk mengurangi tingkat kelelahan sehingga bisa menekan angka keterlambatan
		A	Melakukan konseling ke staff yg bersangkutan dan berkolaborasi dengan KABID dan SDM salah satunya memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis
2	Ketidaklengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA	P	Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar
		D	Karu koordinasi dengan KABID

		S	Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap
3	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer
		D	Karu koordinasi dengan programmer
		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke progammer
			2. Monitoring dan evaluasi SIMRS

3.7.73 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Indicator steril adhesive tape tidak berubah warna	P	Koordinasi dengan penyedia bhp indicator apakah ada perubahan jenis bahan
		D	Menghubungi penyedia indicator apakah bahan indicator adhesive tape berbeda,
		S	1. Dari beberapa instrument dan kasa yang di temple pada kertas pouches tidak mengalami perubahan warna 2. Awal warna sebelum di steril warna hijau, seharusnya bisa berubah ke warna hitam 3. Jika di pakai di autoklaf adhesive tape berubah jadi hitam 4. Jika di pakai dengan memert sulit berubah 5. Indicator ini memeng di peruntukan untuk mesin steam
		A	1. Menghubungi pihak penyedia indicator untuk mencari yang sesuai dengan mesin yang ada di CSSD 2. Jika dari pihak penyedia bhp belum memberi solusi maka pengajuan untuk penghentian, karena sudah ada indicator dalam di setiap instrumennya
2	Kepatuhan input permintaan pensterilan instrument	P	Ada beberapa unit yang tidak tertib untuk input set instrument yaitu poli gigi
		D	Koordinasi dengan asisiten poli gigi untuk patuh menginput, jika tetap tidak terinput maka koodinasi dengan karu irja
		S	Beberapa kali pensetoran instrument gigi pas

			di waktu jam operan antara pagi dan siang, karena asisten poli gigi sekalian pulang
		A	Meminta asisten poli gigi untuk segera menginput karena jika tidak di input tidak akan di lakukan pencucian

3.7.74 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Sarung bantal baru kebesaran	P	Membuat pengajuan permak barang ke PT
		D	Menarik Kembali sarung bantal di ruangan untuk bisa dikumpulkan dan di ajukan permak Mengganti dengan ukuran sarung bantal yang sesuai
		S	Pengecekan dan perbandingan sarung bantal baru dengan yang lama, berapa selisih ukurannya Minta untuk perbaikan permak dengan membawa contoh ukuran sarban yang sesuai
		A	1. Menghitung dan menarik Kembali sarban yang kebesaran total 50 pcs 2. Kolaborasi dengan pengadaan bahwa minta perbaikan permak dan di kasih contohnya
2	LPG tidak bisa menyala	P	Koordinasi dengan penyedia lpg bahwa lpg tidak bisa di gunakan di mesin pengering laundry
		D	Minta pertukaran LPG ke bagian penyedia
		S	1. LPG yang sudah terlalu lama tidak terpakai biasanya liquidnya beku, jadi susah untuk naik gas nya 2. Regulator LPG mesin pengering laundry menggunakan tekanan tinggi, jadi membutuhkan lpg yang sudah cair, karena mudah untuk mengangkat tekanan gas nya 3. STOK jangan sampai mepet atau menipis, buat jaga jaga lagi jika lpg beku
		A	1. Menghubungi penyedia LPG untuk minta tukar gas 2. Jika hal yang sama terulang maka laundry juga akan terus mengajukan pertukaran gas LPG

3.7.75 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Respon time radiologi tidak mencapai standar
		D	Telepon radiolog agar segera di expertise
		S	Mengumpulkan dan analisa data setiap bulan
		A	Evaluasi secara berkala.
2.	Billing tidak dapat input diagnosa	P	Surat permintaan radiologi untuk penulisan diagnose tidak muncul pada

			billing rad. Padahal sudah ditulis oleh perawat igd/irja, Radiolog komplain
		D	Melaporkan kepada Tim IT . dan untuk sementara diagnose ditulis pada kolom keluhan pasien, namun perawat tidak tertib
		S	Follow Up ke IT namun sampai saat ini tidak ada respon dan mengingatkan agar perawat tertib dalam menginput
		A	Evaluasi secara berkala setiap hari

3.7.76 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tikus di dapur sudah berkurang, akan tetapi masih ada tikus yang berkeliaran dan hanya melewati jebakan yang sudah dipasang oleh vendor	P	Memperbaiki struktur gedung dapur agar tidak ada celah tempat tikus masuk ke dapur
		D	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan tukang RSPHM
		S	Kontaminasi makanan akibat adanya vector yang ada di lingkungan dapur
		A	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan vendor untuk memperbarui jebakan tikus yang diletakkan di dapur
2	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan
		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan
3	Beberapa pasien ada yg membawa makanan dari luar RS	P	Pasien dan keluarga pasien mematuhi edukasi yang diberikan ahli gizi untuk tidak membawa makanan dari luar rumah sakit
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan perawat untuk mengontrol makanan yang dibawa keluarga pasien saat berkunjung
		S	Risiko kontaminasi makanan yang dapat memberikan dampak negative pada pasien (keracunan makanan, diare)
		A	Tim gizi, penyaji makanan , dan perawat selalu mengontrol makanan yang dibawa pasien dan selalu mengingatkan untuk hanya mengkonsumsi makanan yang ada di rumah sakit untuk mengihndari risiko kontaminasi makanan.
4	Buah untuk pasien sebagian besar masih mentah sehingga pemberian buah melon pada diet DM rasanya tidak manis dan masih keras	P	Pembelanjaan bahan makanan (Buah) berkualitas bagus dan siap konsumsi
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, pengadaan, dan tim pembelian dalam menentukan kualifikasi bahan makanan yang sesuai

		S	Risiko tidak tepatnya diet yang diberikan kepada pasien terkait ketersediaan buah yang sesuai dengan diet pasien
		A	Tim pengadaan, pembelian, dan tim gizi berkolaborasi dalam pembelian bahan makanan
5	Pembelian buah untuk pasien dilakukan seminggu sekali. Sehingga pada setiap minggunya ada beberapa buah yang busuk dan tidak dapat dipakai	P	Pembelian bahan makanan (Buah) berkualitas bagus dan siap konsumsi
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, pengadaan, dan tim pembelian dalam menentukan kualifikasi bahan makanan yang sesuai
		S	Risiko tidak tepatnya diet yang diberikan kepada pasien terkait ketersediaan buah yang sesuai dengan diet pasien
		A	Tim pengadaan, pembelian, dan tim gizi berkolaborasi dalam pembelian bahan makanan
6	Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian	P	Alur penyerahan alat makan harus bebas dari kontaminasi untuk menjamin higiene sanitasi alat makan
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS dalam pembuatan alur yang sesuai
		S	Risiko alat makan terkontaminasi makanan mentah sehingga tidak terjaga kebersihannya
		A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam pembuatan alur yang sesuai untuk penyerahan alat makan bersih ke tempat pemorsian

3.8
Profil SDM

3.8.1
Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	0	0	0	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0

		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0

		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	1	0	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		11	7	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0

		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0

		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0

62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			430	430	282	148	0

Keterangan :
Pada bulan Agustus akhir terdapat 1 staf SDM resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Agustus 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Juli 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 08 September 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/II/II/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025